

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE

DALVA NASCIMENTO COIMBRA

O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA:

O papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua (in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano

Porto Alegre

2026

DALVA NASCIMENTO COIMBRA

O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA:

O papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua (in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano

Dissertação de mestrado profissional apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ensino na Saúde.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga

Coorientador: Prof. Dr. André Petraglia Sassi

Linha de pesquisa: Educação em Saúde e Políticas Públicas

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Nascimento Coimbra, Dalva

O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA: O papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua (in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano / Dalva Nascimento Coimbra. -- 2026. 206 f.

Orientador: Luiz Fernando Calage Alvarenga.

Coorientador: André Petraglia Sassi.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Atenção Integral à Saúde da Mulher. 2. Medicina Indígena. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Saúde dos Povos Indígenas. 5. Tecnologias de cuidado. I. Calage Alvarenga, Luiz Fernando, orient. II. Petraglia Sassi, André, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

DALVA NASCIMENTO COIMBRA

O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA:

O papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua (in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano

Dissertação de mestrado profissional apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ensino na Saúde.

Dissertação defendida e aprovada em: 12 de março de 2026.

Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga – Orientador – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. André Petraglia Sassi – Coorientador – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. João Paulo Lima Barreto – Universidade Federal do Amazonas (PPGAS-UFAM)

Prof^a. Dr.^a Carmen Lúcia Bezerra Machado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof^a. Dr.^a Camila Giugliani – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof^a. Dr.^a Vanessa Maria Panozzo Brandão – Suplente – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. José Francisco Gontan Albiero – Suplente – Universidade Regional de Blumenau (PPGSC)

Agradeço à grande Força que rege este cosmo e tudo nos fornece.

Aos meus pais, Alfredo e Julia Nascimento Coimbra, por sempre me conectarem à natureza e a tudo o que dela emana, inclusive seus remédios, materiais e imateriais.

Agradeço, de forma especial, à grande protagonista e conhecedora da arte de curar e cuidar por meio dos conhecimentos ancestrais e tradicionais: minha mãe, Julia Nascimento Coimbra, que cuidou de si, cuidou e ainda cuida de suas filhas, netos e bisnetos por meio da arte que brota de sua ancestralidade indígena.

Às grandes protagonistas deste estudo, as mulheres indígenas, que de forma calorosa, receptiva e acolhedora concederam licença para que eu conhecesse seus conhecimentos, sabedorias e formas de estar, viver e ser neste mundo. Ao longo do estudo, inúmeras vezes agradei o privilégio de ter contato com seus saberes e com a magnitude da cosmovisão de seus povos. Vocês são exemplos de resiliência, sabedoria e amor.

Às lideranças das associações e comunidades indígenas que possibilitaram a realização deste estudo.

Ao meu filho, João Vítor, por me fazer sair da minha zona de desconforto e encontrar novos ares e novos mundos, mesmo quando eu ainda não compreendia o sentido desse movimento. Obrigada, filho, você é um presente divino para mim. Com certeza, Deus envia muitos recados por meio de você.

Ao grande coletivo feminino: minhas irmãs Dulce, Delcy, Derli, Ângela, Katia, Neide e Delma, que me ajudaram de diversas formas na construção deste trabalho; à minha prima Marinete, que me iniciou nesta jornada acadêmica da pesquisa; às minhas sobrinhas Juliane, Maria Júlia e Júlia, pelo apoio; e às minhas amigas Débora Socal, Cilene Volkmer, Júlia Galego, Rafaella Bitar, Hulda Amorim, Kattyane Nunes, Fabiane Neves, Fernanda Rodrigues, Thati Guimarães e à minha professora Cris Ayres. Todas contribuíram de maneiras distintas: acolhendo, ensinando, incentivando, cedendo espaço em casa e no trabalho, preparando café, fotografando, filmando, oferecendo caronas, acompanhando visitas aos territórios e, sobretudo, tornando este caminho mais leve e alegre.

À artista e designer do povo Dessana, Thaís Sarmento Fernandes, pela construção das ilustrações elaboradas especialmente para este trabalho, e à designer Fabiane Volkmer Grossmann, por embarcar comigo, compreender minhas abstrações e transformar ideias em imagens e arte. Agradeço pelo projeto gráfico e pela diagramação do produto técnico educativo.

Ao meu orientador, querido amigo e hoje professor, Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga. Quem diria que a vida nos proporcionaria mais esta experiência: de amigos e colegas, tornamo-nos discente e docente. Que presente tê-lo como guia nesta caminhada. Aprendi muito com você e, certamente, aprendemos ainda mais um com o outro ao longo desta jornada. Obrigada pela calma, pela tranquilidade e pela escuta.

Ao professor Dr. André Sassi, meu coorientador, cuja contribuição foi fundamental para materializar a ideia e o contexto que eu desejava construir neste estudo. Obrigada por mostrar os caminhos.

Aos colegas, amigas e amigos do PPGENSAU, especialmente Thayze, Vitória, Joana, Dani, Jéssica, Leonardo, Denise, Eliandre, Pamela e Nato, bem como aos professores, pelos tantos momentos de aprendizagem e também de descontração. Que presente estar nesta universidade.

À Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, pelo licenciamento para a realização do estudo, e a todos os colegas que contribuíram para que isso fosse possível.

Por fim, às minhas ancestrais, que semearam, regaram e fizeram crescer, por meio da transmissão das sabedorias de cura, os caminhos que hoje trilhamos. Estamos aqui porque vocês resistiram no manejo do mundo por meio de suas práticas de Bem Viver.

Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas.

Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós (Kopenawa e Albert, 2015, p. 75).

RESUMO

Manaus destaca-se como a capital brasileira com a maior população indígena em contexto urbano, com 71.713 indígenas autodeclarados, dos quais 38.127 são mulheres, pertencentes a 92 etnias e falantes de 36 línguas, distribuídas em diversos bairros. Diante desse cenário, a pesquisa abordou a saúde integral das populações indígenas em contexto urbano, com ênfase às singularidades de mulheres. O objetivo foi compreender o papel das práticas tradicionais de cuidado integral à saúde da mulher indígena na Atenção Primária à Saúde (APS) de Manaus. Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa, que utilizou diário de campo, entrevistas semiestruturadas e grupos focais com mulheres indígenas vinculadas a comunidades e associações indígenas de Manaus. A análise do material empírico resultou na construção de três eixos analíticos. O primeiro aborda as tecnologias da medicina indígena, evidenciando práticas de autoatenção que atravessam os ciclos de vida das mulheres, configurando sistemas complexos de cuidado e proteção. O segundo eixo discute as concepções de saúde-doença das mulheres indígenas, nas quais a saúde é compreendida como equilíbrio entre corpo, mente, espírito, natureza e relações sociais, com centralidade na transmissão intergeracional de saberes. Já o terceiro eixo analisa a inter-relação entre práticas tradicionais e a APS, evidenciando itinerários terapêuticos plurais, nos quais as mulheres acionam inicialmente a medicina indígena e, quando necessário, recorrem aos serviços biomédicos, produzindo arranjos situados entre diferentes racionalidades de cuidado. Os resultados indicam que, no contexto urbano, a relação entre medicina indígena e biomedicina não se dá por substituição ou oposição, mas por processos de intermedicalização, nos quais elementos biomédicos são incorporados de forma seletiva, sem o abandono das práticas indígenas que orientam a compreensão de corpo, saúde e doença. A APS emerge como espaço de encontro e tensão entre saberes, revelando limites do modelo biomédico hegemônico e, simultaneamente, possibilidades para a construção de um cuidado intercultural. Como produto técnico decorrente da pesquisa, foi elaborado um e-book voltado à Educação Permanente de profissionais da Atenção Primária à Saúde, no qual são apresentados, de forma sistematizada, a concepção indígena de saúde e doença, as práticas e tecnologias tradicionais de cuidado à saúde da mulher indígena e as possibilidades de construção de interfaces interculturais no contexto do cuidado em saúde. Conclui-se que a promoção da saúde integral das mulheres indígenas em contexto urbano exige o reconhecimento dos itinerários terapêuticos e das múltiplas territorialidades do cuidado, reafirmando a medicina indígena como um sistema vivo, central na produção da saúde, da autonomia e do bem viver, e convocando a APS a se reinventar como espaço de escuta, diálogo e articulação intercultural.

Palavras-chave: atenção integral à saúde da mulher; atenção primária em saúde; saúde dos Povos Indígenas; medicina Indígena.

ABSTRACT

Manaus stands out as the Brazilian capital with the largest Indigenous population living in an urban context, comprising 71,713 self-declared Indigenous people, of whom 38,127 are women, belonging to 92 ethnic groups and speaking 36 languages, distributed across different neighborhoods. In this context, this study addresses the integral health of Indigenous populations in urban settings, with emphasis on the singularities of Indigenous women. The objective was to understand the role of traditional practices of integral care for Indigenous women's health within Primary Health Care (PHC) in Manaus. This is an exploratory study with a qualitative approach, using field diaries, semi-structured interviews, and focus groups conducted with Indigenous women linked to communities and Indigenous associations in Manaus. Analysis of the empirical material resulted in the construction of three analytical axes. The first addresses Indigenous medicine technologies, highlighting self-care practices that span women's life cycles, constituting complex systems of care and protection. The second axis discusses Indigenous women's conceptions of health and illness, in which health is understood as a balance among body, mind, spirit, nature, and social relations, with centrality placed on the intergenerational transmission of knowledge. The third axis analyzes the interrelationship between traditional practices and PHC, revealing plural therapeutic itineraries in which women primarily mobilize Indigenous medicine and, when necessary, resort to biomedical services, producing situated arrangements between different rationalities of care. The results indicate that, in the urban context, the relationship between Indigenous medicine and biomedicine does not occur through substitution or opposition, but through processes of intermedicalization, in which biomedical elements are selectively incorporated without abandoning Indigenous practices that guide understandings of body, health, and illness. PHC emerges as a space of encounter and tension between knowledge systems, revealing the limits of the hegemonic biomedical model and, simultaneously, possibilities for constructing intercultural care. As a technical product resulting from the research, an e-book was developed aimed at the Continuing Education of Primary Health Care (PHC) professionals, in which Indigenous conceptions of health and illness, traditional practices and technologies of Indigenous women's health care, and the possibilities for building intercultural interfaces in health care are systematically presented. It is concluded that promoting the integral health of Indigenous women in urban contexts requires recognition of therapeutic itineraries and the multiple territorialities of care, reaffirming Indigenous medicine as a living system, central to the production of health, autonomy, and well-being, and calling on PHC to reinvent itself as a space of listening, dialogue, and intercultural articulation.

Keywords: comprehensive women's health care; primary health care; Indigenous People's health; indigenous medicine.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Ancestralidade materna e paterna.	14
Figura 2: Mulheres corpos-territórios de cura.	15
Figura 3: Mulheres da Associação Rede Makira-E'ta (mulheres indígenas do estado do Amazonas).	32
Figura 4: Comunidade Waikuru, na zona centro-oeste de Manaus.	33
Figura 5: Artesanatos confeccionados pelas mulheres da Comunidade indígena Waikuru, na zona.	33
Figura 6: Acesso à comunidade Wotchimaucu.	34
Figura 7: Centro Cultural criado pelos Tikunas.	34
Figura 8: Formação e planejamento da COPIME.	35
Figura 9: Especialista Kumun realizando Bahsesé (benzimento).	36
Figura 10: Visita ao Centro de Medicina Indígena.	41
Figura 11: Café realizado durante o primeiro grupo focal (café na Sementeira Casa Viva - grupo focal).	43
Figura 12: Feirinha de artesanato realizada com as artes das mulheres indígenas das comunidades.	44
Figura 13: Encontro do grupo focal na cafeteria no Largo São Sebastião em Manaus - Teatro Amazonas ao fundo.	44
Figura 14: Artista indígena realizando ilustrações durante o encontro focal.	45
Figura 15: Comunidade Waikuru – Sateré Mawé.	47
Figura 16: Comunidades indígenas em Manaus.	50
Figura 17: Grafismos e desenhos na comunidade Sateré Mawé Waikuru - Manaus.	51
Figura 18: Janela da memória, cura e proteção.	53
Figura 19: Ritual realizado por indígenas da região do Alto Solimões, na Amazônia ocidental brasileira, para proteção contra picadas de cobra.	58
Figura 20: Plantas medicinais indígenas utilizadas na saúde da mulher por uma das entrevistadas no estudo – plantas encomendadas e vindas do seu território de origem.	61
Figura 21: Prática do Bahsesé por kumun - Centro de Medicina Indígena de Manaus.	65
Figura 22: Restrição alimentar – Regras indígenas.	66
Figura 23: Mulheres - Corpos-territórios Indígenas em Resistência.	69

Figura 24: Corpo feminino indígena e símbolos de cuidado e geração da vida.	70
Figura 25: Adorno de proteção em criança indígena – pulseira de sementes.....	76
Figura 26: Corpos - Territórios Indígenas em Resistência.	87
Figura 27: A “mãe do corpo”, entre o visível e o invisível.	94
Figura 28: Encontro intergeracional de mulheres indígenas em espaço urbano.	100
Figura 29: Não somos Iracema.	106
Figura 30: Lutana Kokama abraçada à sua mãe, Raimunda, cacica geral eleita pela comunidade.	116
Figura 31: Saúde Intercultural, territórios possíveis de cuidado à saúde.	117

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Ficha do produto desenvolvido.....	127
---	-----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	18
2.1 IMPORTÂNCIA E METAS DOS SISTEMAS DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES BRASILEIRAS	18
2.2 NÃO SÓ MANAÓS: MANAUS MULTIÉTNICA – A CAPITAL MAIS INDÍGENA	20
2.3 MEDICINA INDÍGENA E PROTAGONISMO FEMININO INDÍGENA.....	23
3 METODOLOGIA	25
3.1 CAMINHOS DO CUIDADO NO TERRITÓRIO DA PESQUISA.....	25
3.1.1 Caminhos de aproximação: escuta, presença e território	25
3.1.2 Caminhos éticos: o cuidado com a pesquisa e com quem cuida	28
3.1.3 Caminhos trilhados na cidade: inserção e construção de vínculos.....	28
3.1.4 Territorialidades e protagonismo: os territórios da pesquisa.....	30
3.1.5 Corpos-territórios que cuidam: mulheres indígenas em contexto urbano	36
3.1.6 Caminhos vividos no território: experiências do trabalho de campo	40
3.1.7 Caminhos de interpretação: tecnologias de cuidado em análise.....	46
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	48
4.1 TECNOLOGIAS DE CUIDADO À SAÚDE DA MULHER INDÍGENA	53
4.1.1 Tecnologias de medicina indígena	59
4.2 CONCEPÇÕES DE SAÚDE – DOENÇA NA PERSPECTIVA DAS MULHERES INDÍGENAS	70
4.3. INTERFACE ENTRE AS PRÁTICAS INDÍGENAS DE CUIDADO E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM CONTEXTO URBANO	99
4.3.1 Reconhecimento identitário e apagamento institucional.....	99
4.3.2 Negociações de cuidado entre remédios dos brancos e remédios indígenas	108

4.3.3 Conexões territoriais e possibilidades interculturais entre Medicina Indígena e APS	117
5 PRODUTO TÉCNICO	125
5.1 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	125
5.1.1 Descrição do produto	125
5.1.2 Finalidade do produto	125
5.1.3 Público de interesse	126
5.1.4 Divulgação do produto	126
5.1.5 Projeto de pesquisa	126
5.1.6 Linha de pesquisa	126
5.1.7 Disponibilização do produto	126
5.1.8 Autoria	127
5.2 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	127
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	129
REFERÊNCIAS	132
APÊNDICE A - ROTEIRO DO DIÁRIO DE CAMPO	150
APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA	151
APÊNDICE C - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL	153
APÊNDICE D - TCLE - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA	154
APÊNDICE E - TCLE - TCLE - GRUPO FOCAL	160
APÊNDICE F - CARTA DE ANUÊNCIA DAS ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES INDÍGENAS	167
APÊNDICE G – PRODUTO <i>e-book</i>	169
ANEXO A – PARECER CEP/UFRGS	203
ANEXO B – PARECER CEP/CONEP	205

1 INTRODUÇÃO

A investigação desenvolvida nesta dissertação emerge de uma trajetória pessoal e profissional profundamente atravessada por experiências de cuidado, ancestralidade e saúde em contexto indígena. O contato com narrativas, práticas e concepções de cuidado fez emergir memórias da infância no Alto Rio Negro, onde a relação com a natureza estruturava a experiência de viver, cuidar e compreender a saúde. Desde cedo, o bem viver esteve associado à conexão com os territórios, com os rios, com as plantas medicinais e com os saberes transmitidos pelas mulheres da família. A vivência cotidiana com práticas tradicionais de cuidado, conduzidas por minha mãe, avós e bisavós, revelou sistemas complexos de proteção, cura e atenção que atravessam gerações e constituem formas legítimas de produção da saúde.

Figura 1: Ancestralidade materna e paterna.



Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2025.

Minha origem vem do município de São Gabriel da Cachoeira, filha de mãe da etnia Baré e pai caboclo com ancestralidade Baniwa (Figura 1), marcou profundamente minha compreensão sobre cuidado. A memória dos relatos dos partos assistidos por parteiras e dos resguardos tradicionais, dos banhos rituais no Rio Negro, do uso de chás, emplastros e plantas medicinais, bem como dos rituais de proteção e fortalecimento, evidencia a centralidade das mulheres (Figura 2) como protagonistas do cuidado. Essas práticas não eram compreendidas como alternativas à medicina, mas como sistemas vivos

de conhecimento e atenção integral à saúde. A infância em plena conexão com a natureza consolidou uma identidade que reverbera até hoje e que se tornou base para um dos caminhos de minha trajetória profissional, orientando a compreensão da saúde como expressão dos modos de viver das pessoas e comunidades.

Figura 2: Mulheres corpos-territórios de cura.



Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2025.

A formação em Fisioterapia iniciada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a atuação profissional em diferentes níveis de atenção à saúde ampliaram esse olhar. Assim como a inserção na Atenção Primária à Saúde (APS) em Manaus representou um ponto de inflexão na trajetória, ao revelar a potência da educação em saúde, da clínica ampliada, da humanização, da educação permanente e da territorialidade como ferramentas transformadoras. A experiência em territórios marcados por desigualdades sociais, violência urbana e diversidade cultural evidenciou que protocolos biomédicos padronizados nem sempre respondiam às necessidades locais. Nesse contexto, o contato com práticas integrativas e com a medicina indígena ampliou questionamentos sobre equidade, integralidade e reconhecimento de saberes tradicionais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro com o Centro de Medicina Indígena em Manaus e com ações de saúde voltadas à população indígena urbana revelou a insuficiência de conhecimento institucional sobre os modos indígenas de cuidar. Surgiram questionamentos sobre como ofertar cuidado baseado na equidade sem compreender as práticas do território, como promover saúde sem reconhecer os saberes das mulheres indígenas e como exercer a integralidade sem escuta qualificada. Essas indagações não eram apenas profissionais,

mas éticas e políticas, relacionadas ao reconhecimento da diversidade cultural e à necessidade de uma prática intercultural na saúde.

A relevância desta pesquisa se fortalece diante do panorama demográfico contemporâneo. Dados do Censo do IBGE (2022) indicam que o Brasil possui 1,7 milhão de indígenas, sendo o Amazonas o estado com maior população indígena. Manaus destaca-se como a capital brasileira com maior população indígena em contexto urbano, com mais de 70 mil indígenas pertencentes a dezenas de etnias. Apesar dessa presença expressiva, persistem relatos de invisibilidade, exclusão e barreiras culturais no acesso à saúde, especialmente no que se refere ao reconhecimento de saberes tradicionais e à escuta diferenciada das mulheres indígenas, protagonistas históricas do cuidado.

Embora o município mantenha ações orientadas pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, observa-se na prática cotidiana das unidades de saúde a insuficiência de profissionais qualificados para o atendimento diferenciado que a população indígena urbana demanda. Estudos apontam fragilidades na integração entre serviços, descontinuidade de cuidado e processos de invisibilização de indígenas residentes na cidade (Santos e Pereira, 2021; Cardenes, 2021), sobretudo porque a atenção institucional permanece concentrada em territórios demarcados. Assim, a responsabilidade pelo cuidado à população indígena urbana recai majoritariamente sobre a APS municipal (Pontes et al., 2015), que nem sempre dispõe de formação adequada para lidar com racionalidades diversas de cuidado.

Somam-se a esse cenário as vulnerabilidades específicas enfrentadas pelas mulheres indígenas, cuja saúde é atravessada por desigualdades de gênero, raça e território. Organismos internacionais reforçam a urgência de políticas interculturais que assegurem atenção integral e contextualizada, especialmente no cuidado materno e reprodutivo (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2008; Organização das Nações Unidas, 2008, 2023; Organização Pan-Americana da Saúde, 2019, 2023). Na organização social indígena, as mulheres ocupam lugar central na transmissão de saberes, práticas e tecnologias tradicionais de cuidado (Ramos, 2019; Miranda e Barroso, 2023). No entanto, ao se inserirem no espaço urbano, frequentemente encontram serviços que desconhecem suas concepções de saúde, seus rituais e seus itinerários terapêuticos (Albuquerque, 2020).

Apesar do crescimento das pesquisas sobre saúde indígena urbana, observa-se escassez de estudos que abordem especificamente as práticas tradicionais protagonizadas por mulheres indígenas residentes em Manaus e sua contribuição para a qualificação da

APS. Essa lacuna científica limita a compreensão das tecnologias de cuidado presentes no cotidiano e dificulta a construção de práticas interculturais mais equânimes. Persistem fragilidades na escuta diferenciada, na valorização dos saberes tradicionais, na formação profissional e na articulação entre práticas indígenas e biomédicas.

Diante desse cenário, emerge a necessidade de investigar como as tecnologias de cuidado utilizadas tradicionalmente pelas mulheres indígenas podem contribuir para qualificar a assistência integral na APS em contexto urbano. A problemática central reside na invisibilidade dessas práticas no interior dos serviços de saúde e na dificuldade de reconhecimento institucional de racionalidades distintas de cuidado. A trajetória pessoal e profissional apresentada fundamenta a escolha do tema e evidencia a urgência de compreender o papel dessas práticas no fortalecimento de uma atenção intercultural.

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é compreender o papel das práticas tradicionais de cuidado integral à saúde da mulher indígena na Atenção Primária à Saúde de Manaus. Como objetivos específicos, busca-se identificar práticas e saberes tradicionais de cuidado à saúde entre mulheres indígenas em contexto urbano; descrever a percepção das mulheres indígenas sobre o processo saúde-doença; descrever a interface entre cuidados tradicionais e serviços de APS; e construir material educativo voltado à promoção da interculturalidade, equidade e integralidade no cuidado.

Desse modo, a articulação entre introdução, referencial teórico e metodologia assegura a coerência estrutural da dissertação, integrando fundamentos conceituais e procedimentos analíticos na compreensão das práticas tradicionais de cuidado das mulheres indígenas e de suas interfaces com a APS, orientada pelos princípios da integralidade e da interculturalidade no SUS.

No capítulo seguinte, apresento o referencial teórico que sustenta a análise, abordando território, sistemas de saúde, saberes tradicionais indígenas e o protagonismo feminino, elementos indispensáveis para compreender as práticas de cuidado da mulher indígena em contexto urbano.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A seleção dos conceitos discutidos neste capítulo fundamenta-se diretamente nos objetivos da pesquisa, uma vez que compreender as práticas tradicionais de cuidado realizadas pelas mulheres indígenas em Manaus exige considerar tanto os modelos de atenção à saúde quanto as racionalidades médicas que orientam esses cuidados. Dessa forma, o referencial teórico apresentado oferece as bases conceituais necessárias para interpretar os dados produzidos em campo e analisar a interface entre saberes tradicionais e os serviços da APS.

2.1 IMPORTÂNCIA E METAS DOS SISTEMAS DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES BRASILEIRAS

Os sistemas de serviços de saúde possuem como metas principais, segundo Starfield (2002), a otimização da saúde da população, a partir do conhecimento das causas das enfermidades, do manejo das doenças e da maximização da saúde, bem como a minimização das disparidades entre subgrupos populacionais, de modo que determinados grupos não permaneçam em desvantagem sistemática no acesso aos serviços e nos níveis de saúde alcançados. No contexto amazônico, essa desigualdade se expressa de forma significativa entre os povos indígenas, exigindo a consideração de dimensões socioculturais e antropológicas tanto em territórios rurais quanto urbanos. Menéndez (2009) destaca que, ao se tratar dos modelos de atenção à saúde, há centralidade das atividades biomédicas em seus diferentes níveis de atenção; contudo, em contextos multiétnicos, torna-se indispensável considerar a autoatenção, entendida como o conjunto de atividades voltadas à prevenção, tratamento, controle, alívio e cura dos adoecimentos, organizadas a partir de saberes, práticas e representações que operam por meio de curadores, sujeitos e grupos leigos. Nessa perspectiva, os conceitos de forma, saber e modelo referem-se a diferentes níveis de abstração, complementares entre si, permitindo compreender estratégias diferenciadas no manejo da atenção à saúde.

No âmbito da política de saúde indígena brasileira, Langdon e Garnelo (2017) afirmam que o cuidado diferenciado se fundamenta na tensão entre a universalização abstrata dos direitos e a diversidade de demandas, desejos e necessidades expressas por indivíduos e grupos sociais. Pedrana et al. (2018), em consonância com documentos oficiais (Brasil, 2018, 2023), destacam a necessidade de estratégias interculturais

operacionais, como a inclusão de especialistas tradicionais nos serviços de saúde indígena e a formação intercultural de profissionais não indígenas. Pontes et al. (2015), a partir da análise da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), identificam três princípios estruturantes da atenção diferenciada no subsistema de saúde indígena: a adequação de tecnologias, a qualificação dos profissionais para o contexto intercultural e a participação indígena, alinhados à perspectiva antropológica de Menéndez (2009).

No campo da saúde coletiva, o conceito de racionalidades médicas, formulado por Luz, permitiu o estudo de medicinas complexas compreendidas como sistemas dotados de razão médica e eficácia terapêutica própria (Tesser e Luz, 2008). A Organização Mundial da Saúde define a medicina tradicional como um conjunto de práticas, enfoques, conhecimentos e crenças sanitárias diversas, que incluem medicinas baseadas em plantas, animais e minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios, utilizados isoladamente ou em combinação para manter o bem-estar, diagnosticar, tratar e prevenir enfermidades (Ferreira, 2013). Nesse contexto, Mabel (1997) ressalta que a medicina indígena constitui a mais antiga e duradoura forma de medicina tradicional na América Latina, permanecendo indissociável das formas de vida, das cosmovisões e dos sistemas de valor e significação das culturas locais. Conforme Luz (2012), o conceito de racionalidades médicas possibilita o estudo comparativo de sistemas de cuidados não eruditos, convencionais ou não convencionais, incluindo aqueles presentes nas medicinas tradicionais indígenas.

Neste trabalho, utilizam-se os conceitos de Biomedicina e Medicina Indígena com base em Madel Luz e João Paulo Lima Barreto. A Biomedicina, segundo Luz (1997, 2012), fundamenta-se em bases anatômicas, fisiológicas e experimentais, organizando o saber médico a partir da observação e mensuração do corpo biológico. A Medicina Indígena, conforme Barreto (2025) e Schweickardt e Barreto (2023), constitui um sistema complexo de conhecimentos e práticas próprias, que articulam dimensões biológicas, espirituais, sociais e ambientais. Essa concepção foi reafirmada por André Baniwa durante a 3ª Conferência Mundial de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas, ao definir a medicina indígena como conhecimentos sistematizados de tecnologias de cuidado à saúde utilizados pelos povos indígenas desde a criação do mundo (Baniwa, 2025).

O reconhecimento dessas epistemologias e a valorização do protagonismo indígena nas tomadas de decisão alinham-se aos princípios da integralidade no Sistema

Único de Saúde, ampliando o acesso a serviços adaptados às necessidades, à cultura e aos direitos dos povos indígenas (Brasil, 2018, 2019, 2023, 2024). A integralidade, princípio normativo do SUS, orienta a prestação de uma atenção qualitativa que considere as múltiplas dimensões e complexidades dos problemas de saúde, em consonância com as racionalidades médicas (Tesser e Luz, 2008). No campo da saúde da mulher, Coelho et al. (2009) destacam que a integralidade exige acolhimento e escuta sensível às demandas femininas, com práticas que assegurem o acesso conforme os ciclos de vida e os contextos sociais, considerando gênero, raça/cor, classe e geração nos processos de saúde e adoecimento.

Nesse sentido, é fundamental situar o contexto urbano no qual essas práticas de cuidado se produzem, destacando Manaus como território empírico central da pesquisa. Reconhecida como a capital brasileira com maior população indígena em contexto urbano e marcada por intensa diversidade étnica e linguística, a cidade evidencia os desafios e as possibilidades de articulação entre medicina indígena, biomedicina e Atenção Primária à Saúde.

2.2 NÃO SÓ MANAÓS: MANAUS MULTIÉTNICA – A CAPITAL MAIS INDÍGENA

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2025, o Brasil conta com 1,69 milhão de pessoas indígenas, distribuídas em 4.833 municípios, o que corresponde a 0,83% da população total do país, um aumento de 88,96% nessa população entre 2010 e 2022. A Região Norte concentra a maior parte da população indígena, representando 44,47% do total nacional. As maiores quantidades de localidades indígenas fora de terras indígenas, total de 1.078, encontram-se no estado do Amazonas. Em 2022, 53,97% da população indígena, o equivalente a 914.746 pessoas, vive em áreas urbanas. Nos municípios amazonenses, que abrigam 28,44% da população indígena do país, verificou-se uma redução proporcional da população indígena residente em áreas rurais. Observa-se uma predominância feminina, com cem mulheres para cada 89,37 homens da população indígena em áreas urbanas fora de terras indígenas (Brasil, 2024).

Segundo a coordenadora geral da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno - COPIME (Viana, 2023), diversos são os motivos que contribuem para esse aumento, o primeiro deles é que os principais serviços estão centralizados nas cidades, como saúde, educação e oportunidade de trabalho. Um levantamento preliminar das

próprias organizações apontava o número de 35 mil indígenas e os dados do Censo do IBGE (2022) apresentam 71.713 indígenas autodeclarados vivendo na cidade de Manaus. Porém, as políticas públicas ainda não refletem essa realidade, ainda a invisibilidade e a falta de questionamentos direcionados às populações indígenas contribuem para a subnotificação (Disse, 2023).

A capital amazonense demonstra importante segregação socioespacial urbana, com marcantes desigualdades sociais como acesso limitado a recursos, bens e serviços, como bairros com déficit de saneamento e lacunas na assistência à saúde (Pereira, 2021). Segundo dados sobre saneamento básico do IBGE (2022), evidenciados por Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, observa-se que, mesmo em áreas urbanas e não apenas em regiões remotas, a população indígena tem menor acesso aos serviços de saneamento em comparação com o conjunto da população do país. De acordo com o levantamento, 13,3% da população indígena residente em áreas urbanas e fora de terras indígenas possui acesso à água em condições de maior precariedade, enquanto a média da população urbana é de 2,72% (Brasil, 2024). Em relação ao esgotamento sanitário, cerca de 83,05% da população urbana brasileira reside em domicílios conectados à rede geral ou pluvial de esgoto, ou com fossa séptica ou fossa filtro. No entanto, entre a população indígena em áreas urbanas e fora das terras indígenas, apenas 59,24% têm acesso a esse tipo de saneamento básico em 2022 (Brasil, 2024). Esse cenário, como afirma Caiaffa et al. (2021), gera exclusão e consequências desastrosas na qualidade de vida e saúde de grupos considerados vulneráveis, dentre eles a população indígena. Há uma interrupção do direito à cidade e da oferta de seus benefícios em relação ao bem viver.

O Censo ainda destaca Manaus como a capital mais indígena. Para Kern (2020), o que nos chama especialmente a atenção é a diversidade étnica nesta metrópole. Os dados do Censo 2022 apresentam 71.713 indígenas autodeclarados, sendo 38.127 do sexo feminino, representando 92 etnias, que falam 36 diferentes línguas distribuídos em 63 bairros, sendo elas: Munduruku, Tikuna, Sateré-Mawé, Desana, Tukano, Miranha, Kaixana, Baré, Kokama, Apurinã, Tuyuka, Piratapuya, Kamaiura, Kambeba, Mura, Maraguá, Baniwa, Macuxi, Wanano, Tariano, Bará, Arara [do Aripuanã], Karapãna, Barasana, Anambé, Deni, Kanamari, Katukina, Kubeo, Kulina, Marubo, Paumari, Arara do Pará e Manchineri. No que se refere à língua, indicam 19 línguas faladas: Munduruku, Tikuna, Mawé, Mura, Desano, Tukano, Baré, Língua geral amazônica (Nhengatú),

Piratapuya, Wanano, Apurinã, Tariano, Kaixana, Kokama, Karapãna, Tuyuka, Barasana, Baniwa e Kambeba.

Além disso, o mapeamento realizado em comunidade refugiada indígena em Manaus em 2023 pela Agência da ONU para Refugiados - ACNUR, registrou 478 indígenas venezuelanos refugiados, em sua maioria das etnias Warao e Pemón. A maioria mora em bairros periféricos, no entanto, já ocupa áreas que tradicionalmente não eram habitadas por essa população, indicando crescente dispersão pela zona urbana (ACNUR, 2023).

Segundo Kern (2020), esses resultados demonstram que a presença indígena na cidade não é residual, temporária ou concentrada em alguns pontos específicos. Para este autor, o que acontece é o contrário, é significativa e representativa a dispersão das etnias pela maioria dos bairros de Manaus. Relacionado a isso, a concentração se mantém em bairros periféricos, onde há precariedade das condições de vida, geralmente ocupam áreas irregulares, como igarapés poluídos, em que não há serviços de saneamento básico, além da insuficiência no atendimento em educação e saúde (Kern, 2020).

As organizações indígenas, segundo Garnelo e Sampaio (2003), são formas coletivas e institucionalizadas de representação política dos povos indígenas, voltadas à defesa de direitos, ao fortalecimento do protagonismo étnico e à afirmação da diferença. As autoras afirmam que, por meio do controle social, essas organizações exercem uma forma de atividade política, participando e influenciando a formulação, a gestão e a avaliação das políticas públicas, especialmente no campo da saúde, ao disputar espaços de decisão junto ao Estado.

Sobre o processo de mobilização social e política, Souza (2021) destaca a expansão, em meados da década de 1990, protagonizada pelas lideranças indígenas residentes no estado do Amazonas e na capital amazonense. O fortalecimento desse movimento cresceu a partir das ações da Coordenação das Organizações da Amazônia Brasileira (COIAB) e por organizações como a Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro (AMARN), Associação Indígena das Mulheres Sateré-Mawé (AMISM), o Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) e contou com o apoio de instituições de causas humanitárias, ONGs, entidades governamentais. A partir de 2000, a ação conjunta das lideranças indígenas e apoiadores resultou na constituição de importantes organizações indígenas, dentre elas, a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME).

2.3 MEDICINA INDÍGENA E PROTAGONISMO FEMININO INDÍGENA

[E]la é mais corajosa do que os homens em muitos momentos históricos (Fontes, 2020, p. 184).

A afirmação acima evidencia o protagonismo feminino indígena, destacando a coragem, a resiliência e a liderança das mulheres em suas comunidades. As mulheres indígenas desempenham papéis centrais na preservação dos saberes tradicionais, na transmissão de conhecimentos ancestrais e na organização comunitária, assumindo responsabilidades que desafiam estereótipos de gênero e estruturas históricas de poder, contribuindo para a construção da identidade e para a defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas (Miranda, 2020; Miranda e Barroso, 2023).

Dentre as diversas pautas mobilizadas pelas mulheres indígenas, a medicina tradicional ocupa lugar central na luta pela efetivação de direitos diferenciados, especialmente no que se refere à saúde indígena. Em contextos urbanos como Manaus, mulheres indígenas migrantes enfrentam múltiplas vulnerabilidades sociais, ao mesmo tempo em que mantêm papel fundamental na preservação da cultura indígena e dos saberes das Medicinas Indígenas. Castro e Carneiro (2023) destacam o protagonismo dessas mulheres na defesa de seus territórios e da saúde de suas comunidades, por meio da articulação de campanhas, barreiras sanitárias e da valorização dos saberes tradicionais, processos sustentados pelo reconhecimento do pluralismo cultural, das vozes indígenas e de seus saberes como fundamentos para a resistência histórica e a continuidade da vida coletiva (Marchinery e Almeida Silva, 2019).

Esse protagonismo se expressa também nos processos migratórios vivenciados por povos indígenas em contextos urbanos. Santos e Coimbra (1994) analisam que a estrutura demográfica, as condições de saúde e nutrição, a base de subsistência e os padrões de mobilidade são modificados em um processo migratório, especialmente à medida que os grupos indígenas passam a interagir mais intensamente nos complexos sistemas socioeconômicos locais, ou seja, quando se adentram no mundo dos brancos (Santos e Coimbra, 1994). Nesse contexto, a busca pelos cuidados e práticas coloca a mulher indígena como principal articuladora do bem-estar e do conforto familiar, muitas vezes de forma solitária, com seus filhos, sem a ajuda do companheiro.

Esse protagonismo foi reafirmado durante a I Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, realizada em agosto de 2025, que resultou na Carta Pela Vida e Pelos Corpos-Territórios, estruturada em cinco eixos: Direito e Gestão Territorial; Emergência

Climática, Políticas Públicas e Violência de Gênero; Saúde Indígena; Educação e Transmissão de Saberes Ancestrais para o Bem Viver. No eixo da saúde indígena, destacam-se propostas relacionadas à criação de equipes interculturais, casas de saúde, casas de parteiras e da mulher, combate à violência obstétrica, valorização das práticas tradicionais de parto e reconhecimento oficial de parteiras, pajés e especialistas indígenas, além de programas voltados à saúde mental. No eixo da educação, propõe-se a inclusão dos saberes das mulheres indígenas nos currículos, a formação técnica e política de mulheres indígenas, a contratação de professoras indígenas e a valorização das anciãs nos processos formativos (Anmiga, 2025).

Os elementos apresentados neste referencial teórico fundamentam a compreensão do protagonismo das mulheres indígenas na produção do cuidado e orientam a escolha metodológica deste estudo, que privilegia a abordagem qualitativa e a inserção no território para apreender significados, práticas e racionalidades do cuidado tradicional indígena em sua interface com a Atenção Primária à Saúde.

Nesse sentido, este referencial teórico não se limita à descrição de conceitos, mas constitui a base analítica que orientará a interpretação dos dados produzidos, especialmente no que se refere à interface entre as práticas tradicionais de cuidado a partir de suas dimensões culturais, territoriais e políticas, e o diálogo com o cuidado ofertado na Atenção Primária.

3 METODOLOGIA

3.1 CAMINHOS DO CUIDADO NO TERRITÓRIO DA PESQUISA

Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e de campo. A abordagem qualitativa permite trabalhar com significados, crenças, valores, atitudes e modos de vida (Minayo e Miranda, 2002), aspectos fundamentais para compreender as práticas tradicionais de cuidado das mulheres indígenas em contexto urbano. Esses fenômenos não são enumeráveis ou quantificáveis, concepção reforçada por Godoy, citado por Cardoso et al. (2021). A escolha metodológica mostra-se coerente com o objeto do estudo, uma vez que compreender práticas tradicionais, racionalidades e sentidos exige métodos que valorizem narrativas e experiências das participantes.

As atividades propostas neste estudo foram desenvolvidas em associações e comunidades indígenas da cidade de Manaus, conforme o cronograma preestabelecido, com mulheres indígenas maiores de dezoito anos que utilizam práticas tradicionais no cuidado à saúde feminina ou que são reconhecidas como referência em suas comunidades sobre o tema, além de fazerem uso dos serviços da Atenção Primária à Saúde. Participaram doze mulheres pertencentes às etnias Sateré-Mawé, Dessana, Apurinã, Tikuna, Baniwa, Kokama e Tukano, com idades entre 20 e 69 anos. As participantes foram identificadas por denominações simbólicas escolhidas pela pesquisadora, com o objetivo de preservar o sigilo e respeitar a identidade cultural.

A partir desse desenho metodológico, os caminhos da pesquisa foram construídos progressivamente por meio da aproximação com os territórios, das estratégias de produção de dados e da inserção da pesquisadora no campo.

3.1.1 Caminhos de aproximação: escuta, presença e território

Esses caminhos de aproximação foram fundamentais para viabilizar a inserção da pesquisadora nos territórios e orientar as estratégias de produção de dados adotadas no estudo.

A aproximação com as comunidades ocorreu a partir de contatos com lideranças indígenas durante o 1º Encontro de Cacicas organizado pela Rede Makira-E'ta, momento em que se estabeleceram vínculos de confiança e foram apresentados os objetivos do

estudo. Posteriormente, realizaram-se visitas presenciais às associações e comunidades que aceitaram participar, com assinatura das cartas de anuência pelas lideranças (Apêndice VI). Em todos os encontros, observou-se a tomada de decisões de forma coletiva, característica da organização social indígena.

As estratégias de coleta de dados incluíram diário de campo, entrevistas semiestruturadas e grupos focais. Os encontros foram realizados com as participantes que aceitaram o convite, seguindo etapas que se iniciaram com a inserção da pesquisadora no campo, envolvendo a observação das dinâmicas, práticas e inter-relações nos diferentes cenários da pesquisa, com o objetivo de aproximação com as pessoas e compreensão do funcionamento de cada local.

A observação integrou o processo de inserção em campo e de construção de vínculos, compreendida como o ato de perceber atividades e inter-relações no cenário pesquisado (Angrosino, 2009), não se constituindo como estratégia autônoma de coleta de dados. Esse processo foi orientado pelos elementos descritos por Gil (2021), considerando espaço, atores, atividades, objetos, eventos, tempos e sentimentos, e subsidiou os registros sistematizados no diário de campo. As observações ocorreram nos espaços onde o projeto foi apresentado e onde se deu a coleta de assinaturas das lideranças para as cartas de anuência, os quais serão detalhados adiante neste texto.

O diário de campo constituiu-se como instrumento central de registro, conforme Araújo et al. (2013), no qual foram anotadas percepções, interações, contextos e informações relacionadas ao tema, logo após os encontros (Apêndice I). Essa etapa possibilitou apreender aspectos populacionais, costumes, crenças, modos de vida, formas de organização e contribuiu para a construção de vínculos com as participantes do estudo.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices II e IV). Essa estratégia corresponde a uma conversa orientada para um objetivo definido pelo pesquisador, sendo composta por um roteiro previamente estabelecido, com questionamentos básicos relacionados ao tema e ao enfoque da pesquisa, permitindo maior flexibilidade, profundidade e abrangência das informações coletadas (Manzini, 2003, 2004). No estudo, foi utilizado um roteiro subdividido em quatro partes: identificação; concepção geral sobre saúde e serviços; conhecimentos tradicionais em saúde; e práticas específicas relacionadas aos ciclos da mulher. As entrevistas ocorreram nas comunidades, associações ou residências das participantes, conforme disponibilidade, foram gravadas e posteriormente transcritas pela pesquisadora. Participaram doze mulheres de diferentes etnias: Tukano, Dessana,

Baniwa, Apurinã, Sateré-Mawé, Kokama e Tikuna, caracterizadas em seção específica. As entrevistas tiveram duração entre 30 minutos e 1 hora e foram gravadas com gravador e aplicativo de gravação em telefone celular, sendo integralmente transcritas pela pesquisadora.

Na sequência, as mulheres participantes foram convidadas a integrar os grupos focais. De acordo com Lervolino e Pelicioni (2001), os grupos focais estimulam a interação e a produção conjunta de sentidos, favorecendo a identificação de percepções sobre práticas de cuidado. Essa estratégia é amplamente utilizada em pesquisas qualitativas por possibilitar a expressão de opiniões, percepções e atitudes a partir da interação entre os participantes, permitindo a compreensão de diferentes pontos de vista sobre práticas e experiências compartilhadas (Lervolino, 2001). De acordo com Krueger (1991), conforme discutido por Alvarenga (2012), os grupos devem ser compostos por cinco a dez participantes, que compartilhem vínculos sociais capazes de situá-los no contexto investigado, sem relações pessoais muito próximas.

Os grupos focais ocorreram em espaços escolhidos pelas próprias mulheres, que optaram por locais fora das comunidades, compreendendo os encontros também como momentos de socialização. Foram realizados dois grupos focais com dez das doze mulheres participantes, duas não compareceram por questões de saúde e viagem, com o objetivo de aprofundar os temas da pesquisa. O primeiro encontro ocorreu na Sementeira Casa Viva, concomitante à 1ª Feirinha de Artesanato de Mulheres Indígenas de Manaus, contando com a participação de oito mulheres, com idades entre 20 e 69 anos. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico (Apêndice V). Nesse encontro, abordaram-se a assistência à saúde e os cuidados tradicionais utilizados de acordo com as culturas das participantes (Apêndice III). A pesquisadora contou com o apoio de profissionais da saúde, incluindo fisioterapeuta atuante na saúde indígena, nutricionista responsável pelo espaço e psicóloga com atuação na área. A dinâmica incluiu a leitura de um trecho da obra *Meu Avô que Disse*, de Daniel Munduruku, utilizada como estímulo à rememoração das práticas tradicionais, sendo evidenciada, nas falas, a centralidade da medicina indígena como primeira forma de cuidado.

O segundo grupo focal contou com a participação de dez mulheres das etnias Sateré-Mawé, Baniwa-Tukano, Tikuna, Apurinã e Dessana e foi realizado em uma cafeteria portuguesa localizada no Largo São Sebastião, espaço de forte simbolismo histórico e cultural na cidade de Manaus, onde se situa o Teatro Amazonas. A escolha do

local foi intencional, por tratar-se de um espaço construído no contexto da colonização e tradicionalmente associado a encontros sociais e atividades culturais. Realizar o grupo focal nesse território historicamente indígena constituiu-se como um ato simbólico de visibilidade e resistência, em consonância com os objetivos do estudo. O encontro ocorreu em ambiente acolhedor, em torno de um café compartilhado, no qual foram discutidas as relações entre práticas tradicionais, Atenção Primária à Saúde, concepções de saúde-doença e as interferências do contexto urbano. A pesquisadora contou com o apoio de fisioterapeuta atuante na saúde indígena.

A partir do conjunto de informações produzidas ao longo da pesquisa, os elementos empíricos foram organizados da seguinte forma: a descrição das visitas de campo, a caracterização do cenário da pesquisa e a identificação das participantes, bem como o processo de aproximação com as mulheres do estudo. Através dessa aproximação inicial e da produção sistemática de registros, permitiu-se avançar para os caminhos trilhados na cidade, marcados pela inserção em campo e pela construção de vínculos.

3.1.2 Caminhos éticos: o cuidado com a pesquisa e com quem cuida

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, sob o parecer nº (Anexo A) e pela Comissão Nacional de Ética em pesquisa- CONEP, sob o parecer nº 7.754.147 e CAAE 85623324.0.0000.5347 (Anexo B), em conformidade com a Resolução CNS nº 510/2016, Resolução CNS nº 466/2012, Resolução CNS nº 304/2000 e a Norma Operacional CNS nº 001/2013.

3.1.3 Caminhos trilhados na cidade: inserção e construção de vínculos

Os caminhos desenvolvidos nesta pesquisa foram construídos a partir das vivências no território e das relações estabelecidas com mulheres indígenas residentes na cidade de Manaus, configurando um percurso fundamental para a criação de um ambiente de confiança e diálogo entre a pesquisadora e as participantes. A opção pela abordagem qualitativa mostrou-se coerente com o objeto do estudo, uma vez que a compreensão de práticas tradicionais, significados e racionalidades exige métodos que valorizem narrativas, experiências e sentidos atribuídos pelas mulheres indígenas. Essa escolha

mantém vínculo direto com a Atenção Primária à Saúde, campo no qual se desenvolvem as práticas de cuidado investigadas e onde se materializam as tensões entre medicina indígena e biomedicina. Ainda antes da elaboração formal do projeto, as vivências profissionais da pesquisadora e os contatos estabelecidos com comunidades e associações indígenas despertaram questionamentos que orientaram a definição dos objetivos e das estratégias de investigação.

A abordagem metodológica foi estruturada de modo a garantir coerência direta entre os objetivos do estudo e as técnicas de produção de dados selecionadas, considerando que cada técnica respondeu a aspectos específicos da investigação. Para o objetivo de identificar práticas e saberes tradicionais de cuidado, utilizaram-se o diário de campo, as entrevistas semiestruturadas e o grupo focal, possibilitando captar narrativas, práticas cotidianas e tecnologias de cuidado mobilizadas pelas mulheres. Para a descrição das percepções sobre o processo saúde-doença, priorizaram-se as entrevistas semiestruturadas, por favorecerem a expressão das concepções próprias de cada participante. A compreensão da interface entre os cuidados tradicionais e os serviços da Atenção Primária à Saúde integrou informações oriundas do diário de campo, especialmente durante as vivências nas comunidades e associações, e dos relatos das mulheres sobre suas experiências de cuidado no SUS, captados nas entrevistas e grupos focais. O objetivo referente à elaboração do material educativo baseou-se na análise temática das informações produzidas, resultando na síntese dos achados considerados mais relevantes para subsidiar ações de educação permanente em saúde.

O processo de aproximação com as participantes teve como marco inicial o 1º Encontro de Cacicas, organizado pela Rede Makira-E'ta – Organização das Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, espaço em que se evidenciaram a organização, o protagonismo e a força política das mulheres indígenas. Nesse evento ocorreram os primeiros contatos com lideranças de comunidades e associações indígenas de Manaus e Entorno, bem como indicações de outros contatos para a apresentação formal do projeto de pesquisa. A partir desse momento, os laços iniciais de confiança foram sendo construídos de forma gradual, por meio do diálogo e da presença constante nos espaços coletivos.

Conforme afirmam Veras et al. (2025), o diálogo intercultural exige uma postura de escuta atenta e respeito aos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, a inserção no território foi sendo construída de forma progressiva, conversando, ouvindo e compreendendo as participantes, com atenção silenciosa e respeito aos modos de vida dos povos indígenas

residentes na cidade de Manaus. Esse processo foi atravessado por reflexões e descobertas, revelando realidades marcadas por resistência, resiliência e profundidade cultural, ao mesmo tempo em que tensionou certezas oriundas da formação biomédica da pesquisadora, frequentemente orientada por perspectivas parciais e excludentes.

As atividades previstas no estudo foram realizadas em associações e comunidades indígenas da cidade de Manaus, conforme o cronograma estabelecido. Após o encontro inicial, foram realizados novos contatos, agendadas visitas e apresentadas as propostas do projeto às comunidades e associações indicadas. Nesses encontros participativos, o projeto foi apresentado coletivamente e, mediante aceite para participação no estudo, solicitou-se a assinatura da carta de anuência pelas lideranças responsáveis. Algumas tentativas de contato não obtiveram retorno e, por esse motivo, foram excluídas do estudo. Permaneceram, assim, cinco associações e comunidades que aceitaram a visita prévia, a apresentação do projeto e a formalização da participação por meio da carta de anuência.

As associações e comunidades participantes do estudo incluíram a Associação Comunidade Indígena Waikiru, a Associação Rede de Mulheres Indígenas Makira-E'ta, a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME), o Centro de Medicina Indígena Bahserikowi da Associação Indígena Yepa Mahsã e a Comunidade Indígena Wotchimaucu. A escolha desses territórios considerou o retorno aos contatos realizados, a aceitação da proposta de pesquisa e a relevância dessas organizações e comunidades na defesa da cultura, dos direitos e da visibilidade indígena na cidade de Manaus, bem como na oferta de práticas de cuidado baseadas na medicina indígena.

Desse modo, a metodologia adotada permitiu compreender as práticas tradicionais de cuidado presentes no cotidiano das mulheres indígenas em Manaus e integrar essas experiências na construção do material educativo proposto, contribuindo para ações de educação permanente e para o fortalecimento da interculturalidade na Atenção Primária à Saúde. Esses caminhos trilhados na cidade conduziram à delimitação dos territórios específicos da pesquisa, apresentados a seguir.

3.1.4 Territorialidades e protagonismo: os territórios da pesquisa

Durante muitos anos, um grande número de indígenas viveu distanciado dos grandes centros pela necessidade de proteção e refúgio em áreas rurais, visto que em suas

terras foram erguidas as cidades, mas esse cenário mudou, e hoje percebe-se um número cada vez maior dessas populações nos centros urbanos.

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Manaus, área que concentra expressiva população indígena distribuída em espaços urbanos e rurais, com características culturais, sociais, econômicas e históricas diversificadas. Segundo dados do último censo do IBGE, Manaus reúne grupos multiétnicos com significativa diversidade cultural, totalizando 186 etnias e 99 línguas distintas, sendo considerada atualmente a capital mais indígena do país (Brasil, 2024). A presença indígena na cidade se constrói a partir de fluxos dinâmicos de idas e vindas entre territórios da Amazônia rural e urbana, conforme descrito em diferentes pesquisas que analisam comunidades organizadas nos limites da Manaus urbana e rural (Silva, 1999; Almeida et al., 2009; Teixeira, 2009; Pereira, 2018, 2021; Cardenes e Montardo, 2020; Souza, 2021; Santos et al., 2023; Tobias et al., 2023).

A migração para as cidades próximas das terras indígenas dá-se no âmbito do processo de urbanização no Brasil e a capital do Amazonas, Manaus, se destaca como o destino preferido dos migrantes interioranos desse estado, quando se considera o conjunto da população tanto indígena quanto não-indígena (Teixeira et al., 2009). O processo de migração dos indígenas para a cidade envolve desde perda territorial por falta de demarcação a melhores oportunidades de educação, emprego e atendimento de saúde (Silva, 1999; Almeida, 2009; Albuquerque, 2020; Santos et al., 2025).

As associações e comunidades indígenas participantes do estudo foram aquelas que retornaram aos contatos realizados de forma telefônica e presencial, especialmente durante evento de mulheres indígenas ocorrido em Manaus, e que aceitaram a visita prévia para apresentação do projeto de pesquisa e a coleta da assinatura da carta de anuência por suas lideranças. A escolha considerou, ainda, a relevância de associações lideradas por mulheres indígenas, como a Associação Comunidade Indígena Waikiru, a Associação Rede de Mulheres Indígenas Makira-E'ta e a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME), constituídas por mulheres atuantes na defesa de sua cultura, de seus direitos e da visibilidade indígena na cidade de Manaus. Também integrou o estudo o Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, da Associação Indígena Yepa Mahsã, por se tratar de um espaço de referência na oferta de cuidados baseados na medicina indígena, bem como a Comunidade Indígena Wotchimaucu, reconhecida por seu percurso histórico e por sua organização coletiva na cidade.

Associação Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas. Makira-E'ta (Figura 3), fundada em junho de 2017, localizada na capital do estado, possui como

objetivo a representação, ao nível estadual, de organizações, movimentos, cooperativas e associações de mulheres indígenas. Seus projetos possuem temáticas de economia sustentável, políticas públicas, assuntos geracionais, meio ambiente, soberania alimentar e fortalecimento cultural.

Figura 3: Mulheres da associação rede Makira-E'ta (mulheres indígenas do estado do Amazonas).



Fonte: Rede Makira-E'ta, 2024.

Associação Comunidade Indígena Waikiru (Figura 4), formada por indígenas do povo Sateré-Mawé, fundada na década de 1970, no bairro Redenção, após a migração de famílias oriundas do município de Maués para a capital amazonense em busca de tratamento de saúde. Atualmente, a comunidade abriga cerca de 75 pessoas e se localiza em área urbana marcada por becos, escadarias e residências, no limite entre o bairro da Redenção e os conjuntos Santos Dumont e Hileia (Gazel, 2019). As mulheres da comunidade organizam grupos de confecção de artesanatos, atividade importante para a subsistência e para a manutenção das práticas culturais (Figura 5).

Figura 4: Comunidade Waikuru, na zona centro-oeste de Manaus.



Fonte: Araújo, 2023.

Figura 5: Artesanatos confeccionados pelas mulheres da Comunidade indígena Waikuru, na zona.



Fonte: Araújo, 2023.

A Comunidade Indígena Wotchimaucu (Figura 6) foi criada no ano 2000, no bairro Cidade de Deus, a partir da migração de famílias oriundas do município de Benjamin Constant, interior do Amazonas, pertencentes à Terra Indígena Tikuna. O deslocamento para a cidade ocorreu a partir da década de 1980, motivado por demandas relacionadas a estudo, saúde e trabalho. Na comunidade, foi criado um centro cultural (Figura 7), com o objetivo de incentivar a produção de artesanatos e a organização de grupos culturais de música (Santos et al., 2023). Ao longo do tempo, a associação passou a integrar indígenas Tikuna residentes em outros bairros da cidade, alcançando atualmente algumas centenas de associados (Cardenes e Montardo, 2020).

A Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME), criada em 2011, reúne 47 organizações indígenas situadas em Manaus e outras 12 nos municípios do entorno, constituindo-se como uma organização composta e liderada por indígenas. Entre seus eixos prioritários destaca-se a defesa da saúde diferenciada aos povos indígenas, com ações voltadas à cura de doentes por meio de métodos medicinais próprios, que envolvem misticismo, religião e fé. Além da saúde, a COPIME (Figura 8) atua nas áreas de educação, economia, direitos territoriais e moradia, mantendo o direito à cidade como pauta central de suas reivindicações (Oliveira, 2023). Nesse processo de organização e fortalecimento, a coordenação tem contribuído de forma significativa para dar visibilidade à realidade dos povos indígenas no contexto urbano, provocando reflexões sobre territorialidade e afirmando o direito à cidade como lugar de pertencimento, com a defesa da identidade dos povos indígenas e a garantia de seus direitos constitucionais (COPIME, 2024).

Figura 8: Formação e planejamento da COPIME.



Fonte: COPIMEOFICIAL, 2026.

O Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, da Associação Indígena Yepa Mahsã, foi criado em 2009 e localiza-se no centro da cidade de Manaus (Cardenes e Montardo, 2021). Esse espaço tem como objetivo disponibilizar atenção à saúde a partir de práticas indígenas, com a atuação de especialistas e o uso de plantas medicinais, além de difundir a cultura, crenças e práticas tradicionais especializadas (Barreto, 2022). O centro é composto por uma família de especialistas, como Yaiwa e kumuã (Figura 9),

reconhecidos como fundadores do primeiro Centro de Medicina Indígena Bahserikowi do Amazonas, constituindo-se como referência para outros povos indígenas na criação de seus próprios espaços de cuidado e cura (Schweickardt e Barreto, 2023).

Figura 9: Especialista Kumun realizando Bahsesé (benzimento).



Fonte: Centro de Medicina Indígena, 2021.

3.1.5 Corpos-territórios que cuidam: mulheres indígenas em contexto urbano

A inserção nesses territórios possibilitou a aproximação com mulheres indígenas cujas trajetórias, práticas de cuidado e experiências em contexto urbano constituem o eixo principal desta pesquisa. As participantes são mulheres indígenas maiores de dezoito anos, pertencentes às associações e comunidades descritas anteriormente, que utilizam práticas indígenas no cuidado à saúde feminina ou são reconhecidas como referência em suas comunidades sobre o tema, bem como fazem uso dos serviços da Atenção Primária à Saúde na cidade de Manaus. Considerando esse perfil, participaram do estudo doze mulheres das seguintes etnias: três Sateré-Mawé, duas Dessana, duas Apurinã, duas Tikuna, uma Baniwa, uma Kokama e uma Tukano, com idades entre 20 e 69 anos, todas residentes no município de Manaus.

Durante o processo de coleta de dados, observou-se que o nome possui papel central na construção da identidade das participantes. Todas utilizavam dois nomes: um

voltado ao convívio na sociedade não indígena e outro de origem cultural, portador de significados simbólicos vinculados à ancestralidade e ao modo de vida de seu povo, aspecto evidenciado tanto nas entrevistas semiestruturadas quanto nos grupos focais (Hugh-Jones, 2002). Em algumas etnias, o processo de nomeação ocorre logo após o nascimento e é compreendido como um ato de transformação espiritual que fortalece a alma da criança, conferindo vitalidade e proteção. Entre os povos Tukano, há três tipos de nomes pessoais: nomes de espírito, apelidos e nomes de estrangeiro, o que evidencia que as práticas de nomeação são culturalmente específicas a cada povo (Hugh-Jones, 2002).

No contexto indígena, a noção de corpo-território expressa a articulação entre a defesa dos corpos femininos e a defesa dos territórios, reafirmando a indissociabilidade entre o corpo individual, o corpo coletivo e o território, compreendido como espaço de vida, memória, espiritualidade e reprodução social, e evidenciando o compromisso dessa abordagem com os processos coletivos e a defesa dos bens comuns (Miranda e Barroso, 2023). O corpo das mulheres, especialmente indígenas e quilombolas, está intrinsecamente ligado ao território que habitam, sendo ambos alvos de violências e disputas, de modo que qualquer ataque ao território repercute diretamente sobre seus corpos, suas vidas e seus modos de existir (Miranda e Barroso, 2023).

A articulação política dessas mulheres ocorre em contextos historicamente marcados por conflitos e resistências e, mesmo diante de desigualdades de gênero, sociais e regionais, e de opressões e condições de vida precárias, elas constroem formas coletivas de enfrentamento e defesa, reafirmando a inseparabilidade entre corpo e território e protegendo simultaneamente a si mesmas e seus territórios (Miranda, 2020; Miranda e Barroso, 2023; Santos et al., 2025). O protagonismo das experiências de participação social de movimentos de mulheres indígenas é crescente em todo o Brasil (Miranda, 2020), destacando-se, na cidade de Manaus, a trajetória de mulheres indígenas organizadas em associações que, por meio de sua participação política e social, debatem e reivindicam a criação e a formulação de iniciativas de políticas afirmativas em prol da saúde indígena e da atenção diferenciada no Sistema Único de Saúde, evidenciando as mulheres indígenas como agentes sociais envolvidos na defesa de suas formas de viver.

A figura feminina indígena também se destaca no processo de resistência e flexibilização das políticas indígenas, ganhando gradativamente mais força, voz e espaço (Araújo et al., 2022). Além das dezenas de associações indígenas que atuam na representação política e na organização comunitária, observa-se a participação ativa de

mulheres indígenas integradas a essas associações, desempenhando funções de liderança, gestão e promoção de ações coletivas voltadas ao fortalecimento cultural, à defesa de direitos e ao apoio a famílias indígenas que vivem nas cidades (Miranda, 2020; Araújo et al., 2022; Miranda e Barroso, 2023). Essas mulheres articulam projetos, acolhem parentes recém-chegados das aldeias e colaboram na manutenção de redes de solidariedade entre diferentes povos em contexto urbano (Cardenes e Montardo, 2020).

Paralelamente, há um número expressivo de mulheres indígenas que, embora não integrem formalmente associações, residem em comunidades e bairros com forte presença indígena nos centros urbanos. Muitas atuam como trabalhadoras informais, incluindo artesãs, vendedoras de artesanato, diaristas e empregadas domésticas, compondo estratégias cotidianas de sobrevivência (Cardenes e Montardo, 2020). Mesmo sem participação direta em associações, mantêm vínculos com seus territórios de origem e integram redes familiares e comunitárias que acolhem parentes vindos do interior do Amazonas, contribuindo de forma decisiva para a reprodução social e cultural dos povos indígenas em contexto urbano.

As mulheres indígenas participantes da pesquisa foram identificadas por denominações atribuídas pela pesquisadora, com o objetivo de preservar suas identidades e garantir o sigilo das informações pessoais. As nomeações foram inspiradas em suas comunidades ou associações e em elementos da natureza relacionados às suas atividades, costumes cotidianos de autoatenção, cuidado, artes, cultivo e práticas de subsistência e expressão corporal.

Dessa forma, a identidade das participantes foi caracterizada da seguinte maneira:

CRAJIRU, 45 anos, mulher da etnia Baniwa-Tukano, mestre do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM, coordenadora do Makira-E'ta, associação das mulheres indígenas do estado do Amazonas, oriunda do município de São Gabriel da Cachoeira;

ANDIROBA, 26 anos, mulher do povo Sateré-Mawé, do lar, com um filho, residente na comunidade Waikiru, migrada para Manaus aos oito anos de idade, Território Indígena de origem Marau, município de Maués;

TUCUM, 36 anos, indígena do povo Dessano, nascida na comunidade de Cucura, no Território Indígena do Alto Rio Negro, residente em Manaus desde 2013, administradora, gestora de recursos humanos e artesã do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, mestrandia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM, casada e mãe de quatro filhos;

MANIVA, 20 anos, indígena do povo Dessano, estudante, artesã e recepcionista do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, oriunda do município de São Gabriel da Cachoeira;

COPAÍBA, 55 anos, indígena do povo Sateré-Mawé, com uma ilha, formada em Ciências Contábeis, é integrante da COPIME, com atuação desde os 19 anos na defesa dos direitos dos povos indígenas, oriunda do município de Maués;

WARÁ, 39 anos, indígena do povo Sateré-Mawé, mãe de dois filhos, professora indígena, escritora e produtora de documentários, residente na comunidade Waikiru, Território Indígena de origem Marau, município de Maués;

SARATUDO, 54 anos, indígena do povo Apurinã, mãe de três filhos, mora há 25 anos na comunidade onde é líder, a Kaikiru Apurinã, oriunda da região de Jauari, rio Purus;

OPÊ, 54 anos, indígena do povo Tukano, casada, do lar, tem 5 filhos, nasceu na região do alto Rio Tikié, município de São Gabriel da Cachoeira, residente em Manaus;

AÇAÍ, 57 anos, indígena do povo Tikuna, tem 8 filhos, é artesã, membra de grupo musical cultural Tikuna, filha de parteira. Mora em Manaus há 35 anos, seu território de origem é o município de Tabatinga;

JAMBÚ, 40 anos, indígena do povo Tikuna, casada, tem três filhos, mora em Manaus desde os 5 anos de idade, oriunda do território indígena de Tabatinga. É artesã com muito orgulho, como a própria afirma, faz referência à arte como habilidade herdada da família. Artesã e expositora em feiras itinerantes no estado do Amazonas;

TUCUMÃ, 32 anos, indígena do povo Apurinã, casada, uma filha, apoio técnico da COPIME, professora indígena. Nasceu em Manaus, mas ficou até os 7 anos entre a aldeia que fica no baixo Purus, rio Purus, e a cidade de Manaus, reside em Manaus;

UXI AMARELO, 69 anos, indígena do povo Kokama, casada, tem nove filhos, fundadora, juntamente com o esposo, do centro cultural Kokama em Manaus, oriunda do município de Tefé.

A partir das trajetórias dessas mulheres e de suas experiências nos territórios urbanos, o percurso metodológico avançou para a descrição do trabalho de campo realizado em cada contexto.

3.1.6 Caminhos vividos no território: experiências do trabalho de campo

Consolidada a inserção nos territórios e estabelecidos os vínculos com as comunidades e associações, o percurso metodológico avançou para a vivência do trabalho de campo, descrita a seguir a partir das experiências concretas nos territórios investigados.

A primeira comunidade visitada foi a Comunidade Watchimaucu, localizada no bairro Cidade de Deus, após acordo prévio com o cacique. A visita possibilitou compreender o contexto de vulnerabilidade territorial, a dinâmica social e os espaços comuns da comunidade. As conversas envolveram lideranças, anciãs e mulheres artesãs, e o processo de negociação para a anuência revelou tensões históricas relacionadas à participação em pesquisas acadêmicas, bem como à importância atribuída aos saberes das mulheres anciãs e à medicina tradicional.

Durante o encontro, uma das lideranças manifestou resistência à realização do estudo, argumentando que a comunidade já havia participado de diversas pesquisas marcadas por violações de direitos, distorções e inverdades sobre suas falas. Essa manifestação evidenciou violências históricas ainda presentes e revelou limites e desafios da pesquisa com povos indígenas, em consonância com as reflexões de Smith (2018), retomadas por Bergamaschi e Pinheiro (2021), ao explicarem a aversão e a desconfiança dos povos indígenas em relação à pesquisa acadêmica, que muitas vezes reproduz visões parciais e desconsidera a perspectiva dos próprios povos indígenas. Em contraponto, uma anciã indígena e parteira compartilhou suas experiências no cuidado à saúde das mulheres, entoando um canto tradicional em língua Tikuna, o que contribuiu para a ressignificação do diálogo e para a construção de consenso entre as lideranças, resultando na autorização da pesquisa e na solicitação de devolutiva dos resultados.

A segunda visita ocorreu na Associação Comunidade Indígena Waikiru, formada por indígenas do povo Sateré-Mawé, no bairro Redenção. O encontro foi articulado com a liderança feminina e realizado em um sábado, conforme a disponibilidade das mulheres. O projeto foi apresentado no salão de convivência da comunidade, sendo amplamente aceito, com destaque para a relevância do estudo na valorização das práticas tradicionais de cuidado.

No dia da visita, a liderança convidou cerca de dez mulheres para o encontro no salão de convivência da comunidade, um espaço central coberto de zinco e aberto nas laterais, decorado com grafismos, bandeirinhas coloridas e elementos da cultura Sateré-Mawé. Durante o encontro, foi servido um lanche compartilhado, momento em que o

projeto foi apresentado e amplamente aceito, e colhida a assinatura de anuência da liderança. As participantes demonstraram interesse e destacaram a relevância do estudo para a valorização das práticas culturais de cuidado.

Outra etapa de aproximação ocorreu no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, da Associação Indígena Yepa Mahsã (Figura 10), onde o projeto foi apresentado às lideranças e trabalhadores do espaço, resultando na assinatura da carta de anuência. O local é composto por salas destinadas às práticas tradicionais de cura, à confecção de artesanato e às atividades realizadas por especialistas da medicina indígena.

Figura 10: Visita ao Centro de Medicina Indígena.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2026.

Dando continuidade às visitas institucionais, o projeto foi apresentado à Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME) em reunião com a liderança responsável, em espaço institucional destinado a encontros e atividades coletivas. Após debate, a participação da organização foi confirmada. Foi um encontro proveitoso e importante com os membros da associação que aceitaram participar do estudo.

E, finalmente, o projeto foi apresentado à Associação Rede de Mulheres Indígenas Makira-E'ta, que foi contatada em visita à residência de sua liderança, em razão da intensa agenda institucional, sendo o projeto igualmente aceito.

Um fato que ficou evidente em todos os encontros foi a presença coletiva, as lideranças estavam normalmente rodeadas de membros da comunidade ou associação, constatada uma decisão coletiva para a participação do projeto após a apresentação do mesmo. Havia sempre um coletivo para ouvir, discutir e decidir, para finalmente ser assinada a anuência pela liderança, reforçando a lógica de organização social indígena, marcada pelo diálogo, consulta e deliberação conjunta, característica comum nas reivindicações das populações indígenas, suas organizações e tomadas de decisões sociais, culturais e políticas.

Após a finalização das visitas e a formalização das anuências, as entrevistas foram realizadas nas comunidades, associações e residências das participantes, de forma individual. Inicialmente, foram entrevistadas três mulheres vinculadas ao Centro de Medicina Indígena Bahserikowi; em seguida, realizaram-se entrevistas na Comunidade Wotchimaucu e na Comunidade Waikiru. Também foi entrevistada uma participante da Rede Makira-E'ta, em sua sede, e, posteriormente, quatro mulheres indicadas pela COPIME, sendo duas entrevistadas na sede da instituição e duas em suas residências, localizadas em bairros periféricos da cidade.

Uma das entrevistadas relatou hesitação inicial em participar do estudo, em razão do cansaço diante da recorrente desvalorização e discriminação de seus conhecimentos tradicionais. Essa resistência foi superada com o incentivo de sua filha, que reconheceu seu papel como detentora de saberes ancestrais sobre o uso de plantas medicinais, experiência que se revelou significativa no decorrer da pesquisa.

Posteriormente às entrevistas, mulheres que atendiam ao perfil do estudo foram convidadas a participar dos grupos focais, considerando o uso de práticas tradicionais de cuidado à saúde da mulher indígena e a utilização dos serviços da Atenção Primária à Saúde em Manaus.

A realização dos grupos focais com todas as mulheres selecionadas de cada comunidade ocorreu em locais previamente informados e nas datas combinadas de acordo com a disponibilidade das participantes. Os encontros ocorreram em locais escolhidos pelas próprias participantes, fora das comunidades e associações, sendo compreendidos também como momentos de convivência e circulação pela cidade.

Ocorre, nesse exemplo, demonstração de interação grupal e respeito ao princípio da não diretividade, sem interferências indevidas pelo moderador ou facilitador, com objetivo de gerar saberes e apreender fatos e acontecimentos menos acessíveis sem a interação vivenciada (Gatti, 2005; Lopes, 2014; Oliveira et al., 2020). Esse relato

demonstra certa conexão e a relação de confiança criada entre as participantes e a pesquisadora.

Figura 11: Café realizado durante o primeiro grupo focal (café na Sementeira Casa Viva - grupo focal).



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Assim, o primeiro grupo focal foi realizado no espaço Sementeira Casa Viva (Figura 11), concomitantemente à 1ª Feirinha de Artesanato de Mulheres Indígenas de Manaus (Figura 12), como estratégia de valorização das artes indígenas e de apoio à sustentabilidade das participantes. As discussões evidenciaram a centralidade nas práticas tradicionais de cuidado da medicina indígena como primeira forma de cuidado, sendo a busca pelos serviços de saúde acionada, em geral, apenas em situações de agravamento.

Figura 12: Feirinha de artesanato realizada com as artes das mulheres indígenas das comunidades.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

O segundo grupo focal integrou a coleta de dados deste estudo e ocorreu em uma cafeteria (Figura 13) localizada no Largo São Sebastião, espaço de forte simbolismo histórico e cultural, tendo como objetivo aprofundar as discussões sobre práticas de cuidado, identidade indígena em contexto urbano e contribuições das mulheres indígenas para ações de educação permanente em saúde. A escolha do local reforçou o caráter simbólico de visibilidade e resistência da presença indígena na cidade.

Figura 13: Encontro do grupo focal na cafeteria no Largo São Sebastião em Manaus - Teatro Amazonas ao fundo.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Figura 14: Artista indígena realizando ilustrações durante o encontro focal.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

As participantes utilizavam adereços indígenas, expressando identidades e pertencimentos no espaço urbano. Nesse encontro, contou-se com a participação de uma artista indígena do povo Dessana (Figura 14), previamente acordada com as participantes, que produziu ilustrações inspiradas nas falas e debates do grupo. Os desenhos foram apresentados e interpretados pela própria artista, com validação coletiva dos significados, sendo autorizada sua utilização no material educativo resultante da pesquisa. As participantes apoiaram a utilização dos registros visuais no material educativo a ser elaborado no âmbito da pesquisa.

Durante o encontro, as participantes contribuíram com reflexões sobre a metodologia do estudo e sobre as estratégias de abordagem consideradas mais adequadas para ações de educação permanente em saúde. De forma unânime, as mulheres defenderam que as mulheres indígenas sejam protagonistas na transmissão dos conhecimentos da medicina indígena aos profissionais de saúde, ocupando seus lugares de fala conforme a cosmovisão e os modos próprios de cada povo.

Ressalta-se que, ao longo de todo o processo, buscou-se evitar exposições indevidas, hierarquização de saberes ou apropriações não autorizadas dos conhecimentos compartilhados. As participantes foram reconhecidas como sujeitas do processo de produção do conhecimento, em consonância com os princípios éticos que orientam pesquisas com povos indígenas.

Esse conjunto de experiências, narrativas e registros produzidos ao longo do trabalho de campo constituiu a base empírica para a análise apresentada no subcapítulo seguinte.

3.1.7 Caminhos de interpretação: tecnologias de cuidado em análise

A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), desenvolvida em três etapas: Pré-análise: organização do material, leitura flutuante e definição do corpus; Exploração do material: categorização, recortes, codificação e sistematização dos conteúdos; Tratamento dos resultados: interpretação com base no referencial teórico e discussão das categorias emergentes.

Na primeira, denominada pré-análise, ocorreu a organização do material a ser examinado, incluindo as transcrições das entrevistas semiestruturadas, os registros do grupo focal e as anotações do diário de campo, com o propósito de sistematizar as ideias iniciais. Esse momento é considerado uma fase exploratória, na qual se define o conjunto de documentos a serem analisados. Com base nessa seleção, procedeu-se à leitura flutuante de todo o conteúdo coletado.

A segunda fase, chamada exploração do material, correspondeu ao levantamento e à codificação da matéria documental, realizada por meio da transcrição integral das entrevistas e do grupo focal, bem como da sistematização das informações contidas no diário de campo. Nessa etapa, efetuaram-se recortes, condensação e exclusão conforme as hipóteses, categorias e dimensões previamente definidas de acordo com os objetivos da pesquisa.

Por último, na terceira fase, referente ao tratamento e interpretação dos dados, foi realizada a categorização dos elementos. A categorização se caracteriza por agrupamentos de elementos relevantes obtidos em unidades temáticas de acordo com semelhanças e por diferenciação, reagrupados posteriormente por características comuns, em grupos de temas mais abrangentes (Caregnato e Mutti, 2006; Cardoso e Oliveira; Ghelli, 2021). Consistiu na associação dos resultados obtidos com os elementos teóricos apresentados, integrando as diferentes fontes de informação analisadas, com o objetivo de produzir interpretações consistentes e construir os resultados do estudo.

As categorias iniciais foram previamente definidas, mas subcategorias emergiram a partir das falas das participantes.

Figura 15: Comunidade Waikiru – Sateré Mawé.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2024.

Assim, as narrativas foram gravadas, transcritas, analisadas, desmontadas e interpretadas sob a ótica do entendimento da pesquisadora e permitiram identificar as práticas de cuidado utilizadas pelas mulheres indígenas na cidade, baseadas na sua cosmovisão de como se dá o processo saúde-doença e suas opiniões sobre a inter-relação das suas práticas e a assistência dada na Atenção Primária à Saúde.

Dessa forma, o percurso metodológico, construído a partir da inserção nos territórios (Figura 15), da escuta das mulheres indígenas e da análise sistemática das narrativas, registros de campo e produções coletivas, possibilitou a identificação de elementos centrais relacionados às práticas de cuidado, às concepções de saúde-doença e às experiências das mulheres indígenas em contexto urbano. Esses achados fundamentam a apresentação dos resultados e da discussão, organizados em três categorias analíticas: Tecnologias da medicina indígena utilizadas pelas mulheres indígenas; Concepções de saúde-doença na visão das mulheres indígenas; e Inter-relação entre as práticas tradicionais utilizadas por mulheres indígenas em contexto urbano e a Atenção Primária à Saúde.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fluxo do céu, o ritmo da terra, os caminhos das águas e o sentir e agir das estrelas: tecnologias de cuidado, concepções de saúde–doença e interações com a atenção primária à saúde.

Há corpos que nasceram floresta, e há corpos que nasceram concreto.
 Não é uma questão de estilo de vida ou estética: é origem.
 Quem nasce entre rios carrega outra memória no corpo
 Memória que não se aprende por aproximação, nem por visita.
 Viver na aldeia não é ‘inspirar-se’ na aldeia.
 É território que forma o sentir, o pensar e o existir.
 Algumas pessoas admiram – e tudo bem.
 Mas admiração não é pertencimento.
 Pertencer é nascer com a terra dizendo quem você é (Baniwa, 2025).

Este trabalho envolve, antes de tudo, uma admiração por pessoas cujos territórios e pertencimentos nascem da relação com a terra, constituindo quem são. Ao abordar uma temática abrangente, complexa e específica, que diz respeito às vivências cotidianas, costumes e rituais de mulheres de diferentes povos indígenas que vivem na cidade de Manaus, bem como às suas formas de ver, ser, estar e lidar com aquilo que se reconhece como saúde, faz-se necessário um posicionamento ético de respeito e cuidado.

Os resultados apresentados nesse capítulo decorrem do processo de análise descrito anteriormente e expressam os sentidos atribuídos pelas mulheres indígenas às práticas de cuidado à saúde em contexto urbano. A análise evidenciou continuidades dos saberes tradicionais, bem como negociações e tensionamentos estabelecidos com os serviços da Atenção Primária à Saúde, organizados em três categorias analíticas que dialogam entre si.

De forma alguma houve a pretensão de explicar essa cosmovisão em sua totalidade ou abarcar todos os aspectos envolvidos nesse universo plural e intercultural, no qual cada povo apresenta características singulares, socialmente construídas e baseadas em formas próprias de organização comunitária (Silva et al., 2020).

A presente investigação não tem como objetivo dar conta da totalidade das questões relacionadas à saúde das mulheres indígenas residentes em contexto urbano e aos sistemas de medicina indígena, uma vez que tais dimensões envolvem aspectos socioculturais, cosmovisões de múltiplas etnias e a complexidade própria de cada povo. Como afirma Baniwa (2025), cada povo e cada família possuem especificidades no que

se refere às suas tecnologias de cuidado em saúde. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que busca evidenciar, a partir das falas e dos fazeres de algumas mulheres indígenas participantes do estudo, seus conhecimentos e práticas de cuidado à saúde fundamentados na cultura de seus povos. Busca-se, ainda, compreender como essas mulheres percebem os processos de saúde e doença e de que maneira se estabelecem as interações com a assistência ofertada pela Atenção Primária à Saúde (APS) no contexto urbano de Manaus.

No campo da saúde pública, os territórios constituem elemento central na organização do processo de trabalho e na conformação das redes de serviços ofertadas pelo Estado (Gondim e Monken, 2009). No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o território é compreendido como diretriz para o planejamento, a organização e a distribuição das ações e serviços, especialmente no escopo da Atenção Primária à Saúde, sendo o acesso aos serviços de saúde um direito de cidadania assegurado pela legislação brasileira (Alves et al., 2023; Tetemann, Trugilho e Sogame, 2016).

Contudo, a noção de território assume significados distintos quando analisada a partir das perspectivas indígena e não indígena. De modo recorrente, áreas limítrofes são mal definidas nos processos de territorialização institucional, o que compromete a efetivação de programas e ações em saúde e resulta em iniquidades e desigualdades no acesso aos serviços por parte dos usuários do SUS. Isso ocorre porque as demandas e necessidades de saúde não respeitam limites administrativos ou fronteiras geográficas na busca por cuidado e sobrevivência. Nesse sentido, o território no SUS deve prever flexibilização para garantir o acesso (Gondim e Monken, 2009; Tetemann, Trugilho e Sogame, 2016).

Para os povos indígenas, a terra não se limita a uma dimensão geográfica, administrativa ou jurídico-política, constituindo-se como um elemento central da vida social, cultural e espiritual. Conforme destacam Kolling e Silvestri (2019), o território envolve dimensões simbólicas, coletivas e identitárias, sendo fundamental para a reprodução dos modos de vida indígenas. Seeger e Viveiros de Castro (1979) afirmam que a terra não é concebida apenas como meio de produção, mas como o espaço da criação do mundo, da memória e das relações entre humanos, natureza e seres espirituais. Nessa mesma direção, Gallois (2004) distingue “terra”, enquanto categoria vinculada ao reconhecimento político-jurídico pelo Estado, de “território”, entendido como experiência vivida e relação simbólica que conecta os povos indígenas ao espaço que habitam, evidenciando sua importância para a produção da vida, da saúde e do bem-viver indígena.

Dessa forma, o território indígena configura-se simultaneamente como espaço de sobrevivência física e de reprodução cultural, social e espiritual, distinguindo-se do conceito ocidental de propriedade, que reduz a terra à sua dimensão econômica e material. Compreender a noção indígena de território implica reconhecer que este constitui o fundamento da identidade, da memória e da existência coletiva desses povos, expressando modos próprios de ser, viver e cuidar (Tobias et al., 2023). Tal compreensão é central para a preservação das etnias, conforme destaca Bonnemaison (2002, citado por Kolling; Silvestri, 2019), ao afirmar que, em contextos de aculturação e desenraizamento, a constituição de novos territórios, ainda que reduzidos, torna-se estratégia fundamental para a recriação de vínculos culturais, identitários e simbólicos com a terra.

Figura 16: Comunidades indígenas em Manaus.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Essas concepções de terra e território também se manifestam no contexto urbano, particularmente em Manaus, onde os fluxos migratórios indígenas produzem novas formas de territorialização e organização social (Pereira, 2021; Tobias et al., 2023; Santos et al., 2025). Estudos antropológicos contribuem para a compreensão desses processos no Amazonas e das formas de organização étnica em meio urbano (Cardenes; Montardo, 2020). No entanto, a estigmatização e o não reconhecimento das populações indígenas fora de terras homologadas permanecem fortemente associados ao conceito estatal de terra, reforçando o apagamento das heterogeneidades populacionais, linguísticas, sociais e geográficas (Pereira, 2018).

Historicamente, como aponta Silva (1999), os povos indígenas foram estudados a partir de um “lugar de índio” restrito às aldeias, terras indígenas e reservas. Contudo, conforme destacam Coimbra Jr. e Santos (2000) e Baines (2001), os deslocamentos

indígenas para os centros urbanos decorrem de múltiplos fatores, como conflitos territoriais, busca por trabalho, educação e acesso à saúde. Baines (2001) observa, inclusive, que, em alguns contextos, como entre os Tikuna em Manaus, a própria organização social favoreceu a constituição de comunidades indígenas (Figura 16).

Situação semelhante é observada entre os Sateré-Mawé, estudados por Santos et al. (2025), para os quais a terra não é apenas um recurso, mas uma conexão profunda com a vida e com a identidade coletiva, orientada por uma cosmovisão dinâmica que ressignifica crenças e práticas diante de novos contextos, sem romper com suas raízes culturais.

Nesse sentido, os processos de desterritorialização e reterritorialização vivenciados pelos povos indígenas em contexto urbano expressam estratégias contínuas de resistência e resiliência frente às transformações impostas pela cidade (Santos et al., 2025). Em Manaus, diferentes etnias ressignificam bairros, comunidades e associações, transformando-os em territórios de reafirmação identitária e de modos próprios de existência. Machado et al. (2012) e Santos et al. (2025) reforçam essa compreensão ao reconhecerem o território como um espaço vivo, que expressa histórias, cultura, movimentos políticos e relações com o ecossistema.

Assim, mesmo fora de terras homologadas, os povos indígenas mantêm suas cosmologias e relações simbólicas com a terra, reafirmando o território como espaço de vida, memória e pertencimento, o que Silva (1999) define como territorialidade cultural (Figura 17).

Figura 17: Grafismos e desenhos na comunidade Sateré Mawé WAIKIRU - Manaus.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Nesse cenário, as relações sociais desempenham papel central na construção das formas de identificação e pertencimento entre os povos indígenas (Silva, 1999; Machado et al., 2012). O uso recorrente do termo “parente” expressa vínculos sociais que estruturam essas relações. Souza (2004) ressalta que, no pensamento timbira, o parentesco constitui um processo fundamental de constituição da humanidade, na medida em que ser humano é ser reconhecido como parente.

A compreensão dessas abordagens mostrou-se fundamental diante das limitações da formação inicial da pesquisadora, marcada por uma visão tecnicista da biomedicina, pouco atenta às dimensões sociais, culturais e territoriais do cuidado. No contexto da atuação na Atenção Primária à Saúde, tornou-se evidente que uma abordagem linear e classificatória das práticas indígenas era insuficiente para compreender a complexidade dos modos de cuidar das mulheres indígenas em Manaus.

As vivências durante as entrevistas e o grupo focal evidenciaram o valor e a centralidade das práticas de cuidado na vida das mulheres indígenas participantes. Ainda que o roteiro das entrevistas tenha iniciado-se pela concepção de saúde e doença, as mulheres priorizavam espontaneamente o relato de suas experiências com as práticas indígenas de cuidado, destacando seus elementos, objetivos e benefícios. Tornou-se evidente a priorização da medicina indígena como primeira escolha de cuidado, revelando o respeito, a conexão e o pertencimento das mulheres aos modos de viver orientados por sua cultura.

A discussão desenvolvida até aqui permitiu compreender que as práticas de cuidado das mulheres indígenas em contexto urbano estão profundamente articuladas às noções de território, pertencimento, ancestralidade e relações comunitárias. Esses elementos constituem a base a partir da qual se organizam os modos indígenas de produzir saúde, mesmo fora de terras tradicionalmente homologadas, evidenciando processos contínuos de adaptação, resistência e ressignificação no espaço urbano de Manaus.

Nesse sentido, torna-se fundamental avançar da discussão conceitual e contextual para a análise mais detalhada de como essas práticas se materializam no cotidiano das mulheres indígenas. Assim, a divisão analítica adotada neste estudo, inspirada nos eixos apresentados por Baniwa durante o 3º Congresso de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (Baniwa, 2025), orienta a compreensão das tecnologias da medicina indígena a partir das experiências e narrativas das participantes.

Desse modo, o capítulo a seguir aborda as tecnologias da medicina indígena, organizando-as de forma sistemática, sem dissociá-las da cosmovisão indígena, das

relações sociais e do contexto urbano em que são vivenciadas. Essa abordagem permite compreender como tais tecnologias estruturam as práticas de cuidado à saúde das mulheres indígenas em Manaus. Cada categoria analítica será acompanhada por uma ilustração produzida especialmente para este estudo por artista indígena Dessana, que participou de grupo focal e elaborou as imagens a partir desse processo. As ilustrações emergem da pesquisa e traduzem visualmente os principais eixos do estudo: o cuidado em saúde, a memória, o corpo, os saberes tradicionais e as práticas de cura das mulheres indígenas, reafirmando, por meio da integração da linguagem visual, o caráter intercultural do trabalho e seu compromisso com a valorização dos conhecimentos indígenas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

No que se refere à identificação dos excertos apresentados ao longo do capítulo, optou-se por utilizar, ora nomes fictícios atribuídos às mulheres indígenas participantes, inspirados em elementos de suas culturas e da natureza, especialmente aqueles relacionados às práticas de cuidado à saúde e suas artes, ora a identificação por meio do nome da associação ou comunidade de pertencimento. Tal estratégia visa preservar a identidade das participantes, ao mesmo tempo em que valoriza referências simbólicas e coletivas fundamentais aos seus modos de vida e cuidado.

4.1 TECNOLOGIAS DE CUIDADO À SAÚDE DA MULHER INDIGENA

A nossa academia é ancestral!! (Copaíba).

Para mim, remédio caseiro faz parte de mim, da minha família, da minha essência, é onde vejo a cura. (Tucumã).

Figura 18: Janela da memória, cura e proteção.



Fonte: Ilustração produzida por Thais Sarmento Fernandes, especialmente para esta pesquisa, 2025.

Essas falas relacionam-se diretamente a um dos objetivos deste trabalho, que consiste em identificar práticas tradicionais de cuidado à saúde entre mulheres indígenas residentes na cidade de Manaus. Para tal finalidade, buscou-se compreender quem são essas mulheres, onde moram e trabalham, quais são suas principais formas de cuidado fundamentadas na medicina indígena e como se organizam para utilizá-las, de modo a suscitar reflexões acerca desses sujeitos e do reconhecimento étnico de seus cuidados em saúde, em especial no que se refere à saúde da mulher.

Neste capítulo da dissertação, inicia-se apresentando informações sobre possibilidades diversas de cuidado, para além daquelas tradicionalmente reconhecidas pela biomedicina, destacando os conceitos e a cosmovisão da medicina indígena, bem como as práticas tradicionais de cuidado dessa medicina. Essas práticas são abordadas como tecnologias de cuidado utilizadas pelas mulheres indígenas participantes, configurando um dos objetivos centrais deste estudo.

Na sequência, discorre-se sobre as tecnologias de cuidado da medicina indígena, fundamentadas na reformulação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas- PNASPI (Baniwa, 2025) e identificadas nos relatos das participantes, a saber: Tecnologias de Alimentos, que dizem respeito ao uso e às formas de lidar com os alimentos no cuidado à saúde em diferentes fases da vida da mulher; Tecnologias de Cuidado , Resguardo, que abrangem comportamentos individuais e coletivos utilizados em distintos momentos do ciclo de vida feminino como forma de preservação da saúde; Tecnologias de Cuidado com Especialistas, referentes aos cuidados realizados com a assistência de especialistas da medicina indígena, como os kumun, conhecidos como pajés, e as parteiras; e, por fim, Tecnologias de Plantas Medicinais, que envolvem o uso de plantas e seus efeitos benéficos à saúde da mulher.

A composição dos resultados deste estudo revela-se ampla e complexa, considerando a participação de 12 mulheres indígenas de 7 etnias e a riqueza das narrativas, marcadas por informações diversas e relevantes acerca dos elementos investigados, fundamentadas em formas plurais de pensar, ser e viver, ancoradas na cosmovisão indígena. A partir das entrevistas, foi possível conhecer aspectos da trajetória de cada mulher, de sua cultura e de sua visão de mundo e, nesse contexto, de suas práticas de cuidado à saúde, evidenciando características múltiplas e específicas de acordo com os diferentes povos. Considerando os objetivos da pesquisa, este capítulo se detém especificamente nas tecnologias de cuidado da medicina indígena e posteriormente na

concepção saúde-doença segundo a cosmovisão indígena (Figura 18) e na inter-relação dessas práticas com a assistência na Atenção Primária à Saúde.

A Figura 18 expressa simbolicamente essa concepção ao representar a janela como memória da cura, do corpo, das plantas e das conversas entre mulheres, articulada à escuta e à presença do encantado. Os grafismos da Cobra Canoa e da jararaca remetem à geração da vida, à proteção e à força associadas ao corpo feminino, dialogando com as práticas tradicionais de cuidado à saúde compartilhadas pelas participantes da pesquisa.

No campo dos cuidados em saúde, diferentes racionalidades médicas ampliam a compreensão do cuidado para além da biomedicina, incorporando valores mais integrados e humanizados (Luz, 2012). Essas racionalidades, fundamentadas em cosmologias próprias, expressam universos simbólicos e filosóficos que orientam práticas e tecnologias de cuidado diversas, não reduzíveis à explicação biológica, mas capazes de dialogar e compartilhar saberes (Nascimento et al., 2013). Nesse sentido, as formas de busca e manejo da atenção à saúde revelam estratégias diferenciadas de cuidado, evidenciando a coexistência e a complementaridade entre distintos sistemas médicos (Menéndez, 2009).

Assim, essas racionalidades compartilham saberes e práticas em saúde, com tecnologias próprias, sejam elas cientificamente avançadas ou baseadas em demonstrações empíricas tradicionais, cujo intercâmbio possibilita a ampliação e a qualificação do cuidado integral em diferentes sistemas culturais (Nascimento et al., 2013).

Segundo o Dicionário Aurélio (2025), medicina pode ser definida como "arte ou ciência de evitar, curar ou atenuar doenças". A partir desse conceito ampliado, Barreto (2025) utiliza a expressão "arte de curar" como um conjunto de conhecimentos e práticas mobilizadas para promover a cura, restaurar o equilíbrio e garantir o bem-estar. Concepção aberta ao diálogo com outros campos de conhecimento da saúde e em permanente processo de atualização processual, onde é possível reconhecer que todos os povos possuem seus próprios modelos e sistemas de cuidado e cura, suas medicinas específicas, com a formação de especialistas, transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de tecnologias de cuidado (Barreto, 2021)

Nesse contexto, as Medicinas Indígenas, segundo o Ministério da Saúde (2024), constituem um conjunto de sistemas de conhecimentos e tecnologias desenvolvidos há mais de 12 mil anos pelos povos indígenas, voltados à produção e à manutenção de seus modos de vida. Esses sistemas estruturam-se em abordagens preventivas e coletivas de

cuidado com os corpos e os territórios, considerando as diferentes fases dos ciclos da vida e incorporando ordenamentos, especialistas¹ e tecnologias² próprias. Nessa perspectiva, Barreto (2022, 2025) compreende as medicinas indígenas como um sistema complexo que articula dimensões biológicas, espirituais, sociais e ambientais, superando uma visão restrita ao uso de remédios naturais e revelando uma cosmologia relacional e interdependente entre humanos e outros seres como os seres espirituais, as plantas, os animais, as águas, a floresta, o território, os artefatos, a casa, os alimentos, os parentes e outros membros da coletividade. A pessoa é entendida, portanto, como um ente relacional, cuja existência se configura em meio a uma teia dinâmica de interações ontológicas (Barreto, 2025).

Essa concepção é reafirmada por André Baniwa (2025), ao enfatizar que os conhecimentos indígenas relacionados aos cuidados em saúde devem ser denominados Medicina Indígena, uma vez que não se tratam de saberes originados do acaso, mas de conhecimentos herdados desde a criação do mundo, das coisas e da humanidade. Na mesma perspectiva, Barreto (2025) afirma que cada povo tem sua Medicina, seu sistema de arte de cuidado, assim como seus próprios sistemas de formação e suas tecnologias de cuidado com a saúde e cura.

Tal compreensão evidencia que essas práticas se fundamentam em saberes ancestrais e em uma profunda relação com a origem da vida e do universo. Assim, compreender as medicinas indígenas implica reconhecer a complexidade, a ancestralidade e a integralidade que orientam as práticas de cuidado dos povos indígenas, as quais constituem importantes referenciais para a reflexão sobre políticas de saúde e práticas interculturais no contexto contemporâneo.

As práticas tradicionais indígenas são fundamentais para a manutenção da saúde, bem como para a prevenção, a cura e a recuperação nas diferentes comunidades indígenas.

¹ Segundo Barreto (2025): “O termo “especialistas indígenas” refere-se às pessoas que atuam no cuidado da saúde dentro de suas comunidades, de igual modo como os profissionais de saúde formados no modelo ocidental, essas pessoas também passaram por um processo de aprendizado e treinamento que segue os sistemas próprios de formação. Assim como médicos ou outros profissionais de saúde na medicina ocidental recebem educação formal e especializada, os “especialistas indígenas” recebem sua formação dentro de suas tradições. A ideia é que, embora os dois tipos de especialistas atuem no mesmo campo (a saúde), suas formas de aprendizado e atuação são fundamentadas em sistemas distintos, mas igualmente válidos dentro de seus contextos específicos.”

² O termo “tecnologias” é empregado em sentido ampliado, conforme Emerson Elias Merhy, referindo-se ao conjunto de conhecimentos, práticas e relações envolvidas na produção do cuidado, e não apenas a recursos técnicos. Inclui tanto tecnologias biomédicas quanto saberes das medicinas indígenas, como benzimentos, uso de plantas e rituais, reconhecidos como sistemas complexos de atenção à saúde (Barreto, 2025). Articula-se ainda à noção de saúde como “trabalho vivo em ato”, destacando a dimensão relacional do cuidado, como escuta, vínculo e interação (Sodré; Rocon, 2023).

Elas não apenas orientam o significado de estar saudável, mas também definem os caminhos para a recuperação da saúde quando esta é perdida (Barreto, 2022).

Dessa forma, ao relacionar os achados empíricos às diretrizes das políticas públicas, especialmente à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), compreende-se que o uso de plantas medicinais, o parto tradicional, os rituais femininos e os cuidados intergeracionais constituem tecnologias de cuidado, na medida em que são práticas sistematizadas que promovem saúde e autonomia a partir do contexto sociocultural indígena (Brasil, 2019; Brasil, 2024).

O conceito de tecnologias de cuidado aparece em documentos institucionais, como os relatórios do Ministério da Saúde, nos quais é utilizado para designar práticas individuais e coletivas, saberes locais e arranjos comunitários de cuidado que produzem saúde nos territórios indígenas. Tais práticas incluem o trabalho de parteiras, raizeiras, benzedadeiras e coletivos de mulheres que realizam cuidados corporais, espirituais e ambientais (Brasil, 2024). O termo tecnologias de cuidado na medicina indígena (figura 19) é amplamente utilizado nos documentos da PNASPI, assim como por mulheres indígenas pesquisadoras que atuam nesse campo temático e que participaram deste estudo, visto que a amostra foi composta por mulheres com atuações diversas, incluindo mestrandas de universidades federais, detentoras e conhecedoras de termos amplamente utilizados no campo acadêmico. O conceito é justificado pelo fato de a medicina indígena apresentar sistemas bem estabelecidos e definidos, como técnicas de cuidado, tecnologias relacionadas à formação de especialistas, aos resguardos, às regras comportamentais, às tecnologias de alimentos e à segurança alimentar, bem como às tecnologias vinculadas às plantas medicinais e ao manejo do plantio, da pesca e da caça, específicas às múltiplas etnias (Brasil, 2024).

Em consonância, os estudos de Dias-Scopel e Scopel (2019) e de Enk e Kind (2025) descrevem rituais, protocolos tradicionais e arranjos de apoio coletivo, evidenciando práticas que articulam saberes locais, natureza, espiritualidade e organização comunitária com vistas à promoção do bem-estar e à preservação cultural.

Tal aspecto pode ser observado no excerto a seguir, extraído de uma das entrevistas sobre a concepção saúde-doença:

São tecnologias de cuidado: tecnologia para fazer sua comida, tecnologias para cuidar da roça. Para isso, existem padrões de comportamento que precisamos seguir, pois eles também têm conexão com a nossa saúde; se não seguirmos esses padrões, o nosso corpo pode adoecer (Tucum).

Figura 19: Ritual realizado por indígenas da região do Alto Solimões, na Amazônia ocidental brasileira, para proteção contra picadas de cobra.



Fonte: Freitas, Vilela e Nwora, 2023.

As diferenças entre a medicina indígena e a biomedicina também se expressam nas formas de transmissão do conhecimento. Conforme apontam Schweickardt et al. (2023), trata-se de povos de oralidade e de povos da escrita, sendo a oralidade um instrumento central na transmissão dos saberes indígenas, por meio de cantos, verbalizações, sopros, fórmulas e processos intergeracionais conduzidos por especialistas. Como afirmam Fontes (2020); Garnelo e Wright (2001) e Barreto (2025), cada povo constrói historicamente seus próprios modos de organização, sistemas de cuidado e tecnologias de cura, preservando identidades e especificidades que dialogam, mas não se homogeneizam.

As práticas tradicionais desempenham papel fundamental na construção da confiança das mulheres indígenas nos métodos de cuidado próprios de suas culturas, fundamentadas na vivência cotidiana, na transmissão oral e na observação dos efeitos positivos dessas práticas ao longo das gerações (Ramos, 2019; Aurora, 2019; Fontes, 2020). Tais práticas possuem caráter preventivo, orientadas à antecipação de agravos e à manutenção do equilíbrio corporal e coletivo, aspecto recorrente nas narrativas das participantes e amplamente discutido na literatura sobre saúde indígena. Nos relatos colhidos, isso se evidencia na transmissão intergeracional dos cuidados, realizada por meio da oralidade e da observação dos fazeres.

Tal dimensão é evidenciada nas falas das participantes, que associam o cuidado à antecipação de agravos e à manutenção do equilíbrio do corpo e da vida coletiva.

[...] eu falo esses meus conhecimentos para as minhas filhas ...falo que eu sei porque minha mãe fazia e eu estava lá interessada em aprender, então hoje eu sei de todos os remédios, de todos os chás, de todas as cascas [...] (Saratudo).

[...] eu sempre falo que nós, mulheres indígenas, em algum momento a gente se encontra, eu falo que são as ciências que se cruzam porque a gente fala da nossa gente, das nossas práticas, das nossas tecnologias de cuidado, mas em algum momento vai ser muito parecido esses cuidados... só que nos é repassado de maneiras diferentes... isso só nos fortalece porque a gente tem a nossa própria medicina. (Centro de Medicina Indígena).

A divisão analítica adotada neste estudo baseia-se nos eixos apresentados por Baniwa durante o 3º Congresso Mundial de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas, realizado em outubro de 2025 (Baniwa, 2025), os quais orientam a compreensão das tecnologias da medicina indígena a partir das experiências e narrativas das mulheres participantes.

4.1.1 Tecnologias de medicina indígena

a) Plantas medicinais:

“Fazia um chá, usava algumas folhas, ela fazia a reza dela ali, uma plantinha, fazia um banho. O pós-parto é sempre com uso das garrafadas, de Crajiru, Saratudo” (Crajiru).

“[...] Além das regras e etiquetas, a gente usa as ervas medicinais [...]” (Tucum).

“[...] A gente toma muitos banhos com folhas, desde bebê, tipo com cipó alho, mucura caá, faz a mistura dos dois, deixa no sereno durante a noite e dá o banho noutro dia [...]” (Copaíba).

“Tem ervas para tomar, ervas para passar, tem ervas para tomar banho, tem ervas para cheirar, tem ervas para tudo” (Saratudo).

“[...] Para evitar doenças da mulher, se usam chás de casca de plantas, para não ter inflamação [...]” (Jambu).

“[...] A minha mãe defuma a casa com breu branco, breuzinho, para proteção [...]” (Tucumã).

“[...] Ah, o menino está ficando gripado, então dava um banho, e os cabelos ficavam cheios de folhas [...]” (Copaíba).

“[...] Também podemos fazer banhos (assentos) com plantas medicinais e também chás para tomar. Tomamos banho com as folhas de saratudo e com a casca fazemos o chá [...]” (Wará).

“[...] Saúde para nós é a gente cuidar da nossa saúde através de remédios medicinais, chás e plantas que são plantadas ao redor da casa e tem também bastante remédios que são retirados da floresta [...]” (Maniva).

O uso de ervas, garrafadas, chás e banhos com plantas medicinais é recorrente nas práticas de cuidado relatadas pelas mulheres indígenas entrevistadas, sendo empregado tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças, dores e no cuidado cotidiano do corpo. Cada fase da vida da mulher, como menstruação, gestação, pós-parto e puerpério, envolve plantas específicas e modos de preparo próprios, cujos conhecimentos são transmitidos pela oralidade e pela experiência acumulada na observação e na prática intergeracional. Conforme destacam Schweickardt e Barreto (2023), os povos indígenas detêm amplo conhecimento sobre as propriedades curativas, preventivas e protetivas das plantas medicinais (Figura 20), utilizadas também para favorecer aspectos da vida cotidiana, como a caça e as relações afetivas. Nesse sentido, estabelece-se uma relação de interdependência e domesticação entre humanos e plantas, compreendidas como espécies companheiras no cuidado e na sustentação da vida, conforme analisa Lima (2024).

Figura 20: Plantas medicinais indígenas utilizadas na saúde da mulher por uma das entrevistadas no estudo – plantas encomendadas e vindas do seu território de origem.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Nesse contexto, estudos de Enk e Kind (2025) evidenciam que o uso de plantas medicinais por mulheres indígenas está associado à relação com os donos da natureza, seres espirituais que habitam a floresta e exercem influência sobre a saúde humana. Essa compreensão dialoga diretamente com os achados desta pesquisa, como exemplificado nos relatos sobre o uso do breu branco, denominado por uma das entrevistadas como Opê, reconhecido como planta protetora, utilizado na defumação das casas, na preparação do ambiente do parto e na proteção da mulher, do bebê e dos alimentos consumidos no puerpério. Tais práticas também se fazem presentes durante a menarca. Desse modo, as plantas medicinais atuam como aliadas na cura e na proteção contra o mau-olhado e a ação de seres encantados, que podem causar agravos à saúde humana (Barreto, 2022).

Como evidenciado nos discursos, as mulheres participantes do estudo mantêm o uso de plantas medicinais como prática central de cuidado, fundamentada em conhecimentos transmitidos de geração em geração e socialmente reconhecidos pela comunidade como eficazes no restabelecimento da saúde física e espiritual, em consonância com os achados de Baggio et al. (2018). Esses cuidados incluem o preparo e a utilização de chás, banhos, assentos, ervas para defumação e adereços de proteção, dentre outros. Mesmo diante das limitações espaciais do contexto urbano, as mulheres cultivam hortas caseiras em vasos, pequenos jardins ou quintais, demonstrando a preservação e a continuidade de práticas oriundas de seus territórios de origem. Observa-se, ainda, a adaptação dessas práticas ao espaço urbano, seja por meio do cultivo reduzido, da aquisição de plantas em comércios especializados, como o Mercado Público de Manaus, ou por encomendas realizadas a parentes residentes no interior do estado. Essas estratégias dialogam com os achados de Pereira (2021), ao evidenciar que o espaço

habitado pelos povos indígenas na cidade é produzido a partir dos usos do lugar e dos sentidos a ele atribuídos, expressos em práticas como a pintura corporal, os cantos, o aprendizado da língua, a produção de artesanato e as práticas agrícolas e alimentares compartilhadas por múltiplas etnias em contexto urbano.

b) Práticas de resguardo:

O resguardo é um período de cuidados especiais após a menstruação, gravidez e parto, com restrições alimentares e de comportamento. Não seguir o resguardo pode trazer consequências negativas para a saúde da mulher e da criança, como observado nas falas listadas a seguir:

“[...] No pós-parto se fica em torno de 15 dias em casa, não pode sair com as crianças, tem que ficar em casa [...] não pode cozinhar, não pode ficar próximo do fogo, não pode carregar coisas pesadas [...]” (Saratudo).

“[...]A mulher que está em pós-parto pode ter contato também direto com a água. Ela pode ficar doente também. O corpo dela pode pegar friagem [...]” (COPIME).

“[...] O pós-parto é sempre com uso das garrafadas... durante o resguardo por 45 dias [...]” (Crajiru).

“[...] Na menstruação eu tive resguardo, não se pode ficar muito tempo com a barriga molhada, no frio, porque depois pode desenvolver uma doença chamada de mãe do corpo [...]” (Copaíba).

Entre os povos indígenas, os resguardos e reclusões constituem práticas centrais de preservação da saúde da mulher ao longo dos diferentes ciclos da vida. Essas práticas são especialmente observadas em períodos considerados de maior vulnerabilidade, como a gestação, o puerpério e outros ritos de passagem, nos quais o corpo demanda cuidados específicos para manter o equilíbrio físico, social e espiritual.

Entre o povo Apyãwa, conforme estudo de Tapirapé (2025), os cuidados durante a gestação envolvem restrições alimentares e condutas comportamentais adotadas tanto pela gestante quanto pelo pai, com o apoio dos avós, visando garantir o nascimento de uma criança saudável e favorecer sua autonomia ao longo da vida. No período pós-parto, são prescritos repouso, cuidados com a postura corporal, alimentação específica orientada

pela parteira, banhos com folhas e cascas de plantas e o uso de chás para auxiliar no sangramento e na cicatrização (Ramos, 2019; Tapirapé, 2025).

De modo mais amplo, conforme Mendonça (2010), evitar a exposição do corpo durante esses períodos de resguardo e reclusão constitui uma estratégia de proteção, uma vez que a saída precoce da proteção espiritual pode tornar o indivíduo vulnerável ao agravamento do adoecimento. Esses cuidados são orientados pelos especialistas da medicina indígena e evidenciam que a preservação da saúde envolve regras, pactuações e respeito às cosmologias indígenas, devendo qualquer intervenção externa ser negociada de forma cuidadosa e respeitosa.

c) Acompanhamento por especialistas tradicionais:

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2024), os especialistas das medicinas indígenas passam por longos e rigorosos processos de formação e aprendizagem, orientados por especialistas formadores, envolvendo conhecimentos complexos relacionados à natureza e ao mundo espiritual, o que amplia a compreensão de saúde para além da noção de doença e cura (Romero, 2023). Esses especialistas, como pajés, benzedores, parteiras e raizeiras(os), detêm saberes e práticas que articulam elementos vegetais, animais e minerais em tecnologias de proteção, prevenção, alívio da dor e cura (Barreto, 2025). Entre os povos indígenas, práticas como o Bahsesé, conhecido pelos não indígenas como benzimento, constituem tecnologias ancestrais de cuidado em saúde e de construção da pessoa, integrando dimensões terapêuticas, de comunicação e cosmopolíticas, ainda que frequentemente tensionadas pela hegemonia biomédica (Barreto, 2022). Nesse contexto, destaca-se o papel central das mulheres especialistas, cuja formação envolve processos rigorosos de aprendizagem, reclusão, dietas e transmissão intergeracional de saberes, sendo fundamentais no cuidado à saúde da mulher, das crianças e da família, o que evidencia a necessidade de seu reconhecimento como autoridades legítimas nas políticas públicas de saúde indígena.

A ênfase na forma e sistematização diferenciada no acompanhamento de seus especialistas tradicionais foi relatada pelas participantes da pesquisa, como verificado nos excertos abaixo:

“[...] Na gravidez eu fazia os bahsesés com o pajé [...]” (Crajiru).

“[...] Só pode se alimentar e comer depois que a gente passa pelo processo de bahsesé [...]” (Maniva).

“[...] Tem que passar no acompanhamento das mulheres especialistas... os homens que são kumuns que tratam em outra categoria, não tocando no corpo da mulher, diferente da especialista mulher, a mulher toca no nosso corpo, faz perguntas mais íntimas... o homem age com as práticas de bahsesé [...]” (Tucum).

“[...] Quando minha mãe teve um parto, minha tia é parteira, o especialista que estava com ela falou que não pode ter ninguém por perto, precisa de muito cuidado [...]” (Maniva).

“[...] Passar por especialista, tanto homem como mulher, cuidar de nós...acompanhamento pelas mulheres especialistas que tratam do corpo das gestantes e pelos homens que são kumuns [...]” (Tucum).

“[...] O bebê também passa pelo bahsesé, para proteção [...]” (Centro de Medicina Bahserikowi).

" [...] Na nossa cultura, quem cuida da saúde são os homens, fazem bahsesé (benzimento) utilizando cigarro e opê durante a gravidez e no parto..." (Opê).

“[...] O Bahsesé protege dos seres encantados que estão em todo lugar [...]” (Maniva).

O acompanhamento por especialistas tradicionais, como pajés, kumuns e parteiras, é parte constitutiva do cuidado em saúde, articulando práticas de proteção (Figura 21), rituais, benzimentos e orientações específicas para cada fase da vida. Essas práticas reforçam o bem-estar individual e coletivo e expressam a centralidade do conhecimento ancestral na organização do cuidado à saúde da mulher indígena (Barreto, 2025).

As mulheres especialistas desempenham um papel fundamental no cuidado com a saúde e na promoção da cura, especialmente no que se refere à saúde da mulher e das crianças. São as mulheres mais experientes que orientam os novos casais, transmitindo conhecimentos essenciais para a saúde e o bem-estar familiar. No cuidado com a saúde

das crianças, a atuação de especialistas abrange o parto, amamentação, dieta adequada, o uso de plantas medicinais, banhos terapêuticos e outras práticas de cuidado à saúde.

O reconhecimento dessas especialistas como autoridades legítimas no cuidado à saúde é essencial para uma política pública que valorize de fato a saúde indígena.

Figura 21: Prática do Bahsesé por kumun - Centro de Medicina Indígena de Manaus.

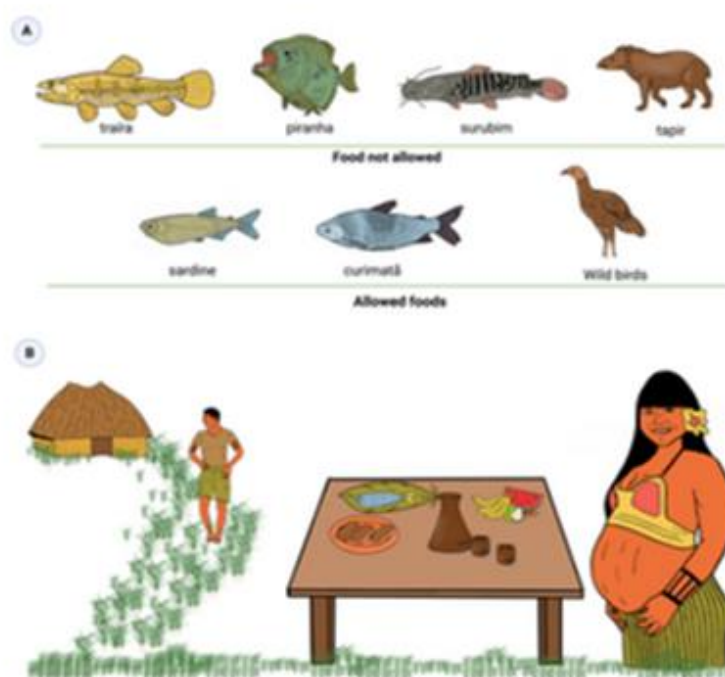


Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2026.

d) Alimentação restrita e adequada:

O cuidado por meio da alimentação constitui uma tecnologia central da medicina indígena, articulando corpo, território e saúde a partir de saberes ancestrais transmitidos intergeracionalmente. Ao longo dos diferentes ciclos de vida, especialmente durante a menstruação, a gestação, o pós-parto e os períodos de adoecimento, as mulheres indígenas seguem restrições alimentares rigorosas (Figura 22), evitando alimentos considerados remosos e priorizando aqueles associados à recuperação, ao fortalecimento do corpo e à manutenção do equilíbrio vital (Baniwa, 2025; Barreto, 2025).

Figura 22: Restrição alimentar – Regras indígenas.



Fonte: Freitas; Vilela e Nwora, 2023.

Essas práticas foram relatadas por todas as participantes do estudo, evidenciando sua permanência e relevância no cotidiano, inclusive em contexto urbano. As falas indicam que determinados alimentos são compreendidos como capazes de agravar inflamações, provocar sangramentos ou gerar desequilíbrios corporais, sobretudo no âmbito da saúde da mulher:

“[...] Também a gente cuida da nossa saúde através da comida, a gente come mais peixes que é mais saudável, come frutas, aí através disso a gente se sente assim mais saudável [...]” (Maniva).

“[...] O abacaxi aumenta a inflamação no útero. Se tiver um ferimento no útero, a minha mãe falava para não comer abacaxi, pois piora a inflamação, pode dar até hemorragia. Abacaxi pode ser veneno para as inflamações na mulher [...] na menstruação, não pode comer frutas azedas porque pode dar doenças mais tarde [...]” (Saratudo).

“[...] Minha mãe falou que eu me formei, aí que ela me guardou e me falou que eu não podia comer nenhuma fruta, leite de castanha [...]” (COPIME).

“[...] A melancia, mesmo não sendo cítrica, ela estimula o fluxo, é um conhecimento que é muito respeitado e minha mãe... e principalmente limão que inflama o útero e realmente a pessoa tem dor, cólica, corrimentos [...]” (Tucuma).

“[...] Também não devemos comer determinadas comidas durante a menstruação, como alimentos com muita acidez, peixes remosos [...]” (Copaíba).

“[...] Tem alimentos que não podemos comer, como alimentos remosos na gravidez e no pós-parto, tipo piranha, podemos comer frango caipira [...]” (Waikuru).

“[...] Até três meses de gestação não se pode comer determinados alimentos, não podemos comer determinadas caças senão pode gerar alguma malformação, ou características do animal ao filho, tipo jabuti. A rã é muito usada na nossa cultura, é muito boa [...]” (Wará).

Esses relatos evidenciam que as práticas alimentares não se limitam a prescrições nutricionais, mas expressam uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, na qual os alimentos são dotados de classificações próprias e se relacionam diretamente com os criadores, com a formação do corpo e com as etiologias das enfermidades, podendo interferir positiva ou negativamente nos tratamentos (Baniwa, 2025).

Nesse sentido, a alimentação opera como uma tecnologia de cuidado que regula equilíbrios corporais, espirituais e ambientais. As reflexões de Rosas sobre a ingestão do alimento, retomadas por Oliveira et al (2023), evidenciam que o alimento transforma o exterior em interior, conectando o corpo a redes e fluxos interespecies, fazendo com que corpo e território se constituam como uma unidade indissociável. Essa perspectiva reafirma a centralidade da alimentação como prática terapêutica e como fundamento dos modos indígenas de cuidar e produzir saúde.

Nos processos indígenas de cuidado, as restrições alimentares são compreendidas como condição relevante para a recuperação da saúde. Estudos de Farias et al. (2023) demonstram que a não observância dessas prescrições, especialmente em casos de picada de cobra, é associada ao agravamento do quadro clínico e à ocorrência de recaídas. De forma convergente, Tapirapé (2025) descreve que, entre o povo Apyãwa, o casal deve seguir restrições alimentares específicas durante a gestação para evitar agravos à saúde do bebê. Esses achados evidenciam que, na concepção indígena, o cuidado alimentar

integra um sistema ampliado de cura, no qual o respeito às regras sustenta a restauração e a manutenção da saúde.

Essa lógica do cuidado, contudo, não se restringe aos territórios indígenas tradicionais. Mesmo em contexto urbano, as mulheres indígenas buscam manter e adaptar suas práticas tradicionais, mobilizando diferentes estratégias para garantir a continuidade dos saberes e cuidados ancestrais. Isso ocorre tanto por meio do recebimento de plantas e remédios provenientes das aldeias quanto pelo cultivo de espécies medicinais em pequenos espaços domésticos (Pereira, 2021), como evidenciam as falas a seguir:

“[...] Eu sempre encomendo plantas quando vem algum parente da aldeia. Lá a gente encontra plantas medicinais verdadeiras e que não se encontra aqui na cidade [...]” (Saratudo).

“[...] Aqui se cultiva em vasos nossas plantas medicinais, em qualquer cantinho de terra que temos a gente planta [...]” (Jambu).

“A gente vive no meio urbano... nosso espaço é pequeno, mas a minha mãe ainda planta, ela gosta de estar ali cuidando do cantinho dela e ela se sente bem com isso [...]” (Tucumã).

“[...] Quando não temos a planta aqui, pedimos que alguém traga uma mudinha do território e plantamos no quintal [...]” (Crajiru).

Os relatos revelam a força e a continuidade dessas tradições, ao mesmo tempo em que expressam preocupação com sua possível perda diante das transformações impostas pela vida urbana e da diminuição do interesse das gerações mais jovens, aspecto já destacado por Baniwa (2018).

Diante do exposto, esta seção evidenciou que as práticas alimentares tradicionais mobilizadas pelas mulheres constituem tecnologias fundamentais para a produção, manutenção e restauração. Ancoradas na ancestralidade, na coletividade e na relação indissociável entre corpo, território e espiritualidade, essas práticas expressam uma concepção ampliada de cuidado, na qual alimentação, resguardo e observância de regras cosmológicas operam como dispositivos terapêuticos e preventivos (Baniwa, 2018; Barreto, 2025; Baniwa, 2025).

Ao explicitar a permanência e a adaptação dessas tecnologias no contexto urbano, o capítulo demonstrou que tais práticas não se configuram como resquícios do passado, mas como estratégias ativas de cuidado, resistência cultural e produção de sentido sobre o corpo, o viver e o adoecer, mesmo diante das transformações socioterritoriais impostas pela cidade. As narrativas das participantes revelam que, apesar das limitações materiais e simbólicas do espaço urbano, as mulheres seguem reelaborando seus saberes e práticas, reafirmando seu papel na sustentação da vida coletiva (figura 23).

Figura 23: Mulheres - Corpos-territórios Indígenas em Resistência.



Fonte: Baniwa, Kaingang e Mandulão, 2023.

Na sequência, os capítulos seguintes aprofundarão a análise da concepção de saúde e doença sob a ótica das mulheres indígenas, buscando compreender como essas experiências de cuidado fundamentam suas interpretações sobre o adoecer e o cuidar-se, bem como a inter-relação entre as práticas da medicina indígena e a assistência ofertada na Atenção Primária à Saúde, evidenciando tensões, diálogos e possibilidades para a construção de um cuidado intercultural no contexto urbano.

4.2 CONCEPÇÕES DE SAÚDE – DOENÇA NA PERSPECTIVA DAS MULHERES INDÍGENAS

Saúde é estarmos em conexão com a natureza, tomar banho de rio, ir para o nosso roçado, comer nossa quinhampira! (Tucum).

Figura 24: Corpo feminino indígena e símbolos de cuidado e geração da vida.



Fonte: Ilustração produzida por Thais Sarmento Fernandes, do povo Dessana, especialmente para esta pesquisa, 2025.

Dando continuidade à análise das práticas tradicionais de cuidado apresentadas no subitem anterior, este item aprofunda a compreensão das concepções de saúde e doença a partir da perspectiva das mulheres indígenas, considerando os modos próprios de interpretar o corpo, o adoecimento e o cuidado.

As percepções sobre o processo saúde-doença da mulher indígena demandam atenção específica, considerando o papel central que as mulheres ocupam como protagonistas do cuidado, tanto no âmbito familiar quanto coletivo (Abritta et al., 2021). Essas percepções são atravessadas pelas mudanças, demandas e vulnerabilidades impostas pela vida urbana, com repercussões pessoais, familiares e comunitárias, além de

influenciarem diretamente a forma como se estabelece a inter-relação com a Atenção Primária à Saúde.

Ressalta-se que os povos indígenas possuem epistemologias próprias, nas quais as concepções de terra e território diferem substancialmente daquelas instituídas pelo Estado e pela sociedade ocidental moderna capitalista. Trata-se de concepções de mundo que não fragmentam o conhecimento, nem separam material e imaterial, sociedade e natureza, mas compreendem a existência como parte de um mundo integrado (Figura 24), orientado pelo princípio do bem viver (Faria, Castro e Osoegawa, 2022). Esses fundamentos epistemológicos orientam a leitura das narrativas apresentadas a seguir, nas quais as mulheres indígenas expressam suas compreensões sobre saúde e doença a partir de suas experiências e modos de vida.

Nesse sentido, a Figura 24 representa o corpo de uma mulher indígena configurado como um grande útero em forma de cuia, símbolo do espaço sagrado de preparo de remédios, folhas e sopros de cura. O grafismo da cobra canoa percorre o corpo até o útero, indicando proteção e geração da vida, enquanto os grafismos fazem referência ao feminino Dessana, às gravuras rupestres e à cerâmica. As folhas e raízes representam as ervas medicinais e a conexão entre corpo e terra, expressando concepções integradas de cuidado, corpo e território.

Na cosmovisão indígena, a saúde e a doença constituem-se em estreita relação com o território, o ambiente e as formas de convivência entre humanos e não humanos, ultrapassando a dimensão estritamente biológica do corpo (Garnelo e Pontes, 2012). Nessa perspectiva, a saúde expressa o equilíbrio das relações individuais e coletivas com a natureza e com as entidades não humanas, organizando-se como um sistema preventivo e protetivo que antecede o ato de curar (Barreto, 2025). O processo saúde-doença, assim, vincula-se à gestão do território, aos saberes tradicionais e às normas simbólicas que regulam essas relações.

Em diálogo com esse entendimento, Dumont e Barra (2025) destacam que as concepções Yanomami e Ye'kwana de corpo, saúde e doença diferem do modelo biomédico, exigindo o reconhecimento de múltiplos modos de conhecimento no cuidado à gestação, ao parto e ao nascimento, compreendidos como parte de práticas coletivas construídas ao longo dos diferentes tempos da vida, que envolvem resguardos, rituais e estratégias de proteção e fortalecimento inseridas em redes ampliadas de relações.

Essa compreensão articula-se à noção de percepção enquanto processo corporal e vivido, conforme Nóbrega (2008), no qual sentir, agir e compreender constituem uma

experiência situada, relacional e histórica. A percepção, nesse sentido, não é passiva, mas produtora de sentidos a partir da interação entre corpo, mundo, cultura e história. Do mesmo modo, cultura, segundo Melo et al. (2021), corresponde a um conjunto de significados compartilhados, construídos a partir da experiência sensorial e simbólica, que organizam o mundo social e o tornam inteligível para a coletividade. Esses sistemas culturais são dinâmicos e históricos, reelaborando seus significados sempre que deixam de explicar adequadamente novos eventos, garantindo sua continuidade e eficácia. Tal compreensão dialoga com o conceito de cultura baseado em Geertz (2008), citado por Garnelo, Sampaio e Pontes (2019), que a define como um sistema simbólico em contínua produção, especialmente tensionado pelas transformações impostas pelo processo colonizatório.

Assim, para as populações indígenas, e de modo particular para as mulheres, saúde e doença envolvem territorialidade, espiritualidade, cosmologia, práticas coletivas de cuidado, modos de vida vinculados ao território e resistência à desvalorização de seus saberes. A percepção de saúde-doença é construída em redes relacionais que extrapolam o corpo físico e exigem o reconhecimento das epistemologias indígenas, o diálogo entre saberes e políticas de saúde que respeitem essas dimensões, em contraste com o modelo biomédico hegemônico (Ahmadpour et al., 2023; Scopel et al.; Freitas et al., 2017; Barreto, 2025; Baniwa, 2025).

A partir dessas definições, o texto conduz para a interpretação das percepções expressas nas experiências vividas pelas participantes. Compreender essas relações é fundamental para superar uma concepção restrita de saúde como mera ausência de doença (Barros, Santos e Souza, 2025).

Encerrada a parte conceitual, passa-se à organização analítica dos dados produzidos nas narrativas das mulheres indígenas.

A partir da análise dos dados produzidos neste estudo, emergiram cinco caminhos analíticos que expressam esses atravessamentos nas falas e vivências das mulheres indígenas, ancorados em suas percepções e sistemas culturais. Esses caminhos organizam a apresentação dos achados e orientam a análise das categorias discutidas a seguir.

A análise das narrativas revelou um conjunto de ideias recorrentes que respondem diretamente ao objetivo de compreender a concepção de saúde e doença a partir da perspectiva das mulheres indígenas. Nos relatos, as participantes expressam o que significa ter saúde e como ela é construída continuamente, bem como os fatores que

interferem em sua preservação. Essa compreensão extrapola o modelo biomédico centrado no aspecto biológico, evidenciando uma cosmologia específica de bem-estar, na qual a saúde é produzida por meio de dimensões relacionais, coletivas, sociais, culturais, territoriais e espirituais (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019; Dias-Scopel e Scopel, 2019; Barreto, 2025).

Esses elementos analíticos constituem a base para a categorização dos achados apresentada a seguir, permitindo organizar e aprofundar a compreensão dos sentidos atribuídos ao processo saúde-doença pelas mulheres indígenas. Dentre as categorias criadas a partir dos relatos, destacam-se: a importância do equilíbrio entre corpo, mente e espírito como fundamentais para a saúde; saúde como estado indissociável da natureza; as regras, etiquetas e tecnologias sociais relacionadas ao cuidado corporal; a transmissão intergeracional de conhecimentos; e a menstruação e seus significados na saúde da mulher indígena.

a) O equilíbrio entre corpo, mente e espírito como definição de saúde:

Para os povos indígenas, o bem-viver está intrinsecamente vinculado ao cuidado com o território, incluindo as florestas, as plantas medicinais, os rios, lagos e cachoeiras, reconhecidos como moradas de seres responsáveis pela proteção desses espaços. Nesse sentido, como afirma Barreto (2025), a concepção de saúde e doença ultrapassa o entendimento estritamente biológico do corpo, sendo indissociável das relações éticas, espirituais e territoriais que sustentam a vida.

Nesse contexto, a espiritualidade aparece como componente indissociável da saúde nas narrativas das mulheres indígenas, revelando uma cosmologia onde os seres espirituais da natureza, os chamados donos do mundo, influenciam diretamente a saúde humana. Essa forma de compreender a saúde exige cuidados específicos para manter o equilíbrio entre o mundo humano e o espiritual, enfatizando a necessidade de resguardos e práticas protetivas.

A partir dessa compreensão do equilíbrio corpo-espírito, seguimos para o aprofundamento da relação entre saúde, território e natureza.

O conceito de Donos do mundo (ou Donos dos lugares, das plantas e dos animais) é mobilizado a partir de Lima e Soares-Pinto (2024), que o articulam no âmbito de uma cosmopolítica do cuidado, em diálogo com a concepção aprofundada por Barreto (2021), ao afirmar a coextensividade entre corpo e território no agenciamento das relações com

os Donos não humanos (Waimahsã), e encontra correspondência nas narrativas cosmológicas apresentadas por Apurinã (2020).

No entendimento indígena, como afirmam Dumont e Barra (2025), a doença não é concebida apenas como um distúrbio físico, mas como a afetação da imagem essencial da pessoa, princípio vital e relacional do ser, geralmente decorrente de agressões por espíritos da floresta. Nessa perspectiva, a relação entre corpo, pessoa e ambiente ocupa lugar central nas concepções de saúde e doença, pois o equilíbrio da vida depende da harmonia entre humanos, território e os demais seres que habitam a natureza. Ribeiro (2020), ao analisar a cosmovisão dos povos Asuriní, descreve a floresta como um espaço povoado por múltiplos seres animais e espirituais, capazes de interferir na formação do corpo e da pessoa, o que exige cuidados específicos, sobretudo por parte das mulheres, como evitar banhos em rios ou igarapés situados no interior da mata. Em consonância, Foller (2004) discute que a origem de determinadas enfermidades pode estar associada às interações do indivíduo com elementos da natureza, como plantas, árvores, ventos ou remoinhos de água. Tais interações demandam medidas protetivas, como o uso de amuletos confeccionados com materiais do próprio território, com a finalidade de resguardar o corpo frente aos perigos e às agências não humanas (Ribeiro, 2020). Segundo Wará: “[...] Sempre tinha que tomar banho antes das seis por causa dos encantados e a gente já era mocinha, então a gente tinha esse cuidado com os encantados para não fazer mal a gente [...]”.

O autor reforça essa lógica ao descrever uma criança Asuriní que utiliza uma pulseira de dente de macaco acompanhada de uma pequena bolsa contendo alho e tabaco, destinada a protegê-la de ataques espirituais, maus-olhados e quebrantos.

As reflexões de Barreto (2021, 2022) ampliam esse entendimento ao demonstrar que, no cosmos indígena, não apenas humanos ocupam os espaços terrestres, mas também seres antropomórficos denominados Waimahsã, alocados por Yepa oãku e Yepálio para habitarem todos os domínios do mundo. A presença desses seres implica que todos os lugares são habitados, exigindo dos humanos regras comportamentais que assegurem o equilíbrio nas relações, fundamento da concepção de “bem viver” entre os Yepamãsã. Manter relações harmoniosas com os Waimahsã, donos dos lugares e responsáveis pelos animais, vegetais, minerais e pela temperatura do mundo, constitui necessidade vital para a continuidade da vida social e ambiental (Barreto, 2022).

Conforme analisa Barreto (2021, 2022), os seres não humanos podem agir sobre os humanos por meio de diferentes elementos do cosmos, como ventos, chuvas, raios,

trovões, vegetais, animais, a exemplo de peixes, cobras e sucuris, e da própria água, em suas cores, ondas e banzeiros. Nesse contexto, o corpo humano permanece exposto e vulnerável a múltiplas forças cosmológicas, de modo que a saúde exige mediação constante entre humanos, não humanos e os diferentes domínios que compõem o mundo, sendo os cuidados corporais fundamentais para a prevenção de agravos (Ribeiro, 2020).

Esses cuidados foram recorrentemente descritos pelas participantes como práticas comuns, mantidas inclusive em contexto urbano. Contudo, mulheres mais jovens relataram que, diante das exigências da vida na cidade e da multiplicidade de atividades cotidianas, nem sempre conseguem cumprir integralmente os resguardos prescritos, associando o descumprimento das regras a desconfortos físicos, como fluxo menstrual intenso e cólicas, compreendidos como sinais do não cuidado adequado nos ciclos femininos. Nesse sentido, os resguardos são percebidos como fundamentais para evitar complicações futuras, sobretudo aquelas relacionadas à saúde reprodutiva (Barreto, 2025). Essa compreensão se expressa nos relatos sobre o Bahsesé (benzimento), realizado em fases específicas da vida da mulher, como ilustra a fala a seguir:

[...] Quando uma mulher passa pela menstruação pela 1ª vez, tem que ter vários cuidados: não pode tomar banho, não pode comer peixe, não pode comer pimenta, enquanto não passa pelo Bahsesé, não pode ter contato com nada, só pode ficar deitada. O Bahsesé protege dos seres encantados que estão em todo lugar [...] (Maniva).

Como apontam Barra e Dias (2012), Apurinã (2020), Barreto (2021) e Lima e Soares-Pinto (2024), a quebra dos protocolos morais, corporais e territoriais pode desencadear doenças, feitiços e mortes, assim como desequilíbrios ambientais, como secas, chuvas extremas, erosão, escassez de alimentos e o abandono dos lugares pelos espíritos-Donos. Práticas protetivas desde o nascimento, como o uso de adornos corporais (Figura 25), reforçam essa lógica, conforme expressa o Copaíba: “[...] quando a criança nasce, colocamos logo uma pulseirinha de tucumã, é uma forma de proteção...assim que nasce, já usa [...]”.

Figura 25: Adorno de proteção em criança indígena – pulseira de sementes.



Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2025.

Essa compreensão dialoga com a perspectiva antropológica apresentada por Scopel et al. (2024), ao enfatizar que os processos saúde-doença entre os povos indígenas são indissociáveis das dimensões espirituais, territoriais e comunitárias, ultrapassando a lógica estritamente biomédica.

No âmbito da saúde da mulher indígena, a negligência dos resguardos associados à menstruação pode gerar adoecimentos no corpo feminino e impactos negativos no território e na coletividade, especialmente aqueles relacionados ao parto e à fertilidade, uma vez que o sangue menstrual é concebido como substância potente e perigosa para os Donos dos lugares e seres invisíveis dos rios e do ar, que podem se vingar dos humanos (Baniwa, 2018; Barreto, 2021). Tal entendimento é sintetizado nas falas a seguir:

“[...] Esses lugares têm donos, donos da natureza que eles podem não gostar de estar sujando a casa deles com o meu sangue quando estou menstruada” (Tucum).

"[...] A mulher que menstrua a primeira vez não pode ter contato com nada, só pode ficar deitada. O Bahsesé protege dos seres encantados que estão em todo lugar, que estão sempre ao nosso redor" (Maniva).

Ainda sob a perspectiva indígena, a saúde é compreendida como uma dimensão relacional e coletiva, que ultrapassa o corpo biológico e se vincula diretamente ao bem-viver, ao pertencimento e às práticas sociais compartilhadas, conforme aponta Baggio et al (2018). Nesse sentido, festas, rituais e reuniões coletivas, como as festas, os rituais de

passagem e as pinturas corporais, constituem práticas fundamentais de cuidado, proteção e prevenção, integrando a Medicina Indígena como um sistema que sustenta o equilíbrio da vida (Barreto, 2025). A centralidade da coletividade na produção da saúde evidencia que o bem-estar indígena depende da articulação entre indivíduos, famílias, comunidade, território, natureza e espiritualidade, formando uma rede relacional que protege o corpo e a vida (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019).

Para ser saudável a gente não tem que sentir nada de ruim, nada de dor, então para mim saudável é estar ali no lugar onde eu possa estar, meus filhos estarem bem, fazer meus artesanatos, sem ninguém para incomodar, poder viajar, porque viajo bastante para vender meus artesanatos aqui pela região, então ser saudável é não estar doente [...] (Jambu).

“[...] Saúde para nós é muito importante e aqui, como somos indígenas, a gente vive de acordo com a nossa cultura[...]” (Comunidade Wotchimaücü).

Sob a ótica indígena, a concepção de saúde está intrinsecamente vinculada aos laços coletivos, às práticas culturais e às formas de organização comunitária, que sustentam o bem-estar individual e coletivo. Nesse sentido, políticas e serviços destinados às populações indígenas precisam valorizar e fortalecer essas relações, uma vez que sua presença está diretamente associada a melhores condições de saúde e a práticas de cuidado culturalmente coerentes (Lin et al., 2023).

Práticas culturais e religiosas, como os grupos musicais, os cantos em língua materna e os encontros comunitários, fortalecem vínculos intergeracionais e identitários, reafirmando que o cuidado em saúde extrapola a dimensão biológica e se constrói no compartilhamento de saberes, afetos e pertencimento. A confecção de artesanatos, por sua vez, não se restringe à produção material, mas cumpre papel central na valorização e difusão cultural, além de constituir fonte de renda para as mulheres indígenas. Como destaca a Associação Comunidade Wotchimaücü, o artesanato, a pintura, o canto, a alimentação e o uso da língua própria expressam a continuidade da cultura Tikuna no contexto urbano, demonstrando que viver na cidade não implica ruptura com os modos indígenas de cuidar, viver e produzir saúde (Associação Comunidade Wotchimaücü, 2009). “[...] Tem a ver com saúde também na nossa cultura ter o nosso grupo cultural... minha mãe tem um grupo musical... gostamos de resgatar a nossa cultura para nossos filhos e netos não esquecerem [...]” (Comunidade Wotchimaücü).

A dimensão comunitária da saúde percorre todos os relatos, evidenciando que o bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao coletivo, demonstrando como a saúde

individual afeta toda a comunidade. As festas, atividades coletivas e culturais são percebidas como importantes para a preservação, a transmissão e a resistência cultural, além de fundamentais para a manutenção da saúde comunitária. Bem evidente nas falas de Saratudo como componente da saúde:

A festa tem queixada, porco, veado faz moqueado, assa tambaqui, todo mundo participa, todos trabalham para acontecer a festa. Aí dançam no terreiro, arria a comida no meio, faz a roda e distribui para todo mundo, isso é saúde pra gente. Quando se fica doente, fica todo mundo desanimado, não consegue fazer nada, todo mundo desanima. (SARATUDO).

Essa compreensão evidencia a necessidade de uma APS intercultural, que reconheça a saúde da mulher indígena para além do corpo individual, como parte de relações cosmopolíticas que sustentam a vida coletiva e territorial (Barreto, 2025). A descon sideração desses princípios compromete a integralidade do cuidado, enquanto sua incorporação fortalece práticas interculturais eticamente situadas nos modos indígenas de produzir saúde (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019).

b) Saúde como estado indissociável da natureza

Barreto reforça essas perspectivas ao propor uma teoria indígena do corpo, elaborada a partir das epistemologias Ye'pamahsã (Tukano), apresenta o corpo como composto por elementos cosmológicos: terra, água, floresta, animal, ar, luz/vida, humano, de modo que desequilíbrios nessas substâncias ou relações produzem doenças, desconfortos, desequilíbrios (Barreto, 2022).

"[...] Saúde para nós, mulheres indígenas, ainda mais para o meu povo dessano, a saúde é nós estarmos em conexão com a natureza. É a gente estar de bem com a nossa vida, tomar banho de rio, comer nossa quinhapira, ir para o roçado.!" (Tucum).

A descrição de Tucum do povo dessano contempla a definição de Baniwa ao descrever o Bem Viver não meramente como ausência de doença, mas como vida plena, integrada ao território, com valores culturais, práticas de coexistência respeitosa com a natureza, e com práticas cotidianas e comunitárias que sustentam o bem-estar coletivo (Baniwa, 2019).

A saúde para os povos originários está intrinsecamente ligada à liberdade de se movimentar e participar de atividades na comunidade em harmonia com a natureza e seus ciclos, observado na fala de mulheres participantes:

"[...] Saúde é poder trabalhar, pescar, plantar, colher e tirar fruta, ir para o mato comer fruta" (Saratudo, 2025).

"[...] Saúde é, final da tarde, escutar história contada pelos nossos anciões da comunidade!" (Tucum, 2025).

Conforme destaca Barreto (2025), entre os povos indígenas, o cuidado à saúde não se restringe à intervenção curativa diante do adoecimento, mas se organiza como um sistema essencialmente preventivo e protetivo, fundamentado em lógicas comunitárias e territoriais, de acompanhamento e proximidade, inseridas no cotidiano da vida, nas quais a promoção da saúde e a manutenção do equilíbrio são prioritárias. Essa compreensão sustenta a formulação das Medicinas Indígenas como arte do cuidado com a saúde e a cura, evidenciando que cuidar implica compreender as múltiplas relações estabelecidas entre humanos, território e demais seres na produção da vida, sendo a prevenção anterior e mais fundamental que o próprio ato de curar (Barreto, 2022, 2025).

No contexto urbano, entretanto, a relação entre saúde e território permanece presente nas falas, ainda que atravessada por profundas tensões. Como expressa a fala de Tucum, diante das vulnerabilidades socioambientais, da ausência de políticas públicas ambientais e da imposição de um modo de vida capitalista, os povos indígenas acabam, muitas vezes de forma compulsória, envolvidos em processos de degradação ambiental, como a transformação de igarapés em esgoto.

Esse cenário, conforme analisam Barros, Santos e Souza (2025), impõe às mulheres indígenas o desafio de coexistir entre diferentes mundos, nos quais seus territórios existenciais são continuamente invadidos e regulados por normas externas de comportamento e sociabilidade. Enfrentar essas condições exige a reelaboração de práticas e costumes opressivos, sem romper com a cultura que sustenta sua existência, o que produz impactos diretos sobre a saúde e o bem-estar.

Essa experiência dialoga com as análises de Miranda e Barroso (2023), que evidenciam como a expropriação territorial e as transformações nos modos de vida afetam a saúde, os valores culturais e a dimensão subjetiva da existência indígena, com repercussões mais intensas entre as mulheres. Tais efeitos são aprofundados pelas mudanças climáticas, especialmente quando associadas à pobreza, à invisibilidade nas políticas públicas urbanas e às desigualdades no acesso ao saneamento, à água, à moradia, à alimentação adequada e à participação nos determinantes sociais da saúde (Faria, Castro e Osoegawa, 2022; Nunes, 2010; Freitas et al., 2017).

“[...] A gente vive no meio urbano, com muro, tudo fechado e nosso espaço é pequeno. O espaço que tem a minha mãe ainda planta, ela gosta de estar ali cuidando do cantinho dela e ela se sente bem com isso [...]” (Tucumã, 2025).

Contrastes da alimentação tradicional com a urbana e a consequência da mudança alimentar são percebidos como fator de risco para complicações de saúde, incluindo o aumento da pressão arterial durante a gravidez:

“Aqui a alimentação é diferente da nossa da aldeia, lá tem peixes, coisas naturais e aqui é muito química, come salsicha, come calabresa, come conservas... isso causou uma gravidez de risco em mim, pois não tinha condições financeiras de me alimentar bem aqui na cidade” (Wará, 2025).

Esse cenário, agravado pela disponibilidade de alimentos industrializados e ultraprocessados substituindo os alimentos naturais tradicionalmente consumidos nas aldeias, é relatado por WARÁ ao destacar que, devido às dificuldades financeiras, a dieta cotidiana passou a incluir produtos como salsicha, conservas e embutidos, resultando inclusive em problemas de saúde durante a gestação. Assim, torna-se fundamental que estratégias de intervenção assegurem a autossuficiência alimentar familiar e promovam o consumo de dietas variadas baseadas em alimentos locais, articuladas a ações preventivas contextualizadas à realidade indígena (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019).

A segurança alimentar e nutricional da população indígena em contexto urbano é fortemente condicionada por fatores socioeconômicos que restringem o acesso a alimentos adequados, diversificados e culturalmente pertinentes. Nesse cenário, os hábitos alimentares passam por um processo de transição caracterizado pela crescente incorporação de alimentos industrializados, típicos do ambiente urbano, o que modifica de forma significativa a relação entre saúde e doença (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019).

Essas dietas, com maior proporção de produtos introduzidos nesse contato, apresentam elevados teores de sal, açúcar e gordura, contribuindo para o aumento de agravos nutricionais e metabólicos. Além disso, o baixo rendimento econômico, a dependência de programas assistenciais e a ausência de acesso regular à água potável intensificam as carências alimentares, atingindo de maneira mais expressiva mulheres em idade reprodutiva e idosos (González-Martell et al., 2019).

A partir de uma compreensão ecossistêmica da saúde (Minayo e Miranda, 2002) e das concepções indígenas de bem viver, a ruptura dos vínculos entre corpo, território e ambiente compromete a saúde coletiva e a continuidade dos modos de existência, evidenciando que, mesmo em contextos urbanos e ecologicamente restritos, preservar

práticas preventivas, cultivos de plantas medicinais e formas próprias de cuidado constitui não apenas uma estratégia de saúde, mas também de resistência e afirmação da vida indígena.

Nesse sentido, a concepção indígena de bem viver expressa por André Baniwa (2025) reforça que a vida plena se sustenta na relação equilibrada com o ambiente e com o território, e que a ruptura desses vínculos, seja pela crise climática, seja pela desigualdade urbana, compromete a saúde coletiva, a autonomia e a continuidade dos modos de existência dessa população.

“Ter saúde e estar bem é não existir nenhuma doença, na aldeia a gente está bem quando a gente vai trabalhar, a gente vai pescar, a gente faz um monte de atividades, plantar, colher e tirar fruta, ir para o mato comer fruta que a gente gosta” (Saratudo).

Se a saúde se ancora na relação com a natureza, ela também se organiza por normas culturais que regulam o cuidado do corpo.

Percebe-se assim, através das narrativas das mulheres, que o distanciamento ou ausência de contato de natureza, ou mesmo contato com áreas degradadas como fator adoecedor, tanto pela indisponibilidade de alimentos saudáveis e naturais encontrados facilmente como frutas, caças, peixes nas localidades de origens das participantes, como questões ambientais poluídos e degradados pela ação humana e a falta de saneamento em áreas com inúmeras vulnerabilidades e falta de condições básicas de sobrevivência nas cidades.

c) Regras, etiquetas e tecnologias sociais - Relação entre saúde física e costumes/regras/etiquetas:

Presente em várias falas, tanto nas entrevistas como no grupo focal, termos como “regras”, “etiquetas sociais”, “padrões de comportamento” e “tecnologias de cuidado” são usados pelas mulheres para expressar normas culturais.

Tucum define essas regras como etiquetas sociais e tecnologias de cuidado dentro de seu povo, primordiais no cuidado ao corpo com padrões de comportamento repassados pelas ancestrais, avó e mãe. E que esses cuidados ultrapassam a questão física.

[...] Eu, como uma mulher indígena, primeiro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso corpo a gente tem que seguir algumas regras que eu chamo de etiquetas sociais que são padrões de comportamento de cada grupo étnico possui, assim como minha mãe e minha avó que me formaram mulher e me ensinaram a seguir essas regras, para ter uma saúde estável, ter uma qualidade de vida boa [...] (Tucum, 2025)

Evidenciada pela fala de Copaíba e Crajiru, ao afirmarem que na cultura indígena as regras ultrapassam objetivos físicos, mas também abrangem a formação para exercer papéis na família e comunidade de forma íntegra e adequada:

“[...] Na cultura indígena, tanto a menina como o menino, nós somos preparados desde novos. Até para o momento de você ser uma boa mãe, ser um bom pai, tanto que tem o ritual da tucandeira dos meninos, que é uma passagem para você ser um bom marido, para ser um bom caçador, ser uma boa liderança. A mulher é preparada para o nascimento do filho, para ser uma boa mãe, o cuidado não apenas com a família [...]” (Copaíba, 2025)

“[...] Então temos muitas regras assim desde pequenas, mas assim que a gente deve seguir, principalmente quando vamos virar mulher, quando a gente se torna uma moça e mãe. Essa concepção tanto faz o povo tukano como o povo baniwa também segue a mesma linha com algumas diferenciações...O conceito de saúde hoje que eu passo para as minhas filhas é isso [...]” (Crajiru, 2025)

“[...] Na verdade, a mulher tem uma grande responsabilidade, ela que dá continuidade desses conhecimentos para os mais novos [...] isso acontece desde cedo, são conselhos, são asseios, é interessante isso porque é todo um cuidado, é espiritual, não pode separar isso, é um conjunto, é uma forma de viver [...]” (Copaíba, 2025)

Exemplificado por Maniva quando relata sobre determinadas regras comportamentais/sociais e em consonância com Oliveira, Nahum-Claudiel e Martín (2023), as práticas e regras extrapolam a prevenção de doenças e o cuidado à saúde, e adicionam a força corporal necessária para as demandas rotineiras e, acima de tudo, para ter fluidez e rapidez na hora do parto.

[...] Minha avó sempre falava que tipo eu tinha mania de ficar na porta, sentada na porta ou em pé, apoiada na porta. Então, ela falava que mulher não pode ficar sentada na porta ou apoiada na porta porque pode prejudicar na hora do parto, por exemplo, a saída do bebê, que pode sair primeiro o braço, sair pela mão, posição da criança que não é normal. Por isso tem que sentar no banco, no lugar certo [...] (Maniva, 2025).

Isso é notado quando Maniva, Tucum e Makira-E'ta detalham sobre o descumprimento das regras como causador de doenças, conforme excerto a seguir:

“[...] Por isso que tem que ter muito cuidado e os cuidados, minha mãe falou que são para ter saúde e evitar ficar doente [...]” (Maniva, 2025)

“[...] Não é simplesmente só cuidar da saúde, também é cuidar do meu corpo, o meu corpo tem regras... Primeiro temos que saber as regras e seguir para o nosso corpo não ficar vulnerável [...]” (Tucum, 2025).

“[...] Você segue a regra do que a sua mãe lhe passa... Ter esses resguardos e cuidados é a nossa saúde física, porque se a gente não cuidar, a nossa saúde física é atingida. Por mais que muitas pessoas queiram negar, é isso que acontece e iremos sofrer com doenças e com enfermidades que vão chegar de forma inexplicável, mas é porque saímos das regras que nos são passadas [...]” (Makira-E'ta, 2025).

Os modos indígenas de pensar e agir em relação aos cuidados com a saúde possuem caráter essencialmente preventivo e diferem significativamente da lógica biomédica dominante na sociedade não indígena (Barreto, 2025)

Destacamos que as mulheres indígenas participantes da pesquisa reconhecem a necessidade de seguir regras e cuidados transmitidos por suas culturas, mesmo diante das influências externas e das exigências impostas pela vida urbana. Segundo os relatos, o não cumprimento dessas regras pode resultar em doenças, dores ou febres consideradas inexplicáveis, interpretadas como sinais de descuido corporal e relacional, o que reforça a importância de manter tais práticas mesmo fora do território tradicional.

[...] E essa talvez seja uma relação de quem vive na cidade e tem muitas atividades e funções. Porque eu acho que a gente hoje vive dois vieses dentro do movimento, um de mulheres que estão no território e outro nós que estamos fora do território, estamos na cidade, eu acho que a gente é tão influenciada pela sociedade, pelo branco que a gente esquece de onde viemos e de que mesmo estando nas cidades devemos seguir as regras e cultura do nosso povo. A gente esquece isso e então essas doenças mostram que você não se cuidou ou se tratou como deveria (Crajiru, 2025).

As falas das participantes evidenciam que a utilização das práticas tradicionais pelas mulheres indígenas no contexto urbano é marcada pela tensão entre o território e a cidade, exigindo o trânsito constante entre lógicas culturais distintas. Como expressa Crajiru, a influência da sociedade envolvente pode levar à flexibilização ou ao esquecimento de regras culturais, com impactos diretos sobre a saúde (Baniwa, 2018; Fontes, 2022).

Essa dualidade se manifesta sobretudo entre as mulheres mais jovens, que relatam dificuldades em manter os cuidados tradicionais diante da rotina acelerada e das múltiplas demandas da vida urbana. Observa-se, assim, que essas práticas não são vivenciadas de forma homogênea, mas variam conforme as trajetórias históricas, as condições comunitárias e os contextos específicos de cada povo. Algumas comunidades conseguem

manter suas práticas culturais de maneira mais contínua e visível, enquanto em outras essas práticas passam a ser vivenciadas de forma mais discreta, em função do ritmo urbano e das múltiplas demandas impostas à vida cotidiana. Ao mesmo tempo, Wará destaca a presença de anciãos como elemento fundamental para a preservação e transmissão dos saberes, mesmo na cidade, evidenciando que a continuidade das práticas tradicionais depende de processos coletivos, da transmissão intergeracional e das condições históricas que atravessam cada comunidade.

Experiências como a da Comunidade Wotchimaüicü são reconhecidas pelas próprias participantes como exemplos de resistência e manutenção das práticas de cuidado, demonstrando que a permanência das tradições no espaço urbano depende de processos coletivos, da transmissão intergeracional e das condições históricas vividas por cada povo.

[...] Eu acho que vivemos realidades distintas, jovens de algumas comunidades que seguem bem a tradição e fico feliz por isso, mas para outros não é essa realidade... Às vezes, o fato da gente estar tão envolvido nessa cidade de pedras, a gente acaba deixando de lado aquilo que foi passado para a gente, eu vejo no contexto geral que acompanho muitos jovens, podem até ouvir, mas não praticam, não usam 100%... é específico, de cada pessoa, de cada povo, dependendo do processo histórico que cada um vive nos centros urbanos, por exemplo, uma realidade bonita a da Comunidade Woichmaucu, que segue e mantém muito bem suas práticas de cuidado[...] (Associação Makira-E'ta, 2024).

Ainda assim, essas participantes demonstram consciência de que a quebra das regras culturais constitui fator de adoecimento e desequilíbrio, o que as leva a retomar os cuidados sempre que surgem sinais de mal-estar, como exemplificado no relato de COPIME, que associa episódios de adoecimento ao descumprimento das orientações maternas relacionadas à menstruação e à alimentação.

“[...] Muitas vezes esqueço de seguir as regras tipo cuidados na menstruação, alimentação, então quando adoço ou surge alguma questão de saúde, vejo que desobedeci o que a minha mãe ensinou...ai volto a ter cuidado [...]” (COPIME, 2025).

O excerto da participante da COPIME evidencia que os cuidados com a saúde, especialmente aqueles relacionados à menstruação e à alimentação, permanecem orientados pelos ensinamentos maternos, mesmo em contextos marcados pelas exigências e rupturas da vida urbana. O “esquecimento” dessas regras no cotidiano é percebido como fator desencadeador do adoecimento, que passa a ser interpretado não apenas como um evento biológico, mas como resultado da desobediência a normas de cuidado transmitidas

intergeracionalmente. Nessa perspectiva, a doença atua como um elemento de alerta e reconexão, mobilizando o retorno às práticas ensinadas pela mãe e reafirmando a centralidade dos saberes familiares na compreensão do processo saúde-doença.

Essa experiência dialoga diretamente com a análise de Oliveira, Nahum-Claudel e Martin (2023), ao destacarem que a construção dos modos de pensar e agir em relação à saúde implica buscar inspiração em pais, mães, avós e avôs, revelando que as pessoas pensam com seus anciãos, mesmo quando os desafiam. A fala da participante expressa justamente esse movimento: há tensão, esquecimento e questionamento, mas não ruptura. Os ensinamentos dos mais velhos seguem como referência estruturante, sendo constantemente revisitados e reinterpretados, em um processo atravessado por implicações de gênero, no qual as mulheres assumem papel central na transmissão, vivência e atualização desses cuidados.

Por outro lado, observou-se que, em algumas comunidades, como Wotchimaucu, há uma preservação mais consistente e contínua das regras e práticas de cuidado fundamentadas na cultura Tikuna, evidenciando possibilidades concretas de manutenção dos modos tradicionais de cuidar mesmo diante das transformações impostas pelo contexto urbano. A permanência dessas regras depende diretamente da transmissão intergeracional dos saberes femininos.

Essas práticas estão intrinsecamente vinculadas à cosmovisão indígena, na qual saúde e doença são compreendidas como expressões do equilíbrio entre humanos, natureza e seres espirituais (Barra; Dias, 2012; Descola, 2014; Fellipe, 2022 e Barreto, 2022, 2025). Açaí, da Comunidade Wotchimaucu, acredita que o descuido das regras de saúde da mulher que vive na cidade, durante, por exemplo, a menstruação e pós-parto, é um fator causador do alto índice de doenças relacionadas à saúde da mulher.

“[...] Porque hoje em dia tem mulheres que começam a sofrer cedo, com o útero todo destruído, porque não se cuidam, não fazem resguardo e os cuidados que deve ter no resguardo [...]” (Açaí).

Segundo Viveiros de Castro (1987), entre os Yawalapíti, o corpo humano é concebido como uma construção cultural, produzida por meio do cumprimento de regras, rituais e comportamentos socialmente prescritos, sendo a reclusão um momento central de transformação corporal e social. Essa compreensão articula-se à concepção indígena de ambiente analisada por Descola (2014), Fellipe (2022) e Barreto (2022), segundo a qual o território constitui um campo relacional habitado por humanos e não humanos

dotados de agência, como plantas, animais, astros e ventos, sendo cada território protegido por seus donos e guardiões espirituais.

Nesse sentido, muitas enfermidades são atribuídas a ações realizadas sem os devidos cuidados ou benzimentos de proteção, como nas atividades de pesca e na manipulação e preparo de peixes, que exigem regras específicas de conduta e respeito aos entes que habitam os mundos aquático e subterrâneo (Barra e Dias, 2012; Barreto, 2022). Assim, tanto o corpo quanto o ambiente são regulados por normas cuja violação pode gerar desequilíbrios manifestados em doenças ou escassez de alimentos, evidenciando que o respeito às regras culturais constitui elemento central na produção da saúde indígena.

- d) Transmissão transgeracional - Conhecimentos de saúde passados de geração a geração/As regras de saúde da mulher indígena ensinadas de geração em geração:

Considerado uma forma importante na transmissão de cuidados à saúde, mas também como uma demonstração de amor incondicional por parte das ancestrais, bem presente na frase da língua Tukano como uma expressão comum usada pelas avós: “mi’îre ma’îgo werêgo weé, makó! Eu te sovino tanto que te ensino (aconselho), filha” (Oliveira, Nahum-Claudel e Martín, 2023). O termo sovinar aqui significa uma forma carinhosa de cuidado, apego e gostar muito. Contar e ouvir narrativas e conselhos das avós possui, assim, uma grande relevância na transmissão, entre gerações, de cuidados à saúde e amor. Ressaltado por Oliveira, Nahum-Claudel e Martín (2023) e Ramos (2019) ao interrelacionar conhecimentos, conselhos, corpo e saúde e a importância da luta das mulheres indígenas para o seu povo, relacionada ao sustento da família além da criação dos filhos, assim como a transmissão de valores e conhecimentos.

A transmissão transgeracional desse conhecimento foi citada por todas as mulheres participantes. Esse saber é passado pelas anciãs da comunidade, avós e mãe, demonstrando o protagonismo feminino no ato de cuidar da saúde dessa população que inicia ainda na fase precoce.

Figura 26: Corpos - Territórios Indígenas em Resistência.



Fonte: Baniwa; Kaingang e Mandulão, 2023.

O cuidado com a saúde é ensinado desde cedo, principalmente pelas mães e anciãs (Figura 26), começando antes mesmo da menarca. As práticas são passadas de geração em geração, reforçando a importância da tradição e respeito a regras e resguardos culturais. (Baniwa, 2018; Fontes, 2020) Há um forte padrão de seguir regras específicas durante a menstruação, gravidez e outros momentos da vida feminina, como evitar certos alimentos, atividades ou lugares. O descumprimento delas é associado ao surgimento de doenças ou complicações de saúde (Dias-Scopel, Scopel e Langdon, 2017).

“Aprendi esses cuidados com minha avó, minha mãe e tias paternas. Esses ensinamentos são feitos principalmente através da oralidade e também, conforme fui crescendo, através da prática, fui observando e depois praticando” (Centro de Medicina Indígena, 2025).

Por isso, a saúde depende, para as participantes, da preservação dos ecossistemas, da disponibilidade de recursos naturais e da manutenção de hábitos tradicionais. Nesse sentido, as ações e políticas de saúde devem estar alinhadas às culturas indígenas e às formas próprias de organização social, reconhecendo que o cuidado só é pleno quando respeita e fortalece esses vínculos (Ahmadpour et al., 2023). Uma tensão recorrente aparece nos relatos sobre as diferenças entre viver no território tradicional em relação à cidade. Esta dualidade cria desafios específicos para manter as práticas de saúde tradicionais em contextos urbanos, onde a influência da sociedade não-indígena pode levar ao esquecimento das regras culturais (Baniwa, 2018; Fontes, 2020).

A migração para cidades introduz novos desafios e conflitos de viver "entre dois mundos", termo utilizado no grupo focal por Crajiru ao debater sobre a influência do

mundo citadino e a preservação das regras e comportamentos baseados na cultura de seu povo, e diferenças em território tradicional e o espaço urbano. Esses relatos evidenciam como a ruptura com modos de vida tradicionais gera vulnerabilidades sanitárias específicas (Farias et al., 2022).

[...] Me lembro que quando a mulher menstruava ...não tomava banho depois das 18 horas, era o resguardo dela, de proteção e cuidado com a saúde dela, mas hoje não, se você fala isso para uma jovem, elas mostram as mídias e pesquisas dizendo outras coisas. Eu acho uma falta de respeito às práticas indígenas [...] (Copaíba, 2025).

[...] Assim que a gente deve seguir e principalmente quando vamos virar mulher, quando a gente se torna uma moça e mãe. Essa concepção tanto faz o povo tukano como o povo baniwa também segue a mesma linha com algumas diferenciações... O conceito de saúde hoje que eu passo para as minhas filhas é isso[...] (Crajiru, 2025).

Segundo Rodrigues et al. (2012, apud. Albuquerque, 2020), embora as narrativas históricas e a cosmologia indígena desempenhem um papel social central na organização da vida e na produção de sentidos sobre o mundo, em contextos urbanos esses saberes tendem a ser desvalorizados. Afirma que, entre indígenas migrantes na cidade, o contato com universos sociais e culturais distintos daqueles vivenciados nas regiões de origem ou de fronteira faz com que os conhecimentos cosmológicos e as falas dos mais velhos sejam, por vezes, interpretados como exagero, superstição ou levandade, revelando tensões geracionais e culturais produzidas pela experiência urbana. Copaíba evidencia essa preocupação em relação aos mais jovens:

[...] Quer dizer que as mídias também contribuem para isso, essa questão do enfraquecimento das práticas tradicionais hoje... se você fala isso para uma jovem, elas mostram as mídias e pesquisas dizendo outras coisas. Eu acho uma falta de respeito às práticas indígenas [...] (Copaíba, 2025).

Conforme as narrativas de várias mulheres participantes, a maioria dos jovens demonstra desinteresse e até descaso sobre as práticas tradicionais de cuidado, dando uma conotação de ultrapassado e associam esse fenômeno à vergonha e ao receio de sofrer discriminação, assim como a influência das mídias como fator distanciador da cultura indígena, contexto abordado por Albuquerque (2020).

Em consonância com os objetivos deste estudo, o cuidado com o corpo e a preservação da saúde das mulheres indígenas estão profundamente vinculados à transmissão intergeracional de saberes, que se mantém como prática de resistência frente às violências históricas do processo colonizatório (Aurora, 2019, Baniwa, 2018). Embora

marcados por uma retórica de silenciamento, esses conhecimentos não deixam de ser vividos e transmitidos, sobretudo por meio da oralidade e das práticas cotidianas, muitas vezes no espaço doméstico, inclusive em contextos urbanos (Aurora, 2019).

[...] Então temos muitas regras assim desde pequenas, mas assim que a gente deve seguir, principalmente quando vamos virar mulher, quando a gente se torna uma moça e mãe. Essa concepção tanto faz o povo tukano como o povo baniwa também segue a mesma linha com algumas diferenciações... O conceito de saúde hoje que eu passo para as minhas filhas é isso [...] (Crajiru, 2025).

As mulheres mais experientes destacam que saúde e bem-estar estão intrinsecamente relacionados à alimentação, aos cuidados corporais e à continuidade dos conhecimentos recebidos na formação indígena, os quais devem ser ensinados onde quer que se esteja, reafirmando o papel central das mulheres na sustentação da vida coletiva (Baniwa, 2018), como destacado na fala de Copaíba (2025): “[...] na verdade, a mulher tem uma grande responsabilidade... isso acontece desde cedo, são conselhos, são asseios, é interessante isso porque é todo um cuidado, é espiritual, não pode separar isso, é um conjunto, é uma forma de viver [...]”.

Andiroba demonstra essa relação ao afirmar que sua mãe a chamou para conversar próximo a vivenciar sua menarca e explicou a conduta a ser seguida de acordo com sua cultura e, por isso, associa sua gravidez de risco e complicações no parto ao fato de burlar essas regras ensinadas pela mãe. Esta prática, conhecida como resguardo, envolve restrições alimentares, comportamentais e espaciais durante o período menstrual, como observado a seguir:

[...] Na 1ª menstruação, a minha mãe me chamou para conversar e falou um monte de coisa que eu não poderia fazer, tipo não varrer a casa, ele não deixava eu comer comida remosa tipo porco, tambaqui por ser gordo, só podia comer galinha caipira. Ela fala que se eu não cuidasse dessa forma, eu teria problemas no parto, então que tinha certas coisas que eu não poderia fazer [...] (Andiroba, 2025).

Problemas no parto citados por Andiroba foram associados a regras burladas e a hábitos inadequados na cidade, como, por exemplo, a falta de repouso necessário e as dificuldades financeiras para obtenção de uma alimentação adequada.

Nesse sentido, como aponta Fontes (2020), as mulheres atuam como verdadeiras “diplomatas étnicas”, estabelecendo elos entre povos e clãs distintos por meio do parentesco e do casamento, ao mesmo tempo em que asseguram a circulação e a continuidade dos saberes. A autora ressalta ainda que a ausência de registros escritos das

experiências das mulheres mais velhas contribui para o risco de apagamento desses conhecimentos, tornando fundamental que as próprias mulheres indígenas, inclusive no espaço acadêmico, registrem suas histórias, práticas educativas e saberes, que podem ser narrados e ensinados em quaisquer territórios (Fontes, 2020).

As autoras ressaltam que as mulheres ampliam sua força coletiva e cuidam melhor da qualidade do ensino repassado às crianças, reafirmando que a saúde, o bem-estar e a continuidade do povo dependem da transmissão dos saberes recebidos na formação indígena, os quais estruturam o cuidado, a proteção e a vida coletiva (Baniwa, 2018; Fontes, 2020).

De forma convergente, Barreto (2025) enfatiza que, além do cuidado com o território e com os seres que nele habitam, as mulheres desempenham papel central na saúde materno-infantil e na transmissão de conhecimentos essenciais ao bem-estar comunitário.

As narrativas de Copaíba e de Comunidade Waikuru reforçam esse entendimento ao evidenciarem que os saberes sobre saúde, cura e prevenção são ensinados de avós e mães para filhas:

“[...] Na verdade, a mulher tem uma grande responsabilidade, ela que dá continuidade desses conhecimentos para os mais novos...não apenas os conselhos, porque para nós indígenas é muito mais a prática, as formas, as atitudes, as ações [...]” (Copaíba, 2025).

“[...] Porque a gente ia plantando e a minha avó ia vendo como que a gente cavava, como que a gente jogava a mandioca, se a gente jogava errado ela pedia para a gente corrigir e fazer tudo de novo [...]” (Comunidade Waikuru, 2025).

“[...] Somos ensinados pelas anciãs, logo no primeiro ciclo da menstruação, aí que começa a nossa vida da saúde da mulher [...]” (Wará, 2025).

Os relatos de COPIME e Tucumã mostram como a confiança é reforçada pela tradição e pela experiência familiar:

“[...] Uso muito, muito por causa da minha mãe, e isso vou levar para vida, é o que eu tenho, remédios, os banhos, ela faz muitos banhos também, para gripe, mal-estar, enjoo, para proteção das crianças... usa muitas plantas [...]” (COPIME, 2025).

“[...] Tudo isso aprendi com minha mãe e minha avó, que também fazia muito remédio caseiro... ela era muito adepta dos remédios tradicionais...” (Tucumã, 2025).

Nesse contexto, as participantes do estudo destacam que o conhecimento sobre saúde, cura e prevenção passados intergeracionalmente envolve conselhos, observação cotidiana e participação em práticas e rituais, confirmando como a observação do fazer e a oralidade são conceitos importantes na educação dos mais jovens e a preservação da saúde indígena feminina ensinada pelas mais velhas. Evidencia como a mulher exerce grande responsabilidade em dar continuidade a esses conhecimentos para os mais novos (Baniwa, 2018; Abritta, 2021; Fontes, 2022).

Em consonância com Pereira (2018) ao se referir como mecanismos sociais que favorecem a manutenção dos laços sistemáticos de indígenas com a aldeia e a afirmação de sua identidade étnica na cidade, preservando aspectos do modo de vida apreendido no território de origem como o uso da língua e dos rituais, socialização dos filhos com as lendas e danças, confecção de artesanatos, prática os hábitos alimentares, recepção de parentes vindos para a cidade e manutenção de contato com parentes que ainda moram no território indígena de origem são indicadores do pertencimento étnico.

e) Menstruação e seus significados na saúde da mulher indígena:

Conforme objetivos deste estudo, que buscam descrever a percepção das mulheres indígenas sobre o processo saúde-doença e analisar as práticas tradicionais de cuidado em contexto urbano, a menstruação emerge como eixo importante na preservação da saúde feminina. Nos estudos de Soares (2019), sobre os Karipuna do Amapá, a menstruação é compreendida como um momento formativo e relacional, no qual o sangue menstrual atua como fluido transformador que exige resguardos específicos para proteger o corpo nas relações com seres não humanos e com o território. Esses cuidados expressam um acordo relacional entre mulheres participantes, território e cosmos, cuja ruptura pode gerar adoecimentos e vulnerabilidades.

Entre diferentes povos indígenas, o período menstrual é vivido como um tempo de recolhimento e de cuidado do corpo e do espírito, em que as mulheres seguem regras específicas sobre alimentação, repouso e contato social (Dias-Scopel, Scopel e Langdon, 2017; Oliveira, Nahum-Claudel e Martín, 2023). Esse conjunto de práticas, denominado como resguardo, resguardo menstrual ou tempo de se guardar, compõe um sistema de conhecimentos e ações coletivas voltadas à proteção e equilíbrio da mulher e da comunidade (Baniwa, 2025).

Em estudo etnográfico sobre práticas de saúde e corporalidade feminina, Dias-Scopel e Scopel (2019) destacam que o resguardo e as regras menstruais se relacionam à

cosmologia e à ecologia local, marcando a conexão entre o corpo da mulher e o ambiente. Durante o resguardo, há restrições quanto à pesca, alimentação e trabalhos pesados, não como forma de isolamento negativo, mas como um processo de cuidado preventivo e regenerativo.

[...] O meu corpo tem regras, então não posso sair por aí, por exemplo, quando estou menstruada, tomar um banho de rio, ter contato com cachoeiras, com pedras, porque esses lugares têm donos, donos da natureza que eles podem não gostar de estar sujando a casa deles com o meu sangue (Tucum, 2025).

Assim, o resguardo menstrual, entendido em seus próprios termos culturais, pode ser considerado uma tecnologia de cuidado indígena, na medida em que traduz um conhecimento sistematizado sobre o corpo e suas relações com o mundo, sustentado por práticas coletivas, redes de apoio e significados compartilhados (Barreto, 2025; Baniwa, 2025). Longe de uma prática restritiva, o resguardo é uma forma de produzir saúde, equilíbrio e continuidade da vida e está profundamente ligado ao cumprimento de regras culturais e envolve períodos menstruais, gravidez e pós-parto (Barreto 2025, Baniwa 2025, Oliveira, 2023, Aurora, 2018).

“[...] E se não fazer esse processo de bahsesé pode acontecer várias coisas, por isso que falam que os seres encantados podem estar atentos querendo fazer mal... somente após o bahsesé que eu tomei banho, comi alguma coisa, pode comer normalmente, mas com bahsesé [...]” (Centro de Medicina Indígena, 2025).

“[...] Não pode ir para o rio tomar banho. Minha mãe sempre fala que, quando estiver menstruada, não pode ir para o porto, ir para a floresta, ir para qualquer lugar [...] tem que ter resguardo também por causa dos encantados. Tem que evitar de ir na roca ou em qualquer outro lugar, e podemos ficar com dor de cabeça, dores no corpo [...]” (Maniva, 2025).

Cuidados específicos durante o período menstrual constituem uma das ideias mais consistentemente repetidas nos relatos. Práticas como evitar certos alimentos, não tomar banho de rio menstruada ou não entrar na mata nesses períodos são vistas como essenciais para evitar doenças e garantir a recuperação plena. Essas regras, transmitidas intergeracionalmente, combinam prevenção fisiológica, como por exemplo evitar infecções, e proteção espiritual, como afastar seres encantados (Baniwa, 2025, Barreto 2025).

“[...] A minha mãe falou que eu me formei, aí que ela me guardou e me falou o que eu não podia comer, nenhuma fruta azeda... não pode pisar na terra quente ou comer tudo que apodrece porque senão podemos ter doenças mais tarde [...]” (COPIME, 2025)

“[...] Na menstruação, não pode pegar sol, pisar na escama do peixe, porque pode dar mioma, câncer [...]” (Saratudo, 2025).

“[...] Ficava no quarto e pegava água que traziam do rio para poder fazer a higiene, mas não podia ir para o rio, ninguém podia ver a gente, então todo mundo já sabia que a gente se formou. Esses cuidados eram feitos para vir a menstruação em só três dias [...]” (Saratudo, 2025).

“[...] Sempre tinha que tomar banho antes das seis por causa dos encantados e a gente já era mocinha, então a gente tinha esse cuidado com os encantados para não fazer mal a gente, até hoje eu tenho ainda esses cuidados porque eu também passei por todos esses cuidados da primeira menstruação, isolamento, cuidados com alimentos [...]” (Comunidade Waikiru, 2025).

A transgressão desses preceitos é associada a complicações na saúde da mulher, como as obstétricas. As mulheres relatam sintomas físicos (dores, febre, complicações no parto) interpretados como consequência direta do descumprimento das tradições (Tassinari, 2021), conhecido por muitos como mãe do corpo, como se observa na fala de COPIME (2025) a seguir: “[...] na menstruação eu tive resguardo, não se pode ficar muito tempo com a barriga molhada, no frio, porque depois pode desenvolver uma doença chamada de mãe do corpo. Que é uma dor que a mulher sente, fortes dores, muito pior que uma cólica, é muito mais que isso [...]”.

Conforme se percebe, o relato de COPIME estabelece relação com achados de Tassinari (2021), em seus estudos com mulheres indígenas, onde a noção de mãe do corpo (Figura 27) não se restringe ao útero como órgão anatômico, mas corresponde a uma força vital e pulsante que sustenta a saúde feminina, sendo compreendida como a essência e a força da mulher, essencial para a manutenção da saúde e fertilidade (Neres, 2026). A autora afirma ainda que, segundo mulheres indígenas, a mãe do corpo cresce durante a gestação, acompanhando o desenvolvimento do feto, e que, após o parto, necessita de cerca de quarenta dias para recuperar e retornar ao seu tamanho e lugar originais, o que fundamenta a importância da quarentena como período indispensável de cuidado e cura.

Figura 27: A “mãe do corpo”, entre o visível e o invisível.



Fonte: Lobo, 2026.

De modo convergente, Scopel (2014) observou entre as mulheres Mundurucu que a mãe do corpo é central para o bem-estar cotidiano e para o parto, sendo entendida como uma forma de saúde da mulher que exige cuidados específicos, como a prática de “puxar a mãe do corpo”, fundamental para a realização de um bom parto, como observado na fala de Makira-E'ta (2025): “[...] minha tia, quando eu estava grávida... ajeitava a minha barriga, fazia alguma coisa pra eu tomar, fazia um chá, usava algumas folhas... para ter um bom parto”.

Durante a menarca, também há rituais e práticas como banhos, cortes de cabelos, como exemplifica abaixo por Saratudo, que possuem objetivos de renovação corporal, capacidade na retenção de conhecimentos e recebimento de energias do meio ambiente (Oliveira, Nahum-Claudel e Martín, 2023), assim como representam importantes técnicas corporais constituintes do processo de tornar-se uma mulher adulta em determinadas culturas indígenas. Conforme Saratudo (2025), “[...] minha mãe também cortava todo nosso cabelo, todo feio, como se fosse um ritual, esse corte significa que tinha “se formado”, um sinal de que a mulher se formou [...]”.

Segundo Belaunde (2006), no território amazônico, sangrar é a "troca de pele/corpo" e são as mulheres, em suas regras e no nascimento da criança, as responsáveis por esse acontecimento.

Além do relato de Saratudo vivenciado na sua menarca, outros relatos colhidos sobre rituais corporais nessa mudança de troca de corpo na menarca, como o descrito por

uma participante Tikuna ao lembrar como, no seu território de origem, os cabelos da menina eram arrancados simbolizando o “nascimento” de uma nova mulher a partir do crescimento de novos fios de cabelo; assim existindo aquém e além da pessoa, o sangue a conecta à vida, mas igualmente às possibilidades de social (Filino, 2019).

A vivência da menstruação fora dos territórios indígenas, especialmente nas cidades, impõe às mulheres indígenas um desafio na preservação de seus modos tradicionais de cuidado. Oliveira, Nahum-Claudel e Martín (2023) destacam que não há uma linearidade histórica quanto à continuidade ou descontinuidade dessas práticas, pois muitas mulheres na Amazônia ainda tomam “o tempo para sentar e sangrar”, vivenciando o período menstrual como um retiro silencioso e um momento de reconstrução do corpo e do espírito.

No entanto, segundo os autores, com contato com sociedades não indígenas, ao deslocarem-se para contextos urbanos, essas práticas tornam-se difíceis de serem mantidas, tanto pelas condições materiais, como trabalho assalariado, quanto pelas imposições socioculturais, acesso a tecnologias de reprodução biomédica na regulação de corpos femininos e práticas em torno da menstruação que desvalorizam os saberes tradicionais. Como observa Baniwa (2018), a colonização e a imposição de padrões externos sobre os corpos das mulheres indígenas estão modificando e surpreendentemente desestruturando práticas tradicionais de cuidado, produzindo rupturas nas relações de pertencimento entre corpo, território e saúde.

Essa dissociação entre território e cidade, perda do equilíbrio mente-corpo-território-cosmos se intensifica nos espaços urbanos, onde o ritmo acelerado da vida cotidiana dificulta o recolhimento e a escuta do próprio corpo, comprometendo práticas de cuidado fundamentais (Oliveira, Nahum-Claudel e Martín, 2023). Ainda assim, segundo os autores, tais condutas, quando preservadas ou adaptadas, fortalecem a autoconfiança e a autodeterminação das mulheres, elementos centrais para a saúde integral e para o reconhecimento de seus corpos e saberes, especialmente considerando que elas transitam por redes complexas de sujeição e hierarquias no interior das famílias, comunidades e nas relações com a sociedade envolvente (Rosas, 2018).

[...] Então, quando eu to menstruada, eu fico mais em casa, eu não gosto de sair, quando eu to assim, então eu não atendo ninguém que vai lá na comunidade, ... Não é porque eu não quero, mas é uma questão cultural minha mesmo, então eu mantenho. Geralmente, eu fico em casa, não saio porque já me foi passado essas práticas. Nesses dias, a minha sobrinha atende à comunidade (Wará, 2025).

Destacamos a importância desse cuidado à saúde praticado por Wará, que estabelece relação com Gottlieb (2020, p. 153) ao destacar que, mesmo em contextos adversos, muitas mulheres buscam manter formas mais desaceleradas de lidar com a menstruação e períodos de repouso, evidenciando a necessidade de estratégias de adaptação que promovam saúde, autonomia, mobilidade e acesso à educação, respeitando-as como sujeitos e integrantes de suas comunidades.

No contexto urbano, as mulheres continuam praticando resguardos, mesmo que de maneira silenciosa ou adaptada. Entre os Baniwa, por exemplo, práticas de cuidado ligadas ao corpo foram historicamente silenciadas por processos de colonização religiosa, que deslegitimam rituais femininos, inclusive os referentes à menarca e ao uso de cosméticos e remédios tradicionais, classificando-os como “coisas do diabo” e violando o direito das mulheres de exercer seus conhecimentos ancestrais (Baniwa, 2019).

Apesar das pressões externas, as mulheres no contexto urbano continuam mantendo resistências, mesmo que de maneira silenciosa ou adaptada, preservando práticas básicas como o uso de remédios naturais e cuidados corporais como o resguardo transmitido entre gerações, como abordado nas falas da Comunidade Waikiru:

[...] Sempre tinha que tomar banho antes das seis por causa dos encantados para não fazer mal a gente, até hoje eu tenho ainda esses cuidados porque eu também passei por todos esses cuidados da primeira menstruação, isolamento, cuidados com alimentos, de tudo... eu não saio porque já me foi passado essas práticas [...] (Comunidade Waikiru, 2025).

Entre os saberes transmitidos, os cuidados menstruais surgem como aspecto relevante da saúde da mulher indígena.

As narrativas das participantes evidenciam que os cuidados com o corpo feminino, transmitidos intergeracionalmente e vivenciados desde a menarca, extrapolam a dimensão preventiva, estando diretamente associados ao fortalecimento corporal, à proteção espiritual e à preparação para a gestação e o parto (Dias-Scopel, Scopel e Langdon, 2017; Oliveira et al., 2023). Esses cuidados integram uma concepção ampliada do processo saúde-doença, na qual os ciclos corporais femininos são compreendidos como elementos centrais para a manutenção do equilíbrio entre corpo, território e cosmos, inclusive no contexto urbano.

Entretanto, conforme destacam Oliveira, Nahum-Claudel e Martín (2023), a migração para a cidade e a biomedicalização da saúde reprodutiva vêm transformando essas práticas, produzindo processos de intermedicalização marcados por encontros,

negociações e tensões entre sistemas terapêuticos distintos. No âmbito dos programas de saúde da mulher ofertados pelo SUS, noções biomédicas de higiene, controle do sangramento e a oferta de tecnologias de supressão menstrual tendem a reforçar um modelo que, muitas vezes, desconsidera os significados cosmológicos do sangue para os povos indígenas, especialmente em contextos urbanos.

Os dados empíricos permitem analisar como a atuação da Atenção Primária à Saúde (APS), associada à migração urbana e à biomedicalização, tensiona esses saberes ao deslocar o sentido da menstruação de marcador relacional e cosmológico para um fenômeno fisiológico a ser controlado (Oliveira et al., 2023).

Os relatos das participantes indicam que o não reconhecimento desses resguardos e ciclos nos serviços de saúde pode gerar constrangimentos, adoecimentos percebidos e rupturas simbólicas, contribuindo para processos de deslegitimação dos saberes tradicionais e de violência epistemológica sobre os corpos das mulheres indígenas (Baniwa, 2018).

As experiências relacionadas ao uso de contraceptivos e à menstruação, conforme evidenciam as falas, são heterogêneas e atravessadas por diferenças geracionais, culturais e pelas exigências da vida citadina. Entre as mulheres mais velhas e de algumas comunidades, a menstruação permanece fortemente vinculada a concepções cosmológicas e corporais, nas quais o cumprimento dos resguardos menstruais é entendido como fundamental para a manutenção do equilíbrio do corpo, da fertilidade e da saúde, sendo o uso de contraceptivos hormonais frequentemente associado a riscos, adoecimentos e à ruptura de cuidados tradicionais.

Essa perspectiva é expressa nas falas de Jambu e Wará, que valorizam o uso de remédios caseiros, garrafadas e práticas herdadas das mulheres mais velhas, ao mesmo tempo em que reconhecem a circulação e o uso dos métodos biomédicos entre as mais jovens, especialmente em função do desejo de estudar, trabalhar e organizar a vida reprodutiva.

“[...] Eu tomei anticoncepcional por um período, mas achei melhor usar nossos remédios caseiros. Minha mãe acha que anticoncepcional é veneno, ela acha que é melhor com nossos cuidados tradicionais, mas as meninas da comunidade usam porque querem estudar, mas também querem ter a sua vida particular sexual, mas o importante é que seja bem explicado o seu uso e cuidados [...]” (Wará, 2025).

“[...] Eu nunca usei anticoncepcional, sempre usei remédio caseiro, uso garrafada [...]” (Jambu, 2025).

Por outro lado, mulheres mais jovens relatam não perceber conflitos entre o uso de contraceptivos hormonais, a supressão da menstruação e suas concepções de cuidado, compreendendo essas tecnologias como estratégias de autonomia reprodutiva e de gestão do cotidiano urbano, marcado por jornadas de trabalho, estudos e limitações de tempo. Como evidencia a narrativa de Tucumã, a utilização de métodos como o dispositivo intrauterino (DIU) não representa o abandono dos saberes indígenas, mas uma negociação situada entre práticas tradicionais e recursos biomédicos, acionados conforme as necessidades do momento de vida. Segundo Tucumã (2025), “[...] para mim não há conflito entre as medicinas, como vivo na cidade e preciso trabalhar, estudar, organizar e planejar a questão familiar, os cuidados para não engravidar que a UBS fornece é muito importante, eu já utilizei DIU, antes de decidir engravidar [...]”.

Assim, as narrativas revelam que a experiência da menstruação e do cuidado com o corpo feminino não é homogênea entre as mulheres indígenas, atravessada por geração, contexto urbano e demandas da vida contemporânea, o que reforça a necessidade de abordagens sensíveis à diversidade de trajetórias no âmbito da APS intercultural.

Dessa forma, a análise das falas confirma que a concepção de saúde da mulher indígena é indissociável das relações entre corpo, território e cosmos, e que a APS, enquanto principal porta de entrada no SUS (Brasil, 2012), ocupa papel estratégico na mediação entre sistemas de saberes. Esse encontro pode produzir acolhimento e diálogo, mas também novas camadas de violência simbólica, quando os profissionais desconhecem ou desconsideram os significados da menstruação, dos resguardos e dos ciclos corporais próprios de cada povo, reforçando formas de colonialidade que incidem de maneira particular sobre os corpos femininos indígenas (Aurora, 2019).

Reconhecer os resguardos menstruais e os significados cosmológicos do sangue não implica incorporar rituais aos serviços, mas garantir um cuidado intercultural que respeite as formas de vida e os saberes das mulheres indígenas, fortalecendo a integralidade da atenção e evitando a deslegitimação de práticas tradicionais fundamentais para a produção do bem-viver em contextos urbanos (Dias-Scopel, Scopel e Langdon, 2017).

As práticas tradicionais de cuidado das mulheres indígenas, que atravessam os diferentes ciclos de vida, menarca, menstruação, gestação, parto, pós-parto, envelhecimento e luto, configuram sistemas complexos de regulação corporal e espiritual. Esses sistemas, práticas de autoatenção, envolvem rituais de resguardo, uso de plantas

medicinais, benzimentos, dietas e restrições associadas ao manejo dos fluxos corporais, conectando corpo, território e relações com humanos e não humanos (Barreto, 2025; Baniwa, 2018; Baniwa, 2025; Dias-Scopel, 2019; Oliveira et al., 2023).

Esses elementos revelam que a concepção de saúde-doença da mulher indígena se estrutura em redes relacionais que exigem diálogo intercultural.

A análise das narrativas confirma que a concepção de saúde da mulher indígena é indissociável das relações entre corpo, território e cosmos, configurando um sistema próprio de produção e manutenção da vida que antecede e ultrapassa a lógica biomédica. Esses modos de compreender e praticar o cuidado não se apresentam como saberes isolados, mas como sistemas organizados de atenção à saúde, sustentados por regras, resguardos, transmissão intergeracional de conhecimentos e práticas coletivas.

É nesse ponto que se estabelece a interface com a Atenção Primária à Saúde, uma vez que as mulheres indígenas, mesmo em contexto urbano, não abandonam esses referenciais ao acessar os serviços do SUS, mas os articulam a outras formas de cuidado. Compreender essa articulação é fundamental para analisar como se produz, no cotidiano, o encontro entre a medicina indígena e a assistência ofertada pela APS, tema que será aprofundado no capítulo seguinte.

4.3. INTERFACE ENTRE AS PRÁTICAS INDÍGENAS DE CUIDADO E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM CONTEXTO URBANO

4.3.1 Reconhecimento identitário e apagamento institucional

“Ah, você é indígena, está querendo me enganar?” (Copaíba, 2025).

“Ah, esses índios de agora!” (Tucumã, 2025).

Figura 28: Encontro intergeracional de mulheres indígenas em espaço urbano.



Fonte: Ilustração produzida por Thais Sarmento Fernandes, do povo Dessana, especialmente para esta pesquisa, 2025.

Na cosmovisão indígena, a doença não se configura como um evento isolado do corpo, mas como um sinal de desarmonia no fluxo do mundo, demandando intervenções que consideram tempos, territórios e relações.

Reconhecer essa lógica, como destaca Barreto (2025), implica admitir outras epistemologias de cuidado e formas de sistematização do conhecimento que escapam à lógica da escrita e da objetividade biomédica, uma vez que o maior desafio reside na abertura para modos legítimos e diversos de compreender o cuidado, a cura e a própria vida no mundo (Figura 28).

Nesse contexto, a Figura 28 representa o encontro entre mulheres indígenas de diferentes gerações em espaço urbano, simbolizado pela presença do Teatro Amazonas e a árvore. O tecido apresenta grafismos da Cobra Canoa, associados à origem e ao transporte da vida, enquanto a árvore traz grafismos presentes na cerâmica. A moldura do desenho utiliza o grafismo da jararaca, símbolo de proteção, compondo uma cena de troca de conhecimentos sobre corpo, cuidado, memória e saúde da mulher indígena.

Nesse cenário, a interface entre as práticas tradicionais de cuidado das mulheres indígenas e a assistência ofertada na Atenção Primária à Saúde (APS) revela-se atravessada por desigualdades históricas, sociais e institucionais, que frequentemente

produzem apagamentos, silenciamentos e deslegitimação de saberes (Langdon e Garnelo, 2017; Lorenzo, 2011; Diehl e Langdon, 2015).

A análise das narrativas evidencia que essa interface não se expressa de forma homogênea, mas pode ser compreendida a partir de diferentes dimensões que atravessam a experiência das mulheres indígenas nos serviços de saúde, iniciando pelo reconhecimento ou pela negação de sua identidade nos espaços institucionais.

No campo das políticas públicas, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída com o propósito de garantir o acesso dos povos indígenas à atenção integral à saúde, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando sua diversidade social, histórica, cultural, territorial e política. Estudos como os de Ahmadpour et al. (2023) reforçam que a concepção indígena de saúde está profundamente vinculada ao território e às condições ambientais que sustentam os modos de vida, as práticas culturais, as relações sociais e espirituais. Nesse sentido, a saúde não se restringe à dimensão biológica, mas envolve um conjunto ampliado de relações que estruturam o viver indígena.

A saúde indígena não é um campo autônomo, pois se articula à cosmologia, à organização social e às formas locais de poder, historicamente atravessadas pelo processo colonizatório. Nos povos amazônicos, predomina o poder local, com lideranças sem poder coercitivo, cuja legitimidade se baseia na mediação, na reciprocidade e nas relações de parentesco (Garnelo e Sampaio, 2003).

Segundo Melo, Sant’Ana, Bastos e Antônio (2021), a colonialidade opera como um processo histórico de hierarquização dos saberes, que deslegitima medicinas indígenas e tradicionais no campo da saúde, tratando-as como crendices e produzindo tensionamentos entre sistemas de cuidado. Articulado a isso, o racismo estrutural atua ao impor uma concepção eurocêntrica de corpo e saúde, invisibilizando necessidades específicas de populações indígenas e desqualificando políticas de reconhecimento sob a acusação de “racialização”, o que aprofunda desigualdades no acesso e na qualidade da atenção. Nesse contexto, a interculturalidade emerge como conceito central para compreender as relações, práticas e processos comunicativos estabelecidos entre culturas indígenas e ocidentais na atenção à saúde, apontando para a necessidade de abordagens que reconheçam a cosmovisão indígena como fundamento do cuidado integral.

A Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) é responsável pela coordenação e execução da PNASPI no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), articulando-se com as demais esferas do SUS para garantir uma atenção integral e

diferenciada, observando as especificidades étnicas, culturais, territoriais e epidemiológicas (Brasil, 2024). As Equipes Multidisciplinares de Atenção Básica à Saúde Indígena (EMSI), instituídas pela Portaria nº 1.088/2005, devem atuar de forma integrada, com clientela adscrita e território definido, respeitando necessidades epidemiológicas e contextuais (Brasil, 2005). Mais recentemente, o processo de revisão da PNASPI tem sinalizado avanços ao reconhecer e valorizar as medicinas indígenas e as práticas ancestrais como componentes legítimos do cuidado em saúde (Brasil, 2025).

Nesse cenário, a política de saúde indígena, ao instituir o Subsistema sob o princípio da atenção diferenciada, busca articular o SUS às práticas tradicionais e ampliar a participação indígena. Contudo, ao adotar modelos institucionais ocidentais de participação, emergem tensões que limitam o exercício pleno e autônomo dos direitos indígenas, especialmente no nível local (Diehl e Langdon, 2015).

A APS, enquanto principal porta de entrada do SUS, ocupa posição estratégica nesse contexto, sendo responsável por ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado integral, orientadas pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade (Brasil, 2012). Contudo, a análise empírica deste estudo evidencia que, na prática, a inter-relação entre APS e mulheres indígenas em contexto urbano é marcada por tensões, conflitos e assimetrias de poder.

Conforme o conceito de autoatenção formulado por Menéndez (2009), o cuidado à saúde organiza-se por meio de práticas cotidianas, coletivas e culturalmente orientadas, que abrangem desde cuidados diários, como alimentação, resguardos corporais e manejo do ambiente, até o reconhecimento do adoecimento e a escolha dos itinerários terapêuticos. A noção de itinerário terapêutico, conforme Helman (2009), permite compreender esses percursos de busca por cuidado que mobilizam práticas culturais diversas. No contexto indígena, as medicinas tradicionais integram esse sistema de autoatenção como práticas prioritárias, mobilizadas no âmbito familiar e comunitário, podendo articular-se ou tensionar-se com a biomedicina (Garnelo, Soares e Pontes, 2019).

Entretanto, ao investigar a inter-relação entre essas práticas e a assistência na APS, emergiram de forma contundente questões sociais relacionadas ao apagamento, à invisibilidade, ao racismo estrutural, à discriminação e à desvalorização dos modos de vida indígenas. Ao discorrer sobre a temática, Calegare, Lopes e Zacarias (2021) analisam que a presença indígena em Manaus é historicamente marcada pela subalternização, apagamento cultural e invisibilização, um padrão que se prolonga no contexto urbano atual.

As narrativas das participantes revelam experiências recorrentes de negação da identidade indígena e subalternização nos serviços de saúde, como expresso na fala de Tucum e Jambu:

“Aqui em Manaus, eles não querem enxergar a gente, porque eles nos veem, eles estão o tempo todo nos silenciando. Quando vou para alguma unidade de saúde, eu falo que sou indígena, eles colocam parda, eu percebo, já vi.” (Tucum, 2025).

“[...] Tempos atrás, aqui nesse bairro era bem difícil, tinha que madrugar e demorava muito para ser atendida só porque nós éramos indígenas e sempre éramos os últimos a ser atendidos... os brancos são atendidos e a gente por último a ser atendida, todos passam na frente [...]” (Jambu, 2025).

Relatos semelhantes aparecem na fala de Crajiru, evidenciando o estranhamento e a suspeição no atendimento: “No atendimento na UBS do bairro, eu mostro meu cartão Saúde... eles se assustam ao falar que sou indígena [...]” (Crajiru, 2025).

As experiências relatadas indicam que, embora as políticas públicas prevejam o reconhecimento da identidade indígena, sua efetivação no cotidiano da Atenção Primária à Saúde (APS) é atravessada por estereótipos, práticas institucionais que produzem exclusão e relações de poder (Garnelo e Langdon, 2017; Diehl e Langdon, 2015). Tais práticas tendem a associar o indígena exclusivamente à aldeia e à floresta, reforçando visões racistas e pejorativas que desconsideram a presença e a diversidade indígena nos contextos urbanos (Calegare, Lopes, Zacarias, 2021).

Nesse sentido, as cidades revelam-se pouco preparadas para acolher as populações indígenas e, muitas vezes, sequer reconhecem sua existência no espaço urbano, evidenciando a ausência de políticas públicas específicas voltadas aos indígenas que migram para a cidade em busca de estudo, trabalho ou melhores condições de vida (Viana, 2023).

Em um contexto urbano pluriétnico como Manaus, no qual diferentes grupos compartilham o mesmo território, a dificuldade em reconhecer a diversidade indígena contribui para o reforço de fronteiras identitárias rígidas e idealizadas, baseadas em imagens estereotipadas do “indígena verdadeiro” (Pereira, 2021). A ideia de que o indígena deixa de sê-lo ao viver na cidade configura uma forma de preconceito que o fixa no tempo e no espaço, excluindo-o da vida urbana e associando-o a noções de atraso, pobreza e ignorância (Baines, 2001; Nunes, 2010; Pereira, 2021).

Essas questões têm sido amplamente debatidas por instituições e organizações indígenas, como a COPIME, que reivindica o direito dos povos indígenas à cidade, compreendida não apenas como espaço físico, mas como lugar de dignidade, oportunidades e qualidade de vida para seus habitantes (Oliveira, 2023; Viana, 2023).

“[...] Eu consigo falar da minha saúde e tá no meu cadastro o nome indígena, aí me atendem bem. Percebi que, depois que coloquei o nome indígena, passaram a me atender melhor, com mais prioridade..., mas muitos dizem que depois da identificação indígena foi pior... lá na UBS perguntam: tu é apurinã, tu é indígena? Aí falo que sou, sou indígena sim, o meu povo é apurinã, mas não perguntam sobre a minha cultura [...]” (Saratudo, 2025).

As falas das participantes mostram que, paradoxalmente, a identificação indígena pode tanto melhorar quanto piorar o atendimento, dependendo da unidade e da postura dos profissionais. Saratudo relata que, após registrar sua identidade indígena, passou a ser atendida com maior prioridade, embora sem que houvesse interesse em compreender sua cultura.

Já Wará aponta que a identificação indígena só foi considerada em situações de conflito ou ameaça de denúncia, como no caso do parto, evidenciando que o reconhecimento se dá mais como estratégia de defesa do que como prática sistemática de cuidado intercultural.

“[...] Nos atendimentos perguntam somente o nome, mas se a gente não se identificar, não somos vistos como indígenas. No meu parto, a minha tia falou na maternidade que deveríamos ter prioridade por sermos indígenas e, caso alguma coisa acontecesse, iria entrar com processo por sermos indígenas e a demora excessiva no atendimento, então o atendimento foi priorizado” (Wará, 2025).

De modo particular, as falas das mulheres evidenciam que o reconhecimento da identidade indígena nos serviços de saúde é ambíguo e instrumentalizado. Em alguns casos, como relatado por Saratudo, a autodeclaração indígena pode gerar prioridade no atendimento; em outros, como aponta Wará, essa identificação só é considerada em situações de conflito ou ameaça de denúncia. Tal ambiguidade revela que o reconhecimento se dá mais como recurso circunstancial do que como prática sistemática de cuidado intercultural, marcado por relações assimétricas de poder.

Essas experiências se inscrevem em um contexto mais amplo de violências históricas e simbólicas vivenciadas pelas mulheres indígenas, cuja trajetória é marcada por discriminações, preconceitos e violências que se intensificam no processo de deslocamento para a cidade (Araújo et al., 2022; Barros; Santos; Souza, 2025). A

naturalização dessas violências reforça processos de invisibilização, impactando diretamente a adesão aos cuidados e a continuidade do acompanhamento na APS.

“[...] Percebia muitos preconceitos dos profissionais que atendiam lá, principalmente de uma médica... ela ficava distante da minha filha [...]” (Jambu, 2025).

“[...] A minha prima, quando foi para se consultar, e ela é assim: ruiva, gosta de usar muitas joias, quando ela foi se identificar como indígena, a mulher falou assim: ‘tu quer me enganar?’ e ela respondeu: ‘não, moça, sou indígena’, e a mulher disse na cara dela: ‘esses índios de agora’... Acabou que ela nem teve mais ação e foi embora, nem consultou mais [...]” (COPIME, 2025).

“[...] Porque nós, indígenas, sempre somos questionados em relação a isso. Sempre tem que estar com a carteirinha para dizer que é indígena, tem que tá com cabelo comprido, com cocar de pena, cabelo liso, se eu não tiver cabelo liso e tiver cabelo enrolado, pior ainda [...]” (Tucumã, 2025).

As falas de Tucumã e Copime explicitam como o questionamento da identidade indígena, baseado em estereótipos fenotípicos e culturais, produz humilhação, silenciamento e afastamento dos serviços de saúde, configurando uma constante batalha posta aos povos indígenas, garantir os direitos constitucionais como povos, ser indígena, com suas identidades onde quer que estejam, terra indígena demarcada e ou nas cidades (Faria, Castro e Osoegawa, 2022).

Em consonância com estudos de Diehl e Langdon (2015), ao destacar que a ausência de marcadores visíveis associados à identidade indígena no Brasil, tais como marcas e adornos no corpo, uso cotidiano da língua, rituais performativos de identidade indígena, contribui para que as equipes de saúde não reconheçam suas especificidades culturais, resultando na oferta de serviços não diferenciados e na invisibilização do princípio da atenção diferenciada. Sob essa perspectiva, as práticas cotidianas, como o uso de tecnologias, adornos ou diferentes estilos de cabelo, passam a ser interpretadas como sinais de “desvio”, reforçando representações sociais estigmatizadoras no contexto urbano (Santos, 2021).

Conforme analisa Baines (2001), tais situações não dizem respeito a atributos individuais, mas a construções sociais produzidas na interação, quando normas implícitas sobre aparência, comportamento e pertencimento territorial não são cumpridas.

As narrativas das participantes evidenciam que as experiências de atendimento e acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS), frequentemente atravessadas por

invisibilidade, discriminação e racismo, impactam diretamente a adesão ao cuidado, resultando no abandono ou na descontinuidade do acompanhamento. Para as mulheres indígenas, um bom atendimento está associado a serem bem recebidas, respeitadas, visibilizadas e cuidadas de forma atenta e sensível, como expressa Açaí ao afirmar que, ao buscar a UBS, sente-se bem atendida e reconhecida em sua condição de usuária.

Em contraponto, a narrativa de Jambu explicita situações em que a ausência de escuta qualificada e de exame clínico cuidadoso produz insatisfação e leva à busca por outro serviço. No cotidiano da APS, tais experiências comprometem a construção do vínculo terapêutico e fragilizam o princípio da integralidade do cuidado, produzindo um afastamento subjetivo e institucional das mulheres indígenas em relação aos serviços de saúde, o que aprofunda desigualdades e limita o acesso a uma atenção efetivamente equitativa.

“[...] Quando vou na UBS, me atendem bem, não posso mentir, sou bem atendida [...]” (Açaí, 2025).

“[...] Profissional não pode atender assim, ele tem que ver realmente o que o paciente tem, tocar no paciente, olhar, sentir se o coração tá bem ... Então procurei outra UBS e lá fui bem atendida [...]” (Jambu, 2025).

No entanto, as mulheres indígenas situam-se na linha de frente dos processos de enfrentamento a essas leituras discriminatórias, assumindo papel protagonista na reafirmação identitária, bem como na desconstrução e recusa dos estereótipos historicamente associados à imagem da mulher indígena (Lima, 2024).

Figura 29: Não somos Iracema.



Fonte: Yacunatuxa, 2020.

“[...] Pessoas julgam muito o seu fenótipo ... se você está com cordão ou usando brinco indígena, eu gosto de usar..., mas quando a pessoa não usa e vai se identificar, sentem no olhar o preconceito, tipo ah, você é indígena, está querendo me enganar?... Como se duvidasse que a pessoa é indígena só porque não usa adereços ou se usa cabelo pintado, loiro, ruivo e não usa adereços ... como se o indígena tivesse aquele fenótipo, aquela característica e tem que ser assim [...]” (Tucuma, 2025).

As narrativas revelam ainda que a vida urbana intensifica essas experiências, uma vez que a presença indígena na cidade é frequentemente percebida como desvio ou perda identitária. Como problematizam Nunes (2010) e Pereira (2021), não existe uma única forma de urbanidade indígena (Figura 29), mas múltiplas inserções no espaço urbano, nas quais a lógica do parentesco, da família extensa e da socialidade indígena permanece estruturando o cotidiano. No entanto, a incapacidade institucional de reconhecer essa diversidade reforça fronteiras identitárias rígidas, produzindo exclusão simbólica e material.

Nesse cenário, Araújo et al. (2022) evidenciam que, de modo particular, as mulheres indígenas permanecem como alvos de estereótipos que as confinam simbolicamente à “selva” ou ao “mato”, negando-lhes legitimidade em espaços urbanos e institucionais. A naturalização dessa invisibilidade e das violências históricas sofridas reforça desigualdades e exclusões, tornando fundamental a efetivação das garantias legais e constitucionais que asseguram igualdade, dignidade e direitos básicos. Desconsiderar essas dinâmicas reforça processos de colonização dos saberes, ao hierarquizar e silenciar conhecimentos não reconhecidos como válidos (Ferreira, 2013).

“[...] O que passei foi preconceito, porque muitas vezes, o profissional acha que o indígena não sente dor, ele acha que tem que voltar para o mato para poder fazer o que tem que fazer ali [...]” (Comunidade Woitchumacuo, 2025).

“Eu acho que deveriam atender igualmente, não diferenciar nenhuma raça porque todo mundo é um ser humano, ela tá ali e procura um profissional porque tá sentindo algo, não vai lá para perder tempo...” (Jambu, 2025).

As falas de Andiroba e Wará evidenciam, de um lado, a desconfiança quanto à escuta dos profissionais de saúde e, de outro, a persistência das práticas tradicionais de cuidado, especialmente no ciclo gravídico-puerperal, mesmo no contexto hospitalar. Esses relatos reafirmam que as mulheres indígenas continuam mobilizando seus sistemas próprios de cuidado como forma de proteção e produção da saúde.

“[...] Porque ele não vai acreditar no que eu estou falando e eu já perdi tempo por conta de o médico não saber o que é ...como a gente olha a doença...rasgadura não é só físico... por ser algo invisível, que não aparece no exame, mas está lá [...]” (Andiroba, 2025).

“[...] Lembro que quando fui ter o meu filho pela primeira vez no hospital, vinham as comidas que podiam fazer mal, vinha melancia, minha mãe tirava e dizia que eu não comia aquilo... ela mandava fazer caldo para mim, não comia os da maternidade... A gente tem esses cuidados que são muito importantes [...]” (Wará, 2025).

Nesse sentido, a inter-relação entre práticas tradicionais e APS não deve ser pensada como oposição, mas como campo de negociação, tradução e debate. Experiências analisadas por Gardella (2024), ao discutir modelos de atenção materna que valorizam práticas tradicionais, reforçam que a integração intercultural fortalece a APS, melhora os desfechos em saúde e amplia o acesso, evidenciando a importância de um cuidado sensível às especificidades culturais.

Assim, compreender a inter-relação entre práticas tradicionais de cuidado das mulheres indígenas e a assistência na Atenção Primária à Saúde exige reconhecer as assimetrias de poder que atravessam esse encontro, enfrentar o racismo estrutural presente nos serviços e valorizar os saberes indígenas como parte constitutiva da produção do cuidado. Somente a partir dessa perspectiva será possível avançar na construção de uma Atenção Primária à Saúde verdadeiramente intercultural, integral e equitativa para as mulheres indígenas em contexto urbano.

Sem se restringir ao reconhecimento identitário, a interface entre medicina indígena e Atenção Primária à Saúde aparece também no campo terapêutico, onde se evidenciam negociações cotidianas entre diferentes racionalidades de cuidado mobilizadas pelas mulheres indígenas.

4.3.2 Negociações de cuidado entre remédios dos brancos e remédios indígenas

As narrativas das participantes evidenciam que a experiência das mulheres indígenas na Atenção Primária à Saúde (APS) é atravessada por tensões simbólicas e práticas relacionadas ao uso concomitante do chamado “remédio de branco” e do “remédio indígena”.

. “[...] As práticas, chás... na UBS pedem para não tomar... quando se fala dessa negação, se nega isso, é negar o que é a sua essência, aquilo que você cresceu, viu, como se aquilo ali fosse uma mentira, uma farsa [...]” (Tucumã, 2025).

“[...] Eu acho uma falta de respeito às práticas indígenas, que precisam ser respeitadas assim como se respeitam as opções sexuais, as opções religiosas, de credo das pessoas. Tem que também respeitar os indígenas, a sua forma de ver e sentir o mundo [...]” (Copaíba, 2025).

As expressões acima revelam não apenas episódios de discriminação, mas a presença de fronteiras relacionais nas quais os saberes indígenas são frequentemente deslegitimados nos serviços formais de saúde.

Nesse contexto, o “remédio de branco” é associado à biomedicina institucionalizada, percebida simultaneamente como necessária em determinadas situações e como um campo marcado por imposição, desconfiança e silenciamento.

“Para mim, os nossos cuidados são diferentes dos da medicina, ou seja, é melhor ... Para eles não, os médicos e enfermeiros dizem que não é bom os nossos remédios, por isso eu fico calada e não falo nada [...]” (COPIME, 2025).

A abordagem biomédica, ao desconsiderar os cuidados tradicionais mobilizados pelas mulheres, contribui para o afastamento dos serviços, a descontinuidade do cuidado e, em alguns casos, a desistência do tratamento. Por outro lado, o “remédio indígena” emerge como primordial para proteção, autonomia e continuidade cultural, profundamente vinculado ao território, à memória coletiva e às relações familiares.

“[...] A medicina ocidental, para mim, é alternativa. Eu procuro em último caso. Porque eu cuido da minha saúde com meus especialistas [...]” (Tucum, 2025).

“[...] Aqui normalmente é um pouco complicado para cuidar da saúde, eu prefiro cuidar da saúde de acordo com o meu povo, sinto falta disso. To aqui há três anos e ainda estranho isso [...]” (Maniva, 2025).

As narrativas das mulheres indígenas evidenciam que o cuidado à saúde, em contexto urbano, é orientado prioritariamente pelas práticas da medicina indígena, sendo a biomedicina acionada de forma situada, seletiva e complementar. Maniva expressa o estranhamento vivenciado na cidade e a saudade dos modos próprios de cuidado de seu povo, indicando que, mesmo após anos no espaço urbano, a lógica indígena de produzir

saúde permanece como referência central. Esse deslocamento territorial não implica abandono das práticas tradicionais, mas reafirma a importância da continuidade cultural no cuidado cotidiano.

Seu uso não se apresenta como negação da biomedicina, mas como parte de um sistema de autoatenção, no qual as mulheres avaliam, combinam e hierarquizam diferentes recursos terapêuticos a partir de suas experiências, percepções e cosmologias, reafirmando seu papel como gestoras do cuidado, especialmente no âmbito doméstico e no ciclo gravídico-puerperal.

“[...] Agora, em relação a doenças como gripes, a gente não vai na UBS, a minha mãe faz os remédios com as plantas medicinais que ela aprendeu, então em situações de gripe não vamos na UBS, a gente trata na comunidade com nossos remédios [...]” (Andiroba, 2025).

“[...] A gente sempre começa a cuidar com nossa medicina, com chás e quando não resolve, caso precise de um tratamento mais específico, procuramos as unidades de saúde [...]” (Maniva, 2025).

“[...] Se faz os chazinhos caseiros, quando estamos gripados se faz os banhos de folhas, esse é o principal, a gente não depende muito dos hospitais porque se faz aqui mesmo em casa [...]” (Jambu, 2025).

De forma recorrente, as participantes relatam que agravos considerados leves, como gripes e dores, são tratados inicialmente com chás, banhos de folhas, xaropes e remédios caseiros, aprendidos no âmbito familiar e comunitário. Jambu, Maniva e Andiroba destacam que essas práticas são realizadas no espaço doméstico, sem necessidade imediata de recorrer às unidades de saúde, revelando uma autonomia construída a partir do conhecimento transmitido por mães e avós. Esse movimento confirma que o cuidado começa “em casa” e na comunidade, sendo a UBS buscada apenas quando os recursos da medicina indígena não produzem os efeitos esperados.

A valorização prioritária da medicina indígena, relatada pelas participantes, confirma os achados de Menéndez (2003) acerca dos itinerários terapêuticos e do pluralismo médico, segundo os quais distintos grupos sociais recorrem a múltiplas formas de cuidado para um mesmo problema de saúde. Nesse sentido, os conhecimentos não são acionados isoladamente, mas avaliados a partir de suas consequências concretas sobre a saúde e as condições de vida.

Estudos como o de Barbosa de Moraes et al. (2021) corroboram empiricamente essa centralidade da medicina indígena, ao demonstrar sua ampla utilização e eficácia no manejo da dor entre povos amazônicos. Conforme Garnelo e Pontes (2012), os itinerários terapêuticos entre os Kaiowá organizam-se a partir de uma hierarquia entre a cura espiritual e os cuidados direcionados ao corpo, orientando os caminhos mobilizados no enfrentamento da doença. Adoecimentos considerados leves ou transitórios tendem a ser tratados no âmbito familiar, com o uso de plantas medicinais e outros recursos tradicionais, enquanto situações associadas à instabilidade da alma ou à dimensão espiritual demandam a atuação de especialistas indígenas, como os xamãs, para os quais a cura espiritual assume centralidade. Esses itinerários não são fixos, mas construídos de forma dinâmica e situada, articulando diferentes operadores de cuidado, especialistas indígenas, curandeiros regionais e profissionais da medicina ocidental, conforme a gravidade, a origem percebida da doença e seus efeitos sobre o corpo e a vida da pessoa.

“[...] No tempo da Covid, nós fizemos nossos remédios, nossos xaropes. A minha mãe sempre fazia chá [...]” (Tucumã, 2025).

“[...] Minha mãe, por exemplo, faz xaropes para tosse que se melhora rapidinho e às vezes se toma xaropes dos médicos e nada [...]” (COPIME, 2025).

“[...] Na Covid, o que garantiu as nossas vidas foram as práticas tradicionais, que praticamente ficamos desassistidos da medicina ocidental. Então foi o chá, foi a pomada, foi o benzimento, foi isso que nos salvou! Nós nos unimos! [...]” (Copaíba, 2025).

A análise das narrativas indica que entre o “remédio de branco” e o “remédio indígena” não se estabelece uma oposição rígida, mas um campo de negociação, no qual as mulheres constroem articulações possíveis entre práticas da medicina indígena e elementos da biomedicina.

As falas de Saratudo e Maniva ilustram com clareza a hierarquização dos cuidados, na qual a medicina indígena ocupa o primeiro lugar no itinerário terapêutico, e a biomedicina surge como alternativa posterior, acionada quando o problema persiste ou quando se trata de procedimentos específicos. Saratudo relata que utiliza remédios caseiros para o cuidado do útero e que os resultados positivos observados em exames preventivos reforçam sua confiança nesses saberes. Maniva afirma que há uma “ligação importante” entre os dois sistemas, mas que essa articulação ocorre a partir de critérios próprios, definidos pelas mulheres.

“[...] Se nossos remédios não funcionam, a gente tem que ir atrás dos remédios dos brancos... tem essa ligação importante também [...]” (Maniva, 2025).

“[...] Primeiro, eu cuido com os remédios caseiros que faço, tomo e se não melhorar eu procuro lá a UBS, eu tomo os remédios caseiros para o útero e quando vou fazer o preventivo é sempre bom, saudável [...]” (Saratudo, 2025).

A biomedicina aparece associada, sobretudo, a ações institucionais específicas, como vacinação, realização de exames preventivos, acompanhamento dos filhos e acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. Tucum explicita que sua principal relação com a UBS ocorre em função dessas demandas, o que evidencia uma utilização funcional e pragmática dos serviços de saúde, sem que isso represente adesão plena ao modelo biomédico.

“[...] Eu utilizo mais pelos meus filhos... precisam tomar vacina, passar por avaliação médica e pegar laudos [...]” (Tucum, 2025).

“[...] Usamos muito para tomar vacina e também para o Bolsa Família. Faço preventivo sempre [...]” (Açaí, 2025).

Noronha (2004) destaca que o uso de medicinas não biomédicas pode ocorrer de forma complementar ou exclusiva, conforme modos de vida e valores culturais. Contudo, quando a APS não reconhece essas articulações, reforçam-se assimetrias de poder e apagamentos epistemológicos.

“[...] Eu nunca falei que uso as minhas plantas porque os médicos não acreditam, falam que não presta e que não é bom e não funciona... fico quietinha tomando. ...continuo usando os meus remédios caseiros e às vezes até paro o tratamento da UBS pelo que falam do meu tratamento com plantas. Nunca nenhum profissional da UBS falou ou me orientou sobre a minha medicina, uso de chás [...]” (Saratudo, 2025).

“[...] Então, praticamente, eu nem utilizo a medicina ocidental, não vejo necessidade e também não vejo relação nenhuma entre elas e nem integração [...]” (Centro de Medicina Indígena, 2025).

A ausência de diálogo e o menosprezo às práticas tradicionais nos serviços de saúde produzem o silenciamento e a ocultação dos saberes indígenas. Isso se evidencia no relato de Saratudo, que evita mencionar aos profissionais o uso de plantas medicinais, diante da recorrente desvalorização do uso simultâneo das tecnologias de cuidado da

medicina indígena e da desqualificação de seus efeitos. Como consequência, ela mantém seus remédios de forma silenciosa e, em alguns casos, desiste do tratamento biomédico, comprometendo a continuidade do cuidado.

Essa realidade dialoga com as reflexões de Merhy e Feuerwerker (2008), ao evidenciarem que relações de cuidado verticalizadas, centradas exclusivamente no saber técnico, dificultam a adesão terapêutica e fragilizam o vínculo entre usuários e serviços de saúde. As falas das participantes confirmam esse processo ao relatarem a desvalorização das práticas indígenas nos encontros com profissionais, o que contribui para o silenciamento de seus saberes.

Nesse sentido, Barbosa de Moraes et al. (2021) demonstram que o uso da Medicina Tradicional Indígena (MTI) é pouco investigado nos serviços de saúde. Enquanto uma parcela significativa dos homens relatou ser questionada por profissionais de saúde sobre o uso da MTI, apenas uma minoria das mulheres afirmou receber esse tipo de abordagem, indicando maior invisibilização de suas práticas de cuidado. O estudo também aponta barreiras de comunicação, associadas ao uso de linguagem técnica e a atitudes negativas dos profissionais, que dificultam tanto a expressão sobre a utilização quanto o reconhecimento das práticas indígenas, comprometendo a integralidade da atenção.

Tucumã aprofunda essa experiência ao descrever a sensação de negação e invalidação do que aprendeu ao longo da vida com sua mãe e avó, associando essa deslegitimação à negação de sua própria essência.

[...] Nunca recebi nenhuma orientação em UBS sobre como utilizar as práticas tradicionais, ao contrário, pedem para não tomar... Sinto como se tivesse uma negação, uma invalidação daquilo que a gente cresce vendo as nossas avós, nossas mães fazendo, e alguém chega e fala para ti que não é daquele jeito, que não tá certo, que pode te fazer mal o que a gente aprendeu a vida toda [...] (Tucumã, 2025).

Essas falas evidenciam que, embora não haja uma oposição absoluta entre “remédio de branco” e “remédio indígena”, a falta de reconhecimento institucional das práticas tradicionais compromete o vínculo com os serviços de saúde e dificulta a construção de um cuidado verdadeiramente intercultural. As mulheres seguem produzindo saúde a partir de múltiplas racionalidades, negociando saberes e estratégias no cotidiano urbano, mas frequentemente o fazem em silêncio, como forma de proteção de seus conhecimentos e identidades frente à desvalorização vivenciada nos espaços formais de atenção.

Na Atenção Primária à Saúde, esses limites tornam-se mais evidentes, uma vez que o cuidado se constrói no território e na relação com sujeitos e coletividades diversas, exigindo reconhecimento da interculturalidade e das práticas tradicionais de cuidado. A interculturalidade na atenção à saúde dos povos indígenas pode ser definida como um processo de relação, diálogo e articulação entre diferentes sistemas de saberes e práticas de cuidado, no qual conhecimentos biomédicos e tradicionais coexistem de forma complementar, respeitosa e sem hierarquização (Raymundo, 2012). No campo da saúde indígena, esse conceito implica a construção de práticas baseadas na troca, negociação e aprendizagem entre culturas, reconhecendo a legitimidade dos saberes indígenas e promovendo sua articulação com os serviços de saúde (Pedrana et al., 2018). Assim, a interculturalidade orienta a Atenção Primária à Saúde como um espaço de intercâmbio equitativo entre diferentes racionalidades de cuidado, visando um cuidado integral, contextualizado e culturalmente apropriado. Assim, a pretensa autonomia do olhar biomédico é tensionada pela prática cotidiana, que se realiza em contextos socioculturais concretos e atravessados por dimensões sociais e ideológicas, demandando formas de cuidado que articulem saberes biomédicos e outros saberes de cuidado (Menéndez, 2005).

Nesse contexto, a intermedicalidade emerge como uma chave analítica para compreender essas articulações. Pode ser conceituada como um espaço contextualizado de encontro e interação entre diferentes tradições médicas, no qual sistemas como a medicina indígena e a biomedicina coexistem e se articulam. Conforme Greene (1998), trata-se de um campo de práticas híbridas, no qual atuam sujeitos com capacidade reflexiva sobre os diferentes sistemas de cuidado, capazes de transitar entre distintas racionalidades médicas. Nesse espaço, são produzidos saberes mistos, situacionais e específicos, resultantes da interação entre diferentes práticas de cuidado, como também apontado por Follér (2004).

Assim, a intermedicalidade expressa o protagonismo dos sujeitos na construção de arranjos terapêuticos plurais, nos quais diferentes sistemas médicos são combinados de forma dinâmica, conforme os contextos e necessidades vivenciadas. Essa dinâmica pode ser observada empiricamente, como evidenciam Farias et al. (2023), ao demonstrar que o uso de práticas tradicionais não atrasa, necessariamente, a busca por atendimento biomédico, contrariando a noção de “barreiras culturais”. Os cuidadores indígenas recomendam o encaminhamento hospitalar em casos graves e atuam como mediadores entre a medicina indígena e a biomedicina. As práticas tradicionais são mobilizadas

sobretudo na reabilitação pós-alta, de forma complementar. Quando há uso exclusivo dessas práticas, isso se relaciona mais a dificuldades de acesso do que a recusas culturais.

Nesse sentido, a intermedicalidade também se expressa nas práticas de autoatenção, que são continuamente reconstituídas, conforme apontam Dias-Scopel (2014) e Baggio et al. (2018). Os achados reforçam que a escuta qualificada é fundamental para evitar desistências e fortalecer uma atenção primária intercultural (Freitas, Vilela e Nwora, 2023).

A articulação entre identidade, terapêutica e território permite compreender a interface entre medicina indígena e Atenção Primária à Saúde como um campo complexo de negociações, onde se evidenciam tanto violências institucionais quanto estratégias de resistência e continuidade cultural.

As narrativas analisadas evidenciam que o cuidado em saúde das mulheres indígenas, no contexto urbano, é construído a partir de uma lógica própria, na qual a medicina indígena constitui escolha prioritária nos itinerários terapêuticos, enquanto a biomedicina é acionada de forma situada, complementar e pragmática. O “remédio indígena” não aparece como oposição ao “remédio de branco”, mas como preferência de cuidado, orientada por saberes ancestrais, experiências familiares e avaliações concretas de eficácia.

Ao mesmo tempo, as falas revelam que a ausência de reconhecimento institucional das práticas tradicionais nos serviços da Atenção Primária à Saúde produz silenciamento, ocultação de saberes e fragilização do vínculo entre mulheres indígenas e os profissionais de saúde. A deslegitimação do uso de plantas medicinais e cuidados aprendidos com mães e avós não apenas compromete a integralidade do cuidado, mas incide diretamente sobre a dimensão identitária das mulheres, ao negar saberes que constituem sua história, sua memória e sua forma de produzir saúde.

Esse cenário evidencia que a articulação entre medicina indígena e biomedicina não se dá de forma automática ou simétrica, sendo atravessada por relações de poder, hierarquização de saberes e práticas de racismo institucional. Ainda assim, as mulheres constroem, no cotidiano, conexões possíveis entre esses sistemas, incorporando seletivamente recursos biomédicos sem abandonar suas práticas tradicionais, reafirmando seu protagonismo na gestão do cuidado.

A luta por direitos indígenas sempre fez parte da história e reivindicações dos povos originários, porém as mulheres indígenas não tinham direito a se pronunciar, conforme relata Manchinery e Silva (2019). A autora afirma que elas, de forma insistente,

são protagonistas (Figura 30) através do que denominam autodeterminação, ou seja, a luta pela defesa de identidade e território e empoderamento, sem criarem conflitos com as organizações masculinas e sim os têm como aliados nas lutas por direitos indígenas.

Compreender esses itinerários terapêuticos e as negociações estabelecidas entre diferentes racionalidades de cuidado permite avançar para a discussão proposta na próxima seção, na qual se analisam os territórios possíveis construídos pelas mulheres indígenas na relação entre medicina indígena e biomedicina. Trata-se de compreender como esses encontros se materializam nos espaços urbanos, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde, e de que modo podem sustentar práticas de cuidado interculturais que não deslegitimam os saberes indígenas, mas os reconheçam como centrais na produção da saúde e do bem-viver.

Figura 30: Lutana Kokama abraçada à sua mãe, Raimunda, cacica geral eleita pela comunidade.



Fonte: Souza, 2023.

As tensões e articulações observadas no reconhecimento identitário e nos itinerários terapêuticos indicam que o encontro entre medicina indígena e biomedicina não se limita ao nível individual, mas se materializa em territórios concretos de cuidado, onde práticas, saberes e instituições se cruzam de forma dinâmica.

4.3.3 Conexões territoriais e possibilidades interculturais entre Medicina Indígena e APS

Para mim, a saúde diferenciada é a que valoriza os conhecimentos ancestrais, que valoriza e reconhece os profissionais indígenas, a parteira, os pajés, a nossa medicina tradicional, então saúde diferenciada é todo um conjunto que é garantido na legislação, mas que infelizmente não é aplicada no dia a dia. (Copaíba, 2025).

Figura 31: Saúde Intercultural, territórios possíveis de cuidado à saúde.



Fonte: Sompré, 2025.

A partir das experiências narradas pelas mulheres indígenas acerca do cuidado com o corpo, da saúde reprodutiva e das relações estabelecidas com os serviços da Atenção Primária à Saúde, torna-se necessário avançar na compreensão dos espaços onde esses encontros se produzem. Mais do que uma justaposição de sistemas terapêuticos distintos, tais experiências revelam processos cotidianos de negociação, resistência e articulação entre a medicina indígena e a biomedicina, que se materializam em territórios múltiplos e dinâmicos (Figura 31). A partir dessa compreensão, insere-se a discussão sobre os territórios possíveis de cuidado, entendidos como espaços físicos, simbólicos, culturais e políticos onde as mulheres indígenas constroem práticas de atenção à saúde capazes de sustentar a integralidade do cuidado em contexto urbano.

As narrativas das mulheres indígenas evidenciam que, no contexto urbano, a relação entre medicina indígena e biomedicina se constrói por meio de conexões

territoriais possíveis, de natureza física, simbólica e cultural, produzidas a partir de vivências e negociações cotidianas no cuidado à saúde. Essas articulações não se configuram como síntese harmoniosa nem como substituição de um sistema por outro, mas como arranjos situados, nos quais elementos da biomedicina são incorporados de forma seletiva, conforme a necessidade, sem o abandono das práticas indígenas que orientam a compreensão de corpo, saúde e doença. Nesse processo, a Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como espaço privilegiado de encontro, mas também de tensão entre saberes, no qual as mulheres elaboram estratégias próprias para garantir cuidado, proteção e continuidade de seus modos de vida.

Como destaca Barreto (2025), entre os povos indígenas, o cuidado à saúde não se restringe à intervenção curativa, organizando-se como um sistema preventivo e protetivo fundamentado em lógicas comunitárias e territoriais. Esse modo de produzir saúde mantém-se mesmo em contextos urbanos, nos quais novas formas de territorialização emergem a partir de deslocamentos motivados por conflitos territoriais, pressões socioambientais e pela busca por educação, trabalho e acesso a serviços (Coimbra Jr e Santos, 2000). Nessa dinâmica, a territorialidade indígena é continuamente ressignificada, articulando vínculos culturais e identitários para além das terras homologadas, como observado em Manaus, onde bairros e espaços de convivência passam a constituir territórios de afirmação da existência indígena e de produção de cuidado.

Ao considerar que os Determinantes Sociais da Saúde abrangem fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos, culturais e subjetivos, torna-se evidente que a atenção à saúde indígena em contexto urbano precisa ser compreendida a partir da articulação entre esses determinantes e as formas próprias de territorialidade cultivadas pelos povos originários. As práticas cotidianas das mulheres participantes evidenciam como condições diferenciadas de vida influenciam diretamente os processos de saúde-doença, reforçando a centralidade do território na produção do cuidado.

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas reconhece que a melhoria das condições de saúde não pode ser alcançada pela imposição de conhecimentos e tecnologias biomédicas, sendo indispensável o respeito às concepções e valores próprios de cada povo (Lorenzo, 2011; Langdon e Garnelo, 2017). Contudo, como apontam essas autoras, a atenção diferenciada permanece pouco definida na prática, sendo atravessada por negociações contínuas, tensões institucionais e

padronizações técnicas que frequentemente tornam os serviços impermeáveis às singularidades socioculturais dos povos indígenas, especialmente no contexto urbano.

[...] A gente foi percebendo, por exemplo, que para que a gente possa garantir a continuidade da nossa existência, a gente precisa dessas políticas diferenciadas principalmente no âmbito da saúde... a saúde diferenciada é a que valoriza os conhecimentos ancestrais... que reconhece os profissionais indígenas... a nossa medicina tradicional, então saúde diferenciada é todo um conjunto que é garantido na legislação, mas que infelizmente não é aplicado no dia a dia [...] (COPIME, 2025).

Essa distância entre o reconhecimento normativo e a prática cotidiana é explicitada na fala de COPIME, ao afirmar que a saúde diferenciada pressupõe a valorização dos conhecimentos ancestrais, o reconhecimento dos profissionais indígenas, como parteiras, pajés e especialistas da medicina tradicional, e a efetivação de um conjunto de direitos garantidos na legislação, mas ainda pouco aplicados no cotidiano dos serviços. Tal narrativa evidencia que a disputa por reconhecimento ocorre tanto no plano simbólico quanto no campo político e institucional da organização da atenção à saúde.

A inter-relação entre práticas tradicionais e biomedicina evidencia que as mulheres indígenas constroem modos singulares de atenção à saúde, nos quais diferentes racionalidades coexistem e se articulam. Na cidade, mobilizam saberes ancestrais, uso de plantas medicinais, práticas corporais e redes comunitárias, ao mesmo tempo em que acessam a APS, principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2012; Ahmadpour et al., 2023). Esses itinerários terapêuticos não se restringem ao circuito biomédico institucional, mas envolvem múltiplas estratégias orientadas por dimensões simbólicas, sociais e culturais (Menéndez, 2009; Helman, 2009).

Reduzir o cuidado indígena ao atendimento médico-hospitalar reforça a centralidade da biomedicina e invisibiliza outras formas legítimas de cuidado. Como aponta Gerhardt (2006), os caminhos terapêuticos são construídos a partir do universo sociocultural dos sujeitos. No caso das mulheres indígenas urbanas, isso evidencia a capacidade de relativizar a biomedicina, integrando-a a um repertório ampliado de práticas, sem que ela se torne eixo exclusivo do cuidado. Tal dinâmica reforça a necessidade de uma APS que reconheça esses saberes e dialogue com eles de forma efetiva.

Nesse cenário de encontros interculturais, a comunicação emerge como dimensão central da produção do cuidado, revelando barreiras e possibilidades que atravessam a experiência das mulheres indígenas na APS.

Embora os povos indígenas vivenciem historicamente a interculturalidade, esse processo não se estabelece de forma isenta de conflitos (Scheweickardt et al., 2023). No contexto urbano de Manaus, marcado pela presença de múltiplas etnias indígenas e pelo uso de 99 línguas indígenas (IBGE, 2022), a ausência de mediação linguística nas unidades de saúde configura-se como barreira central ao acesso e à integralidade do cuidado. Conforme apontam Castro et al. (2025), a presença de intérpretes-tradutores indígenas é fundamental para qualificar a escuta e a compreensão das práticas, dos sintomas e das concepções de saúde, sendo um elemento indispensável para a efetivação de uma atenção intercultural e equitativa. As falas de COPAÍBA e COPIME evidenciam que a dificuldade de comunicação desencoraja a busca pelos serviços, fragiliza o vínculo terapêutico e expõe as mulheres indígenas a situações recorrentes de discriminação e racismo institucional.

Esse cenário dialoga com Dumont e Barra (2025), ao evidenciarem que a atenção ao pré-natal em territórios indígenas é atravessada por barreiras estruturais e comunicacionais, como a inadequação de protocolos, a rotatividade de profissionais e a limitada integração com Agentes Indígenas de Saúde, comprometendo a continuidade e a integralidade do cuidado. No contexto urbano, tais desafios se intensificam nos encaminhamentos para outros níveis do Sistema Único de Saúde, nos quais são recorrentes denúncias de maus-tratos e negação de atendimento (Miranda, 2024).

[...] Aqui em Manaus, hoje ainda temos casos e conhecimento de profissionais de saúde que se negam a atender indígenas porque não entendem o que eles estão falando. Já ocorreram e ainda ocorrem casos assim, têm muitas queixas de profissionais que não entendem e acabam não atendendo os indígenas [...] (Copaíba, 2025).

Nesse contexto, destaca-se o papel do Agente Indígena de Saúde como mediador fundamental entre saberes indígenas e recursos biomédicos, atuando tanto no plano técnico quanto no político (Dias-Scopel, Scopel e Langdon, 2015). Sua presença nas Unidades Básicas de Saúde contribui para qualificar o acesso, reduzir barreiras institucionais e fortalecer a confiança das mulheres indígenas nos serviços, conforme evidenciado na narrativa de Andiroba.

“[...] Depois que a UBS começou a ter AIS, o atendimento na UBS melhorou bastante com a AIS - agente indígena de saúde. Tem até uma demora, mas não precisamos madrugar para pegar ficha. Somos priorizados e a equipe já nos conhece. Quando tem um AIS, tem toda a diferença [...]” (Andiroba, 2025).

“[...] Um atendimento diferenciado com a contratação de linguistas porque o diálogo e a interlocução são melhores quando é de indígena para indígena do que um não indígena [...]” (COPIME, 2025).

No campo da saúde das mulheres indígenas, essas tensões tornam-se ainda mais evidentes. Programas de saúde da mulher, ao priorizarem o controle do ciclo menstrual e o uso de tecnologias hormonais, tendem a desconsiderar os significados cosmológicos do sangue e os resguardos tradicionais, produzindo constrangimentos, silenciamentos e formas de violência simbólica sobre os corpos femininos (Aurora, 2019; Oliveira, 2023). As falas das participantes reiteram que a ausência de acompanhamento diferenciado, associada à vergonha, à falta de confiança e ao despreparo de parte dos profissionais, compromete a adesão às ações preventivas.

Garantir uma saúde diferenciada e intercultural, nesse contexto, não implica a incorporação acrítica de rituais aos serviços, mas o reconhecimento das práticas tradicionais como saberes legítimos e estruturantes do cuidado (Garnelo, Sampaio e Pontes, 2019). Conforme afirmam Romero et al. (2023) e Diehl e Langdon (2007), reconhecer a intermedicalidade como característica constitutiva do cuidado indígena é condição fundamental para o avanço na construção de uma APS intercultural, capaz de dialogar com práticas indígenas, enfrentar assimetrias de poder e garantir a integralidade da atenção às mulheres indígenas em contextos urbanos.

[...] Acompanhamento diferenciado porque muitas indígenas não querem fazer o acompanhamento de saúde pela vergonha, pela falta de confiança, e alguns profissionais também não passam essa confiança para elas e acho que o alinhamento da medicina com o conhecimento indígena é muito importante, trabalhar alinhando as duas formas, para mim isso é essencial [...] (Crajiru, 2025).

Articulada a esse entendimento, a Educação Permanente em Saúde configura-se como ferramenta estratégica para qualificar a assistência, ao integrar aprendizagem, reflexão crítica e transformação dos processos de trabalho (Brasil, 2014). As falas de Tucumã e Wará reforçam que a formação intercultural deve envolver todos os trabalhadores da APS, desde a recepção até as equipes multiprofissionais, favorecendo práticas de cuidado sensíveis às especificidades socioculturais.

“[...] Eu acredito que a porta de entrada e depois se estender pra todos os profissionais, mas a porta de entrada da UBS precisa ter formação para um atendimento diferenciado [...]” (Tucuma, 2025).

“[...] Eu acho que precisa ter oficinas entre nós, indígenas, e profissionais de saúde, tanto recepcionistas como todos os profissionais [...]” (Wará, 2025).

As narrativas das mulheres indígenas evidenciam a necessidade de dispositivos estratégicos no âmbito municipal que assegurem um cuidado sensível às especificidades socioculturais, de gênero e territoriais. A ausência de acompanhamento diferenciado, associada à vergonha, à falta de confiança e ao despreparo de parte dos profissionais, compromete a busca e a adesão aos serviços de saúde, como relatado por Crajiru. Esses achados convergem com Dumont e Barra (2025), ao indicarem que barreiras de acesso e continuidade do cuidado estão fortemente relacionadas às questões de gênero e comunicação, especialmente quando mulheres indígenas são atendidas por profissionais homens, evidenciando a necessidade de reorganização dos serviços para considerar gênero, língua e modos próprios de cuidado.

[...] Porque a maioria das mulheres indígenas não têm o hábito de ir ao ginecologista, porque a maioria tem vergonha de se expor, de serem examinadas por homens, o ideal é que fossem acompanhadas por uma AIS, por uma enfermeira indígena, seria tão importante principalmente para as mulheres de 40, 50 anos... se não tiver alguém acompanhando as mulheres indígenas, elas não fazem acompanhamento preventivo [...] (Crajiru, 2025).

As falas também revelam lacunas formativas importantes, mesmo em um estado marcado pela diversidade indígena, como o Amazonas, onde parte dos profissionais desconhece a presença indígena em Manaus e seus perfis socioculturais. Nesse contexto, a Educação Permanente em Saúde (EPS) emerge como estratégia central para qualificar os processos de trabalho na APS, favorecendo práticas de cuidado culturalmente sensíveis e efetivamente diferenciadas.

[...] O Amazonas é o maior estado indígena, você tem Manaus, o município com maior população indígena, acho que o profissional que sai de dentro das universidades, ele tem que ter o conhecimento dessa realidade, porque muitas vezes quando você procura uma UBS para atendimento, o médico pensa que Manaus não tem indígena. Então você se depara com esses profissionais sem nenhum conhecimento daquele cenário e do perfil daqueles pacientes que eles vão cuidar, aí eu falo mais especificamente de nós indígenas, que não temos nada, não temos nada mesmo [...] (Copaíba, 2025).

Conforme destaca Baniwa (2025), as Medicinas Indígenas e seus sistemas ancestrais constituem elementos centrais do bem viver, sendo fundamentais para a proteção e a cura dos corpos-territórios. No entanto, no contexto contemporâneo, a

biomedicina tende a privilegiar o diagnóstico e o tratamento, em detrimento da experiência subjetiva do adoecimento, o que limita a compreensão do processo saúde-doença em sua complexidade somática, psíquica e, em determinadas cosmologias, espiritual (Gewehr et al., 2017). A distinção entre o conhecimento da doença e a experiência do adoecimento evidencia os limites da ação biomédica e o potencial das práticas tradicionais em integrar sentidos culturais e subjetivos do cuidado (Gewehr et al., 2017).

Embora este estudo contemple um recorte específico da diversidade indígena presente em Manaus, seus resultados corroboram pesquisas que apontam barreiras recorrentes à efetivação da atenção integral e diferenciada em contextos urbanos, especialmente na Atenção Primária à Saúde, espaço onde se materializam as tensões e as articulações possíveis entre a Medicina Indígena e a Biomedicina (Tobias et al., 2023).

“[...] Também um atendimento mais humanizado, não só com os indígenas, mas com toda a sociedade, mas para a gente enquanto mulher indígena, a gente precisa muito disso, pois percebemos a necessidade através de acompanhamentos dados pela nossa rede de apoio [...]” (Makira-E'ta, 2025).

Estudos com mulheres indígenas, como o realizado com mulheres Haliti-Paresí, evidenciam que esses saberes coexistem e se articulam no cotidiano, reforçando a necessidade de abordagens transculturais por parte dos profissionais de saúde (Baggio et al., 2018), em consonância com experiências interculturais na América Latina (Gardella, 2024).

Falar sobre a saúde dos povos indígenas implica reconhecer a pluralidade cultural que compõe o Brasil e compreender que o cuidado em saúde não pode ser uniforme diante dessa diversidade. Os povos indígenas possuem saberes, práticas e concepções próprias sobre corpo, doença e cura, profundamente articuladas aos seus modos de vida, territórios e formas de organização social. Ignorar essas especificidades não apenas fragiliza o cuidado, como também reproduz desigualdades históricas e viola o direito à saúde assegurado pela Constituição Federal e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (COFFITO-5).

Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de que os profissionais de saúde estejam preparados para atuar junto às populações indígenas, reconhecendo sua vulnerabilidade social e os impactos decorrentes do contato com formas de vida e práticas não indígenas. Preservar e respeitar as práticas tradicionais constitui um desafio permanente para os serviços de saúde e exige maior compreensão dos contextos culturais,

sociais e das condições de vida das famílias indígenas. Contudo, a fragilidade da formação superior em conteúdos antropológicos, filosóficos e sociais contribui para a reprodução de uma assistência centrada no modelo biomédico, marcada por dessensibilização e por um olhar reducionista sobre o processo saúde-doença, limitando a construção de práticas de cuidado culturalmente sensíveis e efetivamente interculturais (Baggio et al., 2018).

Nesse sentido, como afirmam Langdon e Garnelo (2017), o pluralismo terapêutico não pode ser compreendido a partir de dicotomias simplificadoras entre biomedicina e práticas tradicionais. A construção do cuidado intercultural na APS exige diálogo efetivo entre epistemologias, reconhecimento das concepções indígenas de corpo, saúde e cuidado e conhecimento aprofundado dos territórios e de suas vulnerabilidades.

O fortalecimento do trabalho com Agentes Indígenas de Saúde, a construção de vínculo e a longitudinalidade do cuidado mostram-se fundamentais para enfrentar barreiras de acesso e adesão, especialmente aquelas relacionadas à comunicação, ao gênero dos profissionais e às experiências de discriminação nos serviços. Nesse processo, a Educação Permanente em Saúde configura-se como estratégia essencial para qualificar as equipes da APS e promover práticas de cuidado científica e culturalmente adequadas, alinhadas aos objetivos deste estudo de compreender as possibilidades, tensões e diálogos entre as práticas de cuidado indígenas e a assistência ofertada na Atenção Primária à Saúde em contexto urbano (Dumont e Barra, 2025).

Por fim, embora o recorte do estudo represente apenas parte da diversidade indígena presente no município de Manaus, os achados corroboram evidências de que a efetivação de uma atenção integral e diferenciada exige o reconhecimento dos territórios possíveis de cuidado, nos quais a medicina indígena e a biomedicina se articulam de forma dinâmica. Ao evidenciar as práticas, narrativas e estratégias das mulheres indígenas, esta dissertação reafirma que a construção da saúde integral passa, necessariamente, pelo diálogo intercultural, pelo fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e pelo reconhecimento das mulheres indígenas como protagonistas de seus processos de cuidado.

A compreensão dessas tensões, articulações e territórios possíveis fundamenta a elaboração do produto técnico desta pesquisa, concebido como instrumento de mediação intercultural voltado à qualificação da Atenção Primária à Saúde no cuidado às mulheres indígenas em contexto urbano.

5 PRODUTO TÉCNICO

O produto técnico desta dissertação deriva dos achados da pesquisa sobre a interface entre medicina indígena e Atenção Primária à Saúde, estando alinhado ao objetivo do estudo de compreender a relação entre práticas tradicionais de cuidado e os serviços de saúde em contexto urbano. Consiste em um *e-book* educativo elaborado a partir do conhecimento sobre tecnologias em saúde e práticas tradicionais mobilizadas por mulheres indígenas de associações e comunidades indígenas de Manaus, sistematizando esses saberes e evidenciando as articulações entre práticas tradicionais e recursos da Atenção Primária à Saúde na produção do cuidado. Sua elaboração integrou o processo de pesquisa qualitativa, exploratória e de campo, realizada com mulheres indígenas que utilizam saberes tradicionais no cuidado à saúde feminina, configurando-se como material educativo de caráter técnico-formativo destinado à socialização do conhecimento produzido. No âmbito acadêmico, o produto contribui para a sistematização de saberes tradicionais no campo da saúde coletiva e amplia o debate sobre interculturalidade no cuidado; no âmbito social, fortalece a circulação de informações acessíveis às comunidades envolvidas e aos serviços de saúde, ampliando o retorno social da pesquisa e promovendo o reconhecimento das práticas tradicionais de cuidado.

5.1 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

5.1.1 Descrição do produto

Produto técnico-científico do tipo e-book educativo/formativo, que aborda a saúde das mulheres indígenas em contexto urbano, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS), nas articulações entre Medicina Indígena e Biomedicina, na interculturalidade e nos itinerários terapêuticos construídos no cotidiano do cuidado.

5.1.2 Finalidade do produto

Contribuir para a educação permanente em saúde, qualificando práticas assistenciais na Atenção Primária à Saúde por meio da reflexão crítica sobre o cuidado às

mulheres indígenas em contexto urbano, promovendo o reconhecimento dos saberes indígenas, o diálogo intercultural e a integralidade da atenção.

5.1.3 Público de interesse

Profissionais da Atenção Primária à Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, gestores, Agentes Indígenas de Saúde, estudantes e docentes das áreas da saúde e das ciências humanas, gestores de políticas públicas e lideranças indígenas.

5.1.4 Divulgação do produto

O e-book será divulgado por meio de atividades de educação permanente em saúde, oficinas, rodas de conversa, ações formativas nos serviços de Atenção Primária à Saúde, além de plataformas digitais institucionais e eventos acadêmicos e científicos relacionados à saúde indígena e à saúde coletiva. Os autores, após avaliação, irão procurar instituições para impressões físicas e em formato digital para disponibilização e divulgação.

5.1.5 Projeto de pesquisa

O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA: o papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua (in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano.

5.1.6 Linha de pesquisa

Educação em saúde e políticas públicas.

5.1.7 Disponibilização do produto

O produto será disponibilizado em formato digital (PDF), em acesso livre, por meio de repositório institucional da universidade e de plataformas digitais utilizadas para educação permanente em saúde.

Link de acesso: <https://files.catbox.moe/1442t9.pdf>

5.1.8 Autoria

Dalva Nascimento Coimbra (Discente, Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga (Orientador, Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Prof. Ms. André Petraglia Sassi (Coorientador, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

5.2 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Tabela 1: Ficha do produto desenvolvido.

Descrição do produto	Produto técnico-científico do tipo e-book educativo/formativo, que aborda a saúde das mulheres indígenas em contexto urbano, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS), nas articulações entre Medicina Indígena e Biomedicina, na interculturalidade e nos itinerários terapêuticos construídos no cotidiano do cuidado.
Finalidade do produto	Contribuir para a educação permanente em saúde, qualificando práticas assistenciais na Atenção Primária à Saúde por meio da reflexão crítica sobre o cuidado às mulheres indígenas em contexto urbano, promovendo o reconhecimento dos saberes indígenas, o diálogo intercultural e a integralidade da atenção.
Público de interesse	Profissionais da Atenção Primária à Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, gestores, Agentes Indígenas de Saúde, estudantes e docentes das áreas da saúde e das ciências humanas, gestores de políticas públicas e lideranças indígenas.
Divulgação do produto	O <i>e-book</i> será divulgado por meio de atividades de educação permanente em saúde, oficinas, rodas de conversa, ações formativas nos serviços de Atenção Primária à Saúde, além de plataformas digitais institucionais e eventos acadêmicos e científicos relacionados à saúde indígena e à saúde coletiva.
Projeto de pesquisa	Produto vinculado ao projeto de pesquisa de dissertação de mestrado intitulado: “O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA: o papel das tecnologias de cuidado das mulheres indígenas e sua

	(in)visibilidade na atenção primária à saúde em contexto urbano”
Linha de pesquisa	Educação em Saúde e Políticas Públicas.
Disponibilização do produto	O produto será disponibilizado em formato digital (PDF), em acesso livre, por meio de repositório institucional da universidade e de plataformas digitais utilizadas para educação permanente em saúde. Link de acesso: https://files.catbox.moe/1442t9.pdf
Autoria	Discente: Dalva Coimbra Docente orientador: Luiz Fernando Calage Alvarenga Docente coorientador: André Petraglia Sassi.

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação teve como objetivo compreender as práticas tradicionais de cuidado à saúde das mulheres indígenas de diferentes etnias residentes em contexto urbano, com ênfase em seus itinerários terapêuticos, na relação estabelecida com a Atenção Primária à Saúde (APS) e as contribuições dessas práticas para a produção de saúde integral. A partir de uma abordagem qualitativa, fundamentada nas narrativas das próprias mulheres, foi possível evidenciar a pluralidade de concepções de saúde, adoecimento e sua resolução, bem como as estratégias de cuidado acionadas no cotidiano da vida na cidade.

Os achados demonstram que as práticas tradicionais de cuidado constituem tecnologias da medicina indígena e permanecem vivas, dinâmicas e fundamentais para a produção da saúde integral dessas mulheres. A autoatenção emerge como eixo estruturante dos itinerários terapêuticos, sustentada pelo uso de plantas medicinais, rituais de proteção, restrições alimentares, resguardos e acompanhamento com especialistas da medicina indígena, como parteiras, pajés, kumuns e benzedeiros. Tais práticas são mobilizadas de forma coletiva e contextualizada, envolvendo redes familiares e comunitárias, e orientadas por avaliações contínuas acerca da gravidade do adoecimento e de seus significados socioculturais.

A inter-relação com a Atenção Primária à Saúde ocorre de maneira seletiva, estratégica e negociada, sendo acionada, principalmente, quando as práticas tradicionais não produzem a resolução esperada ou diante de condições reconhecidas como “doenças de branco”. O acesso aos serviços biomédicos, contudo, não implica o abandono da medicina indígena, mas revela processos de intermedicalidade, nos quais diferentes racionalidades médicas coexistem e se articulam conforme as necessidades e os valores culturais das mulheres.

A pesquisa evidencia que a adesão, o vínculo e a continuidade do cuidado biomédico dependem, de forma decisiva, do acolhimento, do respeito às práticas culturais, da sensibilidade às questões de gênero, mediação linguística e do reconhecimento da presença das mulheres indígenas nos serviços de saúde urbanos. Situações de discriminação, invisibilização e desvalorização dos saberes tradicionais fragilizam o vínculo terapêutico e produzem afastamento dos serviços da Atenção Primária à Saúde, aprofundando desigualdades no acesso ao cuidado e comprometendo a integralidade da atenção.

Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde, quando orientada por princípios interculturais, apresenta-se como espaço estratégico para a articulação entre a medicina indígena e a biomedicina. O fortalecimento do trabalho com Agentes Indígenas de Saúde, a valorização dos saberes tradicionais, a organização dos serviços sensíveis às diferenças culturais e a Educação Permanente em Saúde mostram-se fundamentais para qualificar as práticas assistenciais e promover uma atenção equitativa, contínua e culturalmente referenciada.

Do ponto de vista do percurso da pesquisa, este estudo configurou-se também como um processo de ressignificação profissional e pessoal. Enquanto fisioterapeuta atuante na Atenção Primária à Saúde, o trabalho de campo possibilitou revisitar experiências de cuidado enraizadas na ancestralidade indígena da pesquisadora, especialmente aquelas transmitidas intergeracionalmente relacionadas a resguardos, restrições alimentares e uso de plantas medicinais, vivenciadas no âmbito familiar. Essas memórias e vivências reforçam a compreensão do cuidado como prática coletiva, relacional e situada, histórica e majoritariamente produzida pelas mulheres, e tensionam modelos assistenciais ainda fortemente centrados na racionalidade biomédica. Ao mesmo tempo, evidenciam os limites de uma formação profissional biomédica pouco sensível às dimensões sociais, culturais e históricas do processo saúde-doença, apontando para a necessidade de ampliar os referenciais que sustentam a prática em saúde.

Por fim, é importante destacar que este estudo não teve como propósito avaliar a eficácia da medicina indígena a partir de critérios biomédicos, tampouco classificar suas práticas como eficazes, ineficazes ou prejudiciais segundo parâmetros externos a seus próprios sistemas de conhecimento. Tal posicionamento busca evitar leituras colonizadoras sobre tecnologias indígenas de cuidado, especialmente aquelas de natureza simbólica e espiritual. Ao contrário, o estudo orientou-se pelo respeito e reconhecimento do protagonismo das mulheres indígenas na produção, transmissão e atualização de saberes, respeitando as formas próprias pelas quais compreendem o cuidado, o adoecimento e a cura.

Conclui-se, portanto, que a promoção da saúde integral das mulheres indígenas em contexto urbano exige o reconhecimento da multiplicidade de territórios possíveis de cuidado, nos quais se entrelaçam práticas tradicionais, experiências urbanas e políticas públicas de saúde. Evidencia que a medicina indígena, longe de ser residual ou substituível, constitui um sistema vivo de produção de saúde, autonomia e bem viver com racionalidades próprias, coletivas e territorializadas, que desafiam a lógica

homogeneizante da biomedicina e convocam a Atenção Primária à Saúde a se reinventar como espaço de escuta, diálogo e articulação intercultural. Ao dar centralidade às vozes das mulheres indígenas, esta dissertação contribui para o fortalecimento de abordagens interculturais na Atenção Primária à Saúde e para a efetivação de políticas públicas capazes de enfrentar desigualdades históricas e produzir cuidado integral, contínuo e culturalmente referenciado em contextos urbanos marcados pela diversidade indígena.

REFERÊNCIAS

- ABRITTA, M.; TORRES, S.; FREITAS, D. Saúde das mulheres indígenas na América Latina: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Saúde Funcional**, v. 9, p. 164–177, 2021. doi: <https://doi.org/10.25194/rebrasf.v9i2.1449>.
- ACNUR – AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS. **Mapeamento de refugiados indígenas em Manaus**. 2023. Disponível em: <https://www.acnur.org/br/media/mapeamento-de-refugiados-indigenas-em-manaus>. Acesso em: 7 out. 2025.
- AHMADPOUR, B.; BEZERRA, C. C.; SILVA, D. F. da; SOUZA E SILVA, M. V.; TURRINI, R. N. T. Resolutividade no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Brasil: revisão de escopo. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 21, e02227226, 2023. doi: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs2227>. Acesso em: 29 nov. 2025.
- ALBUQUERQUE, R. Indígenas Sateré-Mawé/AM e Hixkaryana/AM em sofrimento mental e ético-político. **Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis**, Florianópolis, v. 17, p. 1–17, 2020. doi: <https://doi.org/10.5007/1807-1384.2020.e70094>.
- ALMEIDA, A. W. B. de; SANTOS, G. S. (org.). **Estigmatização e território: mapeamento situacional dos indígenas em Manaus**. 1. ed. Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia; Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2009.
- ALVARENGA, L. F. C. **A arte de envelhecer ativamente: articulações entre corpo, gênero e sexualidade**. 2012. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/60400>. Acesso em: 10 maio 2025.
- ALVES, R. A. L.; GOMES, L. E.; TOLEDO, N. N.; SCHWEICKARDT, J. C.; TOBIAS, R. “Ninguém deixa de ser indígena porque mora na cidade”: um olhar sobre as políticas públicas de saúde e os povos indígenas no contexto pandêmico de Covid-19. In: TOBIAS, R.; TOLEDO, N. N.; BEZERRA, C. C.; ALVES, R. A. L.; ANDRADE, T. R. C. (orgs.). **A saúde indígena nas cidades: redes de atenção, cuidado tradicional e intercultural**. 1. ed. Porto Alegre: Editora Rede UNIDA, 2023. p. 20–44. (Série Saúde & Amazônia, v. 26). Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Livro-A-Saude-Indigena.pdf>. Acesso em: 10 maio 2025.
- ANGROSINO, M. **Etnografia e observação participante**. Tradução de José Fonseca. Porto Alegre: Artmed, 2009. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/787222944/Michael-Angrosino-Etnografia-e-observacao-participante>. Acesso em: 20 ago.2024.
- ANMIGA – ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES INDÍGENAS GUERREIRAS DA ANCESTRALIDADE. **I Conferência Nacional das Mulheres Indígenas chega ao fim, com lançamento da Carta “Pela Vida e pelos Corpos-Territórios” e propostas para a construção da Política Nacional para a Mulher**. Brasília: ANMIGA, 06 ago. 2025. Disponível em: <https://anmiga.org/i-conferencia-nacional-das-mulheres-indigenas-chega-ao-fim-com-lancamento-da-carta-pela-vida-e->

pelos-corpos-territorios-e-propostas-para-a-construcao-da-politica-nacional-para-mulher/. Acesso em: 27 out 2025.

APURINÃ, F. Um olhar sobre o cosmos a partir da perspectiva indígena e as consequências da fricção entre os humanos e os não humanos. **Emblemas – Revista da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais**, Catalão, v. 17, n. 1, p. 14–35, jan./jun. 2020. DOI: 10.5216/emb.v17i01.63143. Disponível em: <https://periodicos.ufcat.edu.br/index.php/emblemas/article/view/63143>. Acesso em: 08 fev. 2025.

ARAÚJO, A. C. Manaus, exclusão e pandemia. **Amazônia Real**, 2023. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/especiais/manaus-exclusao-e-pandemia/>. Acesso em: 31 jan. 2026.

ARAÚJO, A. J.; DE SOUSA, N. B.; PORTAL, K. N. R. (RE)significação da mulher indígena: luta e resistência das “PauBrasil ia Echinata”. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, [s. l.], v. 8, n. 4, 2021. doi: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/46534>. Acesso em: 05 de mar. 2025.

ARAÚJO, L. F. S. de; DOLINA, J.; PETEAN, E.; MUSQUIM, C.; BELLATO, R.; LUCIETTO, G. Diário de pesquisa e suas potencialidades na pesquisa qualitativa em saúde. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde / Brazilian Journal of Health Research**, Vitória, v. 15, n. 3, p. 69–76, 2013. doi: <https://doi.org/10.21722/rbps.v15i3.6326>. Acesso em: 15 out. 2024.

ARTINI, A. A. F.; GABRIEL, I. M.; ALMEIDA, N. L.; SCHWEICKARDT, J. C. Etnias integradas: fortalecendo o SUS nas comunidades indígenas da Zona Norte de Manaus. In: SEMINÁRIO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE, 1., 2025, Manaus. **Saúde em Redes**, v. 11, supl. 4, 2025. doi: <https://doi.org/10.18310/2446-48132025v11nsup4>.

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WOTCHIMAÜCÜ (ACW). **Wotchimaucü: indígenas Tikuna na cidade de Manaus**. Coordenação: Deniziu Araújo Peres Tikuna; Reginaldo Luciano Marcolino Tikuna. Belém: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, 2009. (Série Movimentos Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia). Disponível em: <https://www.ppgcspa.uema.br/wp-content/uploads/2017/10/28-Wotchimaucu-Indigenas-Tikuna-Manaus.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2024.

AURORA, B. A colonização sobre as mulheres indígenas: reflexões sobre cuidado com o corpo. **Revista de Estudos em Relações Interétnicas | Interethnica**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 109–115, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/view/20530>. Acesso em: 5 jan. 2026.

BAGGIO, É.; NASCIMENTO, V. F. do; TERÇAS, A. C. P; HATTORI, T. Y.; ATANAKA, M.; LEMOS, E. R. S. de. O cuidar da saúde para a mulher indígena Haliti-Paresí. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 12, n. 3, p. 729–737, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/22870>. Acesso em: 18 dez. 2025.

BAINES, Stephen G. As chamadas “aldeias urbanas” ou índios na cidade. **Revista Brasil Indígena**, v. 2, n. 7, p. 15-17, 2001. Disponível em: <https://biblioteca.funai.gov.br/media/pdf/Folheto55/FO-CX-55-3502-2006.PDF>. Acesso em: 25 nov. 2025.

BALDISSERA, A. Pesquisa-ação: uma metodologia do “conhecer” e do “agir” coletivo. **Sociedade em Debate**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 5–25, 2001.

BANIWA, A. Originalidade das medicinas indígenas, tecnologias de cuidado dos povos indígenas e formação de especialistas. **Transcrição da fala apresentada no 3º Congresso Mundial de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas**, Rio de Janeiro, 18 out. 2025. Revisado pelo autor em 21 out. 2025.

BANIWA, A.F.; VIANNA, J. J. B.; IUBEL, A. F. **Bem viver e viver bem: segundo o povo Baniwa no noroeste amazônico brasileiro**. 1. ed. Curitiba: Editora da UFPR, 2019.

BANIWA, B. A. Mulheres e território: reflexão sobre o que afeta a vida das mulheres indígenas quando os direitos territoriais são ameaçados. **Vukápanavo: Revista Terena**, v. 1, n. 1, p. 165-170, 2018

BANIWA, B.; KANGANG, J.; MANDULÃO, G. **Mulheres: corpos-territórios indígenas em resistência!** (Org) Kassiane Schwingel. Porto Alegre: Fundação Luterana de Diaconia: Conselho de Missão entre Povos Indígenas, 2023.

BANIWA, Lilly [@lillybaniwa]. A aldeia não é o que muita gente conta olhando de fora... [post]. Instagram, 26 out. 2025. Disponível em: <https://www.instagram.com/reel/DQRhjiLDWrV/?igsh=MWk4bTJ5MWdzbWg4aQ==>. Acesso em: 11 nov. 2025.

BARBOSA DE MORAES, E.; DAL FABBRO, D. R.; BERNARDES DE OLIVEIRA, L.; RIBEIRO LEÃO, E. Pain management of Amazon indigenous peoples: a community-based study. **Journal of Pain Research**, [S. l.], v. 14, p. 1969–1980, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/JPR.S298219>. Acesso em: 14 jan. 2026.

BARBOZA, M. S. L.; TUKANO, L. D. Y.; WAIWAI, J. X. “Corpoterritorialização” Katukina: lampejos etnográficos sob as perspectivas femininas indígenas. **Amazônica: Revista de Antropologia**, Belém, v. 11, n. 2, p. 503–547, dez. 2019. doi: <https://doi.org/10.18542/amazonica.v11i2.7365>.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2024.

BARRA, C. S.; DIAS, C. (org.). **Peixes, pescarias e os modos de viver no médio Rio Negro**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2012. (Série Pescarias no Rio Negro, v. 3).

BARRETO, J. P. L. Tecnologias de Cuidados nos Territórios Indígenas – Encontro no Centro de Medicina Indígena. Manaus, 2025. Comunicação apresentada.

BARRETO, J. P. L. **O mundo em mim: uma teoria indígena e os cuidados sobre o corpo no Alto Rio Negro**. 1. ed. Brasília, DF: Mil Folhas, 2022.

BARRETO, J. P. L. **Kumuã na kahtiroti-ukuse: uma “teoria” sobre o corpo e o conhecimento prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro**. 2021. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2021.

BARROS, E. B. de; SANTOS, A. L. dos; SOUZA, M. C. de. Agá (A voz da mulher): uma cartografia do cuidado e da (r)existência de mulheres indígenas. **Ciência & Praxis**, [S. l.], v. 20, n. 35, p. 272–287, 2025. Disponível em: <https://revista.uemg.br/praxys/article/view/9105>. Acesso em: 4 nov. 2025.

BERGAMASCHI, M. A.; PINHEIRO, I. S. Resenha: Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas, de Linda Tuhiwai Smith. **Revista Brasileira de Educação**, v. 26, e260084, 2021. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782021260084>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Departamento de Atenção à Saúde Indígena. **Atenção psicossocial aos povos indígenas: tecendo redes para promoção do bem viver**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Atencao_Psicossocial_Povos_Indigenas.pdf. Acesso em: 4 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 726, de 9 de novembro de 2023**. Dispõe sobre as propostas e moções aprovadas na 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2024/res0726_17_01_2024.htm. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Brasília, 2012. Disponível em: <http://aps.saude.gov.br/>. Acesso em: 14 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. **6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI: “Atenção diferenciada, vida e saúde nas comunidades indígenas”**. Documento orientador. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt->. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. **Brasil tem mais de 8,5 mil localidades indígenas, segundo IBGE**. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/brasil-tem-mais-de-8-5-mil-localidades-indigenas-segundo-ibge>. Acesso em: 07 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Medicinas Indígenas: tecnologias de cuidados em saúde e cura nos territórios indígenas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

Disponível em: <https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/13102>. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Educação Permanente em Saúde: um movimento instituinte de novas práticas no Ministério da Saúde: agenda 2014**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_permanente_saude_movimento_instituente.pdf. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.088, de 4 de julho de 2005. Dispõe sobre a definição dos valores do incentivo financeiro de atenção básica de saúde aos povos indígenas e sobre a composição e organização das equipes multidisciplinares de atenção à saúde indígena. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 5 jul. 2005.

CAIAFFA, W. T. et al. **Saúde urbana, cidades e a interseção de sistemas: panorama, agendas, gaps e oportunidades rumo à equidade, sustentabilidade, resiliência e promoção em saúde**. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2021.

CARDENES, L.; MONTARDO, D. L. Sobre cocares e máscaras: estratégias das lideranças indígenas em Manaus no enfrentamento à Covid-19. **Revista TOMO**, [S. l.], n. 38, p. 75–118, 2020.

CARDOSO, M. R. G; OLIVEIRA, G.S. de; GHELLI, K.G. M. Análise de conteúdo: uma metodologia de pesquisa qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v. 20, n. 43, p. 98–111, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2347>. Acesso em: 10 ago. 2024.

CAREGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de conteúdo. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 15, n. 4, p. 679–684, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000400017>. Acesso em: 08 jul. 2024.

CASTRO, N. J. C.; GAVIÃO, P. L.; SANTOS, A. L. P.; PAES, F. T. Linguística e semiótica na formação e atuação de pessoas indígenas e não indígenas na enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 59, e20250023, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2025-0023en>. Acesso em: 27 out. 2025.

CASTRO, C. M. G. L. de; CARNEIRO, M. Protagonismo feminino indígena: gênero, organização e luta. **Revista Habitus - Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia**, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 52–73, 2023.

CENTRODEMEDICINAINDIGENA. Kumun fazendo Bahsesé. 2021. Fotografia. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/centrodemedicinaindigena?igsh=ZnFhbXI0ejJwejlI>. Acesso em: 31 jan. 2026.

CIDADE, F. C.; FARIA, I. F. de. O direito à saúde, o direito à cidade e os povos originários em espaço urbano. In: TOBIAS, et al. (org.). **A saúde indígena nas cidades**.

Porto Alegre: Editora Reunida, 2023. p. 93–102. ISBN: 978-65-5462-063-5. doi: 10.18310/9786554620635.

COELHO, E. de A. C.; SILVA, C. T. O.; OLIVEIRA, J. F. de; ALMEIDA, M. S. Integralidade do cuidado à saúde da mulher: limites da prática profissional. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 154–160, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000100021>. Acesso em: 03 mar. 2024.

COIMBRA JR., C. E. A.; SANTOS, R. V. Saúde, minorias e desigualdade: algumas teias de inter-relações, com ênfase nos povos indígenas no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 5, n. 1, p. 125–132, 2000. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100011>. Acesso: 07 mai. 2024.

COIMBRA JR., C. E. A.; GARNELO, L. Questões de saúde reprodutiva da mulher indígena no Brasil. In: MONTEIRO, Simone; SANSONE, Livio (org.). **Etnicidade na América Latina: um debate sobre raça, saúde e direitos reprodutivos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. p. 152–173. Disponível em: <https://doi.org/10.7476/9788575416150.0008>. Acesso em: 08 out. 2023.

COPIMEOFICIAL. Formação e Planejamento da COPIME. 2026. Fotografia. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/copimeoficial?igsh=MWNleGluNnVqODNseA==>. Acesso em: 31 jan. 2026.

COPIME – **Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno**. Disponível em <http://cnpj.info/Coordenacao-dos-Povos-Indigenas-de-Manaus-e-Entorno-Copime>. Acessado em: 06 de ago. de 2024.

DAMASCENO, R; SILVA, P. Competência cultural na atenção primária: algumas considerações. **Journal of Management & Primary Health Care**, v. 9, 2018. DOI: <https://doi.org/10.14295/jmphc.v9i0.435>.

DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS. 2008. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf. Acesso em: 03 out. 2023.

DESCOLA, P. Modes of being and forms of predication. HAU: **Journal of Ethnographic Theory**, v. 4, n. 1, p. 271-280, 2014. doi: <https://doi.org/10.14318/hau4>. Acesso em: 03 out. 2023.

DISSE, E. A. S. K.-U. **Povos indígenas em contexto urbano: uma realidade esquecida pelos governos**. In: REPAM. 10 jan. 2023. Disponível em: <https://repam.org.br/povos-indigenas-contexto-urbano/>. Acesso em: 16 out. 2024.

DIAS-SCOPEL, R. P.; SCOPEL, D.; LANGDON, E. J. Gestaç o, parto e p s-parto entre os Munduruku do Amazonas: confrontos e articula  es entre o modelo m dico hegem nico e pr ticas ind genas de autoat n  o. **ILHA – Revista de Antropologia**, Florian polis, v. 19, n. 1, p. 183-216, 2017.

DIAS-SCOPEL, R.P. **A cosmopolítica da gestação, parto e pós-parto: práticas de autoatenção e processo de medicalização entre os índios Munduruku**. 2014. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

DIAS-SCOPEL, R. P. **A cosmopolítica da gestação, parto e pós-parto: práticas de autoatenção e processo de medicalização entre os índios Munduruku**. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2020.

DIAS-SCOPEL, R. P.; SCOPEL, D. Promoção da saúde da mulher indígena: contribuição da etnografia das práticas de autoatenção entre os Munduruku do Estado do Amazonas, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, e00085918, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00085918>. Acesso em: 4 nov. 2025.

DIEHL, E. E.; LANGDON, E. J. Transformações na atenção à saúde indígena: tensões e negociações em um contexto indígena brasileiro. **Universitas Humanística**, Bogotá, n. 80, p. 213–236, jul./dez. 2015. ISSN 0120-4807. doi: 10.11144/Javeriana.UH80.tasi.

DROTBOHM, H. O cuidado além do reparo. **Mana: Estudos de Antropologia Social**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, e281206, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-49442022v28n1a206>. Acesso em: 7 out. 2025.

DUMONT, E. (Coord.); BARRA, M. C. (Coord.). **Temí Totihi: guia de atenção ao pré-natal na Terra Indígena Yanomami**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2025. Projeto Redes de Cuidado na Terra Indígena Yanomami. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/b17d6001-edc6-4238-8415-234836c975ba>. Acesso em: 16 jan. 2026.

EDITOR@PAINTBOX.COM.BR. **Comunidade indígena fundada nos anos 1970 recebe abastecimento de água tratada pela primeira vez**. In: ÁGUAS DE MANAUS. 20 set. 2020. Disponível em: <https://www.aguasdemanaus.com.br/comunidade-indigena-fundada-nos-anos-1970-recebe-abastecimento-de-agua-tratada-pela-primeira-vez/>. Acesso em: 16 out. 2024.

ENK, M. S.; KIND, L. Indigenous Women's Politics of Care: Human and medicinal plants vital connections in the Caititu Land, Brazilian Amazon. **Archivio antropologico mediterraneo**, v. XXVIII, n. 27(1), 2025. Disponível em: <http://journals.openedition.org/aam/10487>. Acesso em: 4 nov. 2025.

FARIA, I. F. de; CASTRO, C. C.; OSOEGAWA, D. K. Povos indígenas: da negação da identidade e do território ao direito originário à terra no Amazonas. **Revista Ciência Geográfica**, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 926–950, 2022. Disponível em: <https://ppg.revistas.uema.br/index.php/cienciageografica/article/view/2926>. Acesso em: 4 jan. 2026.

FARIAS, A. S. de; NASCIMENTO, E. F. do; GOMES FILHO, M. R.; FELIX, A. C.; COSTA ARÉVALO, M. da; ADRIÃO, A. A. X. et al. Construindo um modelo explicativo para o atendimento de envenenamento por picada de cobra na Amazônia brasileira a partir da perspectiva dos cuidadores indígenas. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 3, e0011172, 2023.

FERNANDES, T. S. **Gravuras produzidas especialmente para esta pesquisa**. 2025. Ilustração. Material autoral.

FERREIRA, L. O. Os discursos oficiais e a emergência do tradicional como objeto de políticas públicas. In: **Medicinas indígenas e as políticas da tradição: entre discursos oficiais e vozes indígenas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013. p. 49-70. (Coleção Saúde dos Povos Indígenas). ISBN 978-85-7541-510-8. Disponível em: <https://doi.org/10.7476/9788575415108>. Disponível também em ePUB em: <http://books.scielo.org/id/f48w3/epub/ferreira-9788575415108.epub>.

FERREIRA, L. O. Saúde e relações de gênero: uma reflexão sobre os desafios para a implantação de políticas públicas de atenção à saúde da mulher indígena. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, n. 4, p. 1151–1159, 2013. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000400028>

FOLLÉR, Maj-Lis. Intermedicalidade: a zona de contato criada por povos indígenas e profissionais de saúde. In: LANGDON, Esther Jean; GARNELO, Luiza (org.). **Saúde dos povos indígenas: reflexões sobre antropologia participativa**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004. p. 106–120.

FONTES, F. B. Minha escrivência, experiências vividas e diálogo com as mulheres indígenas do Rio Negro – Amazonas/Brasil. **Cadernos de Campo** (São Paulo - 1991), São Paulo, Brasil, v. 29, n. 1, p. 179–186, 2020. doi: 10.11606/issn.2316-9133.v29i1p179-186. Disponível em: <https://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/169460>. Acesso em: 11 nov. 2025.

FREITAS, F. P. de P. As políticas de saúde indígena e a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 29, e250018, 2025. doi: 10.1590/interface.250018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.250018>. Acesso em: 04 nov. 2025.

FREITAS, M. A.; MATTOS, A. T. R. de; GOMES, W. Z.; CACCIA-BAVA, M. do C. G. G. Quem são, o que falam e quem escuta os pobres? **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 3859–3882, dez. 2017. doi: 10.1590/1413-812320172212.24852017.

FREITAS, M.; VILELA, P.; NWORA, E. Religiosity and Indigenous Cosmology in a Brazilian Hospital Setting: The Challenges Faced by Health Professionals. **International Journal of Latin American Religions**, v. 7, p. 46–77, 2023. DOI: 10.1007/s41603-023-00194-w.

FUNDO BRASIL. **Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas – Makira E'ta**. Disponível em: <https://www.fundobrasil.org.br/projeto/rede-de-mulheres-indigenas-do-estado-do-amazonas-makira-eta/>. Acesso em: 23 de set. 2024.

FUNDO BRASIL. **Centro de Medicina Indígena Bahserikowi**. Disponível em: <https://www.fundobrasil.org.br/projeto/centro-de-medicina-indigena-bahserikowi/>. Acesso em 23 de set. 2024.

GALLOIS, D. T. Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades? In: RICARDO, F. (Org.). **Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio das sobreposições territoriais**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004. Disponível em: <https://institutoiepe.org.br/wp-content/uploads/2020/07/doc11.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

GARDELLA, J. **Guatemala: melhorando a saúde materna de mulheres indígenas por meio de um modelo de atenção mista**. [S. l.]: Management Sciences for Health (MSH), 2024. Disponível em: <https://msh.org/stories/guatemala-improving-maternal-health-for-indigenous-women-through-a-blended-care-model/>. Acesso em: 26 out. 2025.

GARNELO, L.; SAMPAIO, S. de S; PONTES, A. L. **Atenção diferenciada: a formação técnica de agentes indígenas de saúde do Alto Rio Negro**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2019.

GARNELO, L.; SAMPAIO, S. Bases sócio-culturais do controle social em saúde indígena: problemas e questões na Região Norte do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 311–317, 2003. doi: 10.1590/S0102-311X2003000100035. Acesso em: 22 set. 2025.

GARNELO, L.; WRIGHT, R. Doença, cura e serviços de saúde: representações, práticas e demandas Baniwa. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 273–284, mar. 2001. doi: 10.1590/S0102-311X2001000200003. Acesso em: 22 set. 2025.

GARNELO, L.; PONTES, A. L. (Orgs.). **Saúde indígena: uma introdução ao tema**. Brasília: MEC/SECADI; UNESCO, 2012. (Série Vias dos Saberes, n. 5). ISBN 978-85-7994-063-7.

GATTI, B. A. **Grupo focal na pesquisa em Ciências sociais e humanas**. Brasília: Líber Livro 2005.

GEWEHR, R. B.; BAÊTA, J.; GOMES, E.; TAVARES, R. Sobre as práticas tradicionais de cura: subjetividade e objetivação nas propostas terapêuticas contemporâneas. **Psicologia USP**, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 33–43, 2017.

GIL, A. C. **Como Fazer Pesquisa Qualitativa**. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559770496/>. Acesso em: 15 out. 2024.

GOBBI, M. “Nóis” é ponte e atravessa qualquer rio: notas sobre mulheres, crianças, coletivos periféricos e o comum (ou, quando a pandemia é apenas mais um elemento). **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 42, n. 118, p. 359–372, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/CC253004>. Acesso em: 7 out. 2025.

GONDIM, G. M. de M.; MONKEN, M. Territorialização em saúde. In: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. **Dicionário da Educação Profissional em Saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2009. Disponível

em: <https://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html>. Acesso em 16 dez. 2025.

GONZÁLEZ-MARTELL, Andrea Daniela et al. La seguridad alimentaria y nutricional en una comunidad indígena de México. **Revista Española de Nutrición Comunitaria**, v. 25, n. 3, 2019.

GOTTLIEB, Alma. **Menstrual politics and the global body: anthropology and the menstrual taboo**. New York: Routledge, 2020.

GREENE, S. A agulha do xamã: desenvolvimento, agência xamânica e intermedicalidade nas terras Aguaruna, Peru. **American Ethnologist**, v. 25, n. 4, p. 634-658, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1525/ae.1998.25.4.634>. Acesso em: 30 mar. 2026.

GOV.BR: Secretaria de Comunicação Social: **Brasil tem mais de 8,5 mil localidades indígenas, segundo IBGE**. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/brasil-tem-mais-de-8-5-mil-localidades-indigenas-segundo-ibge>. Acesso em 07 out. 2025.

HELMAN, C. G. **Cultura, saúde e doença**. [S. l.: s. n.], 2009. p. 431–431. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-591615>. Acesso em: 15 out. 2024.

HUGH-JONES, S. Nomes secretos e riqueza visível: nominação no noroeste amazônico. **Mana: Estudos de Antropologia Social**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 45–68, 2002. doi: <https://doi.org/10.1590/S0104-93132002000200002>.

IBGE – **Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia**. Disponível em: <http://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasilindigena/os-indigenas-no-censo-demografico-2022>. Acessado em: 10 de agosto de 2023.

KERN, F.A. **a presença indígena na cidade de Manaus**. [S. l.], [s. d.]. Notícia. Disponível em: <https://www.kooperation-brasilien.org/pt-br/publicacoes-1/brasilicum/257-pandemia-e-ignorancia-politica/a-presenca-indigena-na-cidade-de-manaus>. Acesso em: 15 out. 2024.

KOPENAWA, D; ALBERT, B. **A queda do céu: palavras de um xamã yanomami**. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. Prefácio de Eduardo Viveiros de Castro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

LANGDON, E. J.; GARNELO, L. Articulation between health services and “indigenous medicine”: Anthropological reflections on policies and reality in Brazil. **Salud Colectiva**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 457, 2017.

LANGDON, E. J. Os diálogos da antropologia com a saúde: contribuições para as políticas públicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1019–1029, abr. 2014. DOI: 10.1590/1413-81232014194.22302013.

LERVOLINO, S. A.; PELICIONI, M. C. F. A utilização do grupo focal como metodologia qualitativa na promoção da saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, [s. l.], v. 35, n. 2, p. 115–121, 2001.

LIMA, E. C. C. de. Não somos Iracema: a imagem da mulher indígena sendo (re)escrita nas artes e nas literaturas. **Via Atlântica**, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 709–735, 2024. DOI: 10.11606/va.i1.199345. Disponível em: <https://revistas.usp.br/viaatlantica/article/view/199345>. Acesso em: 09 maio 2024.

LIMA, A. G. M. de; SOARES-PINTO, N. Parentesco com a terra e as cosmopolíticas indígenas do cuidado. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 38, n. 112, p. 173–194, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202438112.010>. Acesso em: 12 mai. 2025.

LOBO, N. A “**mãe do corpo**”, **entre o visível e o invisível**. 2026. Ilustração. Sumaúma, Santarém, PA, 5 jan. 2026. Disponível em: <https://sumauma.com/a-mae-do-corpo-entre-o-visivel-e-o-invisivel/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

LOPES, B. E. M. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. **Revista Educação e Políticas em Debate**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 482–492, ago./dez. 2014. doi: 10.14393/REPOD-v3n2a201430290. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/article/view/30290>. Acesso em: 30 set. 2025.

LORENZO, C. F. G. Desafios para uma bioética clínica interétnica: reflexões a partir da Política Nacional de Saúde Indígena. **Revista Bioética** (Impressa), Brasília, v. 19, n. 2, p. 329–342, 2011.

LUZ, M. T. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em saúde no fim do século XX. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 7, p. 13–43, 1997.

LUZ, M. T. **Natural, Racional, Social - Razão Médica e Racionalidade Científica Moderna**. 3. ed. São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2012.

LUZ, M. T.; BARROS, N. F. **Racionalidades e Práticas Integrativas em Saúde: estudos teóricos e empíricos**. 1. ed. UERJ / REDE SIRIUS / CBC Rio de Janeiro: UERJ/IMS/LAPPIS, 2012.

KOLLING, P.; SILVESTRI, M. Reflexões sobre território e terra indígena: aspectos culturais, sociais e jurídicos. **Para Onde!?**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 211–226, 2019. DOI: 10.22456/1982-0003.94569. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/paraonde/article/view/94569>. Acesso em: 25 nov. 2025.

MANAUS. **Secretaria Municipal de Saúde**. Disponível em: <https://semsa.manaus.am.gov.br>. Acessado em: 22 de set. de 2023.

MACHADO, J. M. H.; GALLO, E.; SETTI, A. F. F.; BUSS, D. F.; MAGALHÃES, D. de P.; FRANCO NETTO, F. de A.; BUSS, P. M. Sustentabilidade, desenvolvimento e saúde: desafios contemporâneos. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 36, n. esp. 1, p.

14–41, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042012E05>. Acesso em: 08 fev. 2026.

MANCHINERY, A. S. S.; ALMEIDA SILVA, A. DE. Mulheres Indígenas no Estado do Acre (BR): Território Tradicional do Movimentos Indígenas nas Cidades. **Revista Latino Americana de Geografia e Gênero**, v. 10, n. 1, p. 26–42, 2019.

MANZINI, E. J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-estruturada. In: MARQUEZINE, M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE, S. (Orgs.) **Colóquios sobre pesquisa em Educação Especial**. Londrina: eduel, 2003. p.11-25.

MANZINI, E. J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: **SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS**, 2, 2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais. Bauru: USC, 2004. CD-ROM. ISBN.

MELO, A. C.; SILVA, J. L.; SANTOS, A. L. S. dos; et al. Tendências populacionais na incidência e mortalidade por câncer de colo do útero no Brasil: foco nas disparidades entre as populações negra e indígena. **Journal of Racial and Ethnic Health Disparities**, v. 11, p. 255–263, 2024. doi: 10.1007/s40615-023-01516-6.

MELO, A. V.; SANT'ANA, G.; BASTOS, P.; ANTONIO, L. Bioética e interculturalidade na atenção à saúde indígena. **Revista Bioética**, Brasília, v. 29, n. 3, jul./set. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422021293485>. Acesso em: 15 out. 2024.

MENDES, A. M. et al. O desafio da atenção primária na saúde indígena no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [s. l.], v. 42, 2018. Disponível em: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49563>. Acesso em: 15 out. 2024.

MENDES, M. R. Z.; BATISTA, N. A.; VASQUEZ, E. L. Cosmovisão indígena sobre a temática saúde: uma experiência de ensino intercultural. **Science, Knowledge and Focus**, v. 1, n. 2, p. 61–80, 2018. doi: 10.18468/sc.knowl.focus. 2018 v. 1, n. 2.p. 61-80.

MENDONÇA, S. B. M. de. Saúde indígena: distâncias que aproximam. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (org.). **Cadernos HumanizaSUS – Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. v. 2, p. 179–194. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_humanizasus_atencao_basica_v2_1ed.pdf. Acesso em: 14 jan. 2026

MENÉNDEZ, E. L. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 185–207, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232003000100014>. Acesso em: 14 jan. 2026.

MENÉNDEZ, E. L. Autoatención de los padecimientos y algunos imaginarios antropológicos. **Desacatos**, n. 29, p. 161-178, 2009.

MENÉNDEZ, E. L. El modelo médico y la salud de los trabajadores. **Saúde Coletiva**, Buenos Aires, v.1, n.1, p.9-32, 2005. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73110102>. Acesso em: 8 out. 2025

MENEZES, D. **Entrevista André Baniwa: “Sem organização, não há como acessar políticas públicas”**. Mongabay, 23 mar. 2020.

MERHY, E.; FEUERWERKER, L.; CERQUEIRA, P. **Da repetição a diferença: construindo sentidos com o outro no mundo do cuidado**. 2010. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/De%20Repente%20%C3%A0%20Diferen%C3%A7a%20-%20Construindo%20Sentidos%20Com%20o%20Outro%20no%20Mundo%20do%20Cuidado.pdf#page=1. Acesso em: 25 nov. 2025.

MINAYO, M. C. de S.; MIRANDA, A. C. de (org.). **Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. p. 344. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 08 fev. 2026.

MIRANDA, V. A. M.; BELIZARIO, A. B. Q.; PEREIRA, M. F. Encontro de saberes: interculturalidade crítica e saúde coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva** [periódico eletrônico], jun. 2024. Disponível em: <http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/encontro-de-saberes-interculturalidade-critica-e-saude-coletiva/19295?id=19295>. Acesso em: 15 dez. 2025.

MIRANDA, V. Mulheres indígenas de Manaus: construindo políticas afirmativas no SUS. **Revista Psicologia e Saúde**, Campo Grande, p. 127–143, 2020. DOI: 10.20435/pssa.vi.1070. Disponível em: <https://pssa.ucdb.br/pssa/article/view/1070>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MIRANDA, C. M.; BARROSO, M. F. Mulheres na Amazônia: lutas em defesa de seus corpos-territórios. **Revista Estudos Feministas**, v. 31, n. 2, e92873, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n292873>. Acesso em: 29 nov. 2025.

MUNDURUKU, D. **Foi vovô que disse**. 2. ed. Porto Alegre: Edelbra, 2015. 24 p. ISBN 978-8566470871.

NASCIMENTO, M. C. D. et al. A categoria racionalidade médica e uma nova epistemologia em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 18, n. 12, p. 3595–3604, 2013.

NERES, D. **A “mãe do corpo”, entre o visível e o invisível**. Sumaúma, Santarém, PA, 5 jan. 2026. Disponível em: <https://sumauma.com/a-mae-do-corpo-entre-o-visivel-e-o-invisivel/>. Acesso em: 5 jan. 2026.

NÓBREGA, T. P. da. Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 13, n. 2, p. 141–148, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2008000200006>. Acesso em: 08 fev. 2025.

NORONHA, M. A etnopsiquiatria na sociedade contemporânea. **Presença**, Porto Velho, v. 3, n. 28, p. 1–17, 2004. Disponível em: http://www.revistapresenca.unir.br/artigos_presenca/28marcosdenoronha_aetnopsiquiatrianasociedade.pdf. Acesso em: 08 fev. 2025.

NUNES, E. S. Aldeias urbanas ou cidades indígenas? Reflexões sobre índios e cidades. **Espaço Ameríndio**, Porto Alegre, v. 4, n. 1, p. 9–31, 2010. doi: 10.22456/1982-6524.8289. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/8289>. Acesso em: 18 dez. 2025.

OLIVEIRA, M. **Marcivana Sateré Mawé: “A cultura e a identidade carregamos conosco”**. [S. l.], 2023. Disponível em: <http://nosmulheresdaperiferia.com.br/marcivana-satere-mawe-a-cultura-e-a-identidade-carregamos-conosco/>. Acesso em: 16 out. 2024.

OLIVEIRA, G. S.; CUNHA, A. M. O.; CORDEIRO, E. M.; SAAD, N. S. Grupo focal: uma técnica de coleta de dados numa investigação qualitativa? **Cadernos da Fucamp**, Monte Carmelo, v. 19, n. 41, p. 1–13, 2020.

OLIVEIRA, M. S. de; NAHUM-CLAUDEL, C; MARTÍN, J. G. Corpo e menstruação na Amazônia indígena: uma síntese. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 31, n. 3, p. e95367, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n395367>. Acesso em: 05 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas**. Rio de Janeiro: Nações Unidas, 2008. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf. Acesso em: 03 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. OMS adota resolução elevando saúde indígena ao nível de prioridade global. **ONU News**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/05/1815072>. Acesso em: 20 jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Estratégia e plano de ação sobre etnia e saúde 2019–2025**. Washington, D.C.: OPAS, 2019. Disponível em: <https://iris.paho.org/items/81718c8c-fab4-4a71-8c11-81e980c3ec73>. Acesso em: 30 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Países concordam em priorizar iniciativas para melhorar a saúde das populações indígenas**. Pan American Health Organization – PAHO, 29 maio 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/29-5-2023-paises-concordam-em-priorizar-iniciativas-para-melhorar-saude-das-populacoes>. Acesso em: 04 mai. 2024.

PEDRANA, L. et al. Análise crítica da interculturalidade na Política Nacional de Atenção às Populações Indígenas no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [s. l.], v. 42, 2018. Disponível em: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49558>. Acesso em: 15 out. 2024.

PEREIRA, J. C. M. Indígenas na cidade de Manaus (AM). **Novos Cadernos NAEA**, [S.l.], v. 23, n. 3, jan. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/8257/6749>. Acesso em: 01 out. 2024.

PEREIRA, J. C. M. **Indígenas na metrópole: lutas multiétnicas e identidade coletiva na cidade de Manaus** (AM). 2018. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://portal.ufrj.br/wp-content/uploads/2018/06/Os-ind%C3%ADgenas-na-cidade-de-Manaus-Vers%C3%A3o-final.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2025.

PEREIRA, A.S. **Metodologia da pesquisa científica** [recurso eletrônico] 1. ed. – Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2018.

PONTES, A. L. De M.; REGO, S; GARNELO, L. O modelo de atenção diferenciada nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas: reflexões a partir do Alto Rio Negro/AM, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 10, p. 3199-3210, 2015.

RAMOS, E. U. Mulher indígena da tradição entre serras Pankararu. In: MENDONÇA, Caroline Leal; LEAL, Elizabeth; ANDRADE, Lara Erendira Almeida de; SCHILLACI, Manuela (org.). **Mulheres indígenas: tradição, luta e resistência**. [S. l.]: Conselho Indigenista Missionário – CIMI, 2019. p. 21–25. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/03/livro-mulheres-indigenas-tradicao.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2026.

RAYMUNDO, M. M. Uma aproximação entre bioética e interculturalidade em saúde a partir da diversidade. **Clinical and Biomedical Research**, [S. l.], v. 31, n. 4, 2012. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/hcpa/article/view/24281>. Acesso em: 30 mar. 2026. DOI: 10.22491/2357-9730.24281.

REDE MAKIRA-E'TA. **A Makira-E'ta**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.makiraeta.com/>. Acesso em: 16 out. 2024.

RIBEIRO, B. N. P. Corpo e pessoa Assuriní: práticas de resguardo na Aldeia Indígena Trocará. **Revista Wamon** – Revista dos Alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM, v. 5, n. 1, p. 89-102, jul./dez. 2020. DOI: 10.29327/217579.5.1-7

ROMERO, G. et al. Medicina indígena e as práticas de cuidado em saúde na América Latina: Uma revisão integrativa. In: **16º Congresso Internacional da Rede Unida - Revista Saúde em Redes**, v. 10, Supl. 2 (2024) - Editora Rede Unida - doi: 10.18310/2446-48132024v10nsup2, 2023. Disponível em: <https://doity.com.br/anais/16congressointernacionaldaredeunida/trabalho/370668>. Acesso em: 13 nov. 2025.

SARDENBERG, C. M. B. De Sangrias, Tabus e Poderes: a menstruação numa perspectiva sócio-antropológica. **Revista Estudos Feministas**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 314, 1994. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16215>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SANTOS, G. R. dos; SOUZA, L. C. de; MARTINS, M. de S.; MARTINS, C. B. de S. Reterritorialização e a promoção da sustentabilidade na Tawa Hywi (Aldeia Gavião), Sateré-Mawé – Manaus/AM. **Revista Foco**, [s. l.], v. 18, n. 5, p. e8629, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/8629>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SANTOS, F. V. et al. Corpos e cura na cidade: categorizações nosológicas relacionadas ao covid-19 entre moradores de uma comunidade Tikuna de Manaus, Amazonas, Brasil. **Espaço Ameríndio**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 260–278, 2023.

SANTOS, C. M. dos; PEREIRA, J. M. O estigma da presença de indígenas em contexto urbano na cidade de Imperatriz – MA. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, [s. l.], v. 7, n. 12, p. 113463–113473, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/40877>. Acesso em: 09 fev. 2024.

SANTOS, R. V; COIMBRA JR., C. E. A. (org.). **Saúde e povos indígenas**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. p. 251. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SCHWEICKARDT, J. C.; BARRETO, J. P. **Trançar, destrançar e tecer na dança e no canto: práticas da medicina indígena na Amazônia**. 1. ed. Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2023. (Série Saúde & Amazônia, v. 25). ISBN 978-65-5462-068-0.

SCOPEL, D; LANGDON, E.J. Intermedicalidade e práticas de autoatenção entre os povos indígenas no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, supl. 3, p. e00085918, 2019.

SILVA, R. N. P. De aldeados a urbanizados: aspectos da identidade étnica indígena na Cidade de Manaus. **Rua** (UNICAMP), Campinas, v. 5, n. 00, p. 109-119, 1999. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/download/8640667/8211/11392>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SILVA, J. B. F. da; NÓBREGA, R. G.; ALMEIDA, S. A. de; LIMA, É. A. R. de; SILVA, A. C. de O. e; NOGUEIRA, J. de A. O olhar de mulheres índias e não índias sobre a aids: convergências e singularidades. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 54, e03552, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018032403552> Acesso em 19 out. 2025.

SOARES, Ana Manoela Primo dos Santos. Sangue menstrual na sociedade Karipuna do Amapá, Brasil. **Amazônica – Revista de Antropologia, Belém**, v. 11, n. 2, p. 413-434, 2019. doi: <https://doi.org/10.18542/amazonica.v11i2.7548>

SODRÉ, F; ROCON, P. C. O trabalho em saúde pode ser considerado “tecnologia leve?”. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 32, n. 1, e210545pt, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023210545pt>. Acesso em: 30 mar. 2026.

SOUZA, E.R. **Relações Interétnicas em Contexto Urbano: Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno – COPIME**. Disponível em: <http://ipol.org.br/defesa->

postuma-da-dissertacao-de-ely-ribeiro-de-httpsouza-macuxi/ 2021. Acessado em: 07 ago. 2024.

SOUZA, S. Lutana Kokama abraçada à sua mãe, Raimunda, cacica geral eleita pela comunidade, exemplo de liderança feminina em bairro indígena de Manaus. 2023. Fotografia. AZ Mina. **Projeto Colabora**. Disponível em: <https://projetocolabora.com.br/ods11/mulheres-lideram-lutam-para-manter-cultura-indigena-em-area-urbana/>. Acesso em: 02 set. 2024.

SOMPRÉ, I. **Saúde Intercultural**. Instagram. 2025. Publicação em rede social. Disponível em: https://www.instagram.com/idjarrury_sompre?igsh=NXo4cnAzNGY5NThs. Acesso em: 05 jan. 2026.

STARFIELD, B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia**. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p.

TAPIRAPÉ, K. V. O corpo e a pessoa entre os Apyãwa: resguardos, alimentos para os espíritos e transição alimentar. In: DIAS, L. O.; ALVAREZ, G. O. (orgs.). **Frutos das ações afirmativas na antropologia social**. Goiânia: Cegraf UFG, 2025. p. 109–146. (Coleção Diferenças). E-book (PDF). doi: <https://doi.org/10.63756/CegrafUFG.FRU.ebook.978-85-495-1196-6/202525-295934.1>. ISBN 978-85-495-1196-6.

TASSINARI, A. A “mãe do corpo”: conhecimentos das mulheres Karipuna e Galibi-Marworno sobre gestação, parto e puerpério. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, v. 27, n. 60, p. 95–126, 2021. doi: 10.1590/S0104-71832021000200004.

TESSER, C. D.; LUZ, M. T. Racionalidades médicas e integralidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 195–206, 2008.

TEIXEIRA, P.; MAINBOURG, E. M. T.; BRASIL, M. Migração do povo indígena Sateré-Mawé em dois contextos urbanos distintos na Amazônia. **Caderno CRH**, v. 22, n. 57, p. 531–546, 2009. doi: 10.1590/S0103-49792009000300008.

TETEMANN, E. C; TRUGILHO, S. M; SOGAME, L. C. M. Universalidade e territorialização no SUS: contradições e tensões inerentes. **Textos & Contextos (Porto Alegre)**, [s. l.], v. 15, n. 2, p. 356–369, 2016. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/25456>. Acesso em: 17 dez. 2025.

TOBIAS, R. et al. (org.). **A saúde indígena nas cidades: redes de atenção, cuidado tradicional e intercultural**. Porto Alegre: Editora Rede UNIDA, 2023.

TOBIAS, R; CIDADE, F. C; SOUZA, L. C.; LIMA, M. C. R. F. de; SANTOS, G. R. dos; MATA, L. M. da. Direito à cidade para povos indígenas na perspectiva do direito à saúde: uma revisão integrativa. **ARQ.URB**, [S. l.], n. 38, p. 31–41, 2023. Disponível em: <https://revistaarqurb.com.br/arqurb/article/view/679>. Acesso em: 18 dez. 2025.

VERAS, I. de A.; BANDEIRA, M. A. M.; SÁ, K. M.; COUTINHO JÚNIOR, M. E. P.; SOARES, I. L.; SIQUEIRA, J. E. F.; LIBERATO, F. L. R.; VERISSIMO, M. L. C.

Tradição e saúde: o uso de plantas medicinais por mulheres Tapeba em Caucaia – Ceará. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 9, p. e18261, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/18261>. Acesso em: 10 nov. 2025.

VIANA, J. Povos indígenas em contexto urbano: uma realidade esquecida pelos governos. **Comissão Episcopal para a Amazônia**, 1 jan. 2023. Disponível em: <https://comissaoepiscopalamazonia.org/2023/01/12/povos-indigenas-em-contexto-urbano-uma-realidade-esquecida-pelos-governos/>. Acesso em: 04 nov. 2025.

VIVEIROS DE CASTRO, E. A fabricação do Corpo na Sociedade Xinguana. In: Oliveira Filho J. P. (Org.). **Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil**. Rio de Janeiro: Marco Zero, UFRJ; 1987. p. 31-34.

YACUNATUXA. **Não somos Iracema**. Instagram. 2020. Publicação em rede social. Disponível em: <https://www.instagram.com/yacunatuxa/>. Acesso em: 20 out. 2024.

APÊNDICE A - ROTEIRO DO DIÁRIO DE CAMPO

O diário de campo é um instrumento importante para a prática da observação, pois nele são registradas não só as percepções sobre as atividades de trabalho, mas também todas as informações correlatas ao tema da pesquisa. Será realizado um apanhado e registro dos dados pelo observador logo após as atividades desenvolvidas com as impressões, sensações, informações e fatos captados e registrados sobre o cenário estudado, espaço físico, relação dos participantes, suas características pessoais, comportamentos, interações e cronologia dos eventos. A elaboração de um roteiro serve para orientar a observação e organizar os registros.

O roteiro será sistematizado baseado na recomendação de Angrosino (2009) da seguinte forma:

1. **Explicação do cenário estudado** (casa, associação, comunidade, bairro)
2. **Descrição do espaço físico e seus componentes materiais** (aparência, características físicas, arquitetura, distribuição do espaço).
3. **Relação dos participantes** (etnia, clã, quantidade, gênero, idade)
4. **Descrição objetiva dos participantes** (Aparência física, formas de vestir)
5. **Descrição de comportamentos e interações** (quem esteve no local, de que maneira esteve, como se envolveu, descrição detalhada dos comportamentos, olhares, gestos).
6. **Cronologia dos eventos** (tempo e sequência do início ao fim)
7. **Registro de conversas e outras interações verbais** (como, por exemplo, conversas privadas do sujeito que estão para além das narrativas da/na entrevista).
8. **Comentários do observador** (as notas de campo podem incluir comentários críticos acerca do que é dito ou observado).

APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

RACIONALIDADES NO CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA EM
CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Instrumento: Roteiro para entrevista:

Nome:

Idade:

Etnia:

Comunidade/Aldeia de origem:

Estado civil:

Profissão:

Número de filhos:

A - Concepção Geral sobre Saúde e Serviços de Saúde

1 - O que é saúde para você e para a sua etnia?

2 - Você utiliza os serviços de saúde, como unidades de saúde da família e postos de saúde?

3 - Como é o atendimento prestado pelo serviço de profissionais de saúde dos postos?

4 - Você sente dificuldade em falar de sua saúde para os profissionais de saúde das unidades de saúde (postos)?

5 - Se sim, quais são as dificuldades?

6 - O que você acha que seria importante para melhorar o atendimento à sua saúde nos postos de saúde?

7 - Como você percebe que as práticas tradicionais de cuidado são recebidas nas unidades de Atenção Primária?

8 - Qual a relação entre as práticas tradicionais de cuidado e os atendimentos realizados na Atenção Primária?

9 - Você já recebeu orientações de cuidados em saúde nas unidades de saúde com base nas suas práticas tradicionais? Comente:

B - Conhecimentos Tradicionais em Saúde

- 1 - Você utiliza alguma prática de acordo com seus costumes?
- 2 - Quais os cuidados de saúde da sua tradição/costumes que você utiliza?
- 3 - Com quem e como você aprendeu esses cuidados?
- 4 - Em relação a essa prática que você utiliza, poderia explicar por que é utilizada?
- 5 - De onde veio essa aprendizagem sobre essa prática?
- 6 - Como e por que isso funciona para essa questão/cuidado/doença? Pode me explicar?

C- Práticas Específicas Voltadas para Aspectos da Saúde Feminina - Ciclos da Mulher

Quais são os cuidados e práticas de saúde utilizados nas diferentes fases da mulher de acordo com sua tradição/costumes?

- 1 - Menarca
- 2 - Sexualidade e Concepção
- 3 - Gestação e Processo de Gestação
- 4 - Parto
- 5 - Pós-parto e Puerpério
- 6 - Climatério e Menopausa
- 7 - O que mais existe sobre a saúde da mulher dentro da sua rotina para manter a saúde?

APÊNDICE C - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL

Nos encontros com os grupos das associações indígenas do estudo, serão utilizadas notícias de jornais, mídias sociais e relatos sobre fatos relacionados a cuidados e atendimentos em unidades de saúde a indígenas no contexto urbano, com dados estatísticos sobre o assunto, com intuito de provocar as discussões com os integrantes dos grupos. Assim, construir um diálogo sobre assistência à saúde indígena em contexto urbano e assistência na atenção primária e identificar as práticas tradicionais de cuidado à saúde da mulher que as mesmas utilizam de acordo com sua cultura.

APÊNDICE D - TCLE - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA**

PESQUISA: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: qualificando a atenção integral à saúde.

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga e coorientação do Prof. Dr. André Petraglia Sassi.

Prezada Sra.

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) se refere ao Projeto de pesquisa de mestrado: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, que está sendo desenvolvido por mim, Dalva Nascimento Coimbra, com a responsabilidade e orientação do Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga e coorientação do Prof. Dr. André Petraglia Sassi.

Você está sendo convidada a participar deste estudo. A seguir, esclarecemos e descrevemos as condições e objetivos do estudo.

Geral: Compreender a relação entre as práticas tradicionais de cuidado à saúde utilizadas por mulheres indígenas com a prestação de serviços de Atenção Primária à Saúde na cidade de Manaus.

Sendo seus objetivos específicos: Identificar quais as práticas tradicionais de cuidados à saúde (preventivos, menstruação, cuidados na idade adulta e na terceira idade) que as mulheres indígenas utilizam no contexto da cidade de Manaus; Descrever a percepção das mulheres indígenas sobre o processo saúde-doença; Descrever a interface entre os cuidados tradicionais indígenas e os serviços de Atenção Primária; Construir material educativo sobre os cuidados e práticas tradicionais na saúde da mulher indígena no contexto urbano de Manaus.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. Meios de contato com o CEP UFRGS: Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: +55 51 3308 3787. E-mail: etica@propeq.ufrgs.br. Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. Meios de contato com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D – Edifício PO 700, 5º andar, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70719-040. Fone: +55 61 33155878. E-mail: conep@saude.gov.br

As atividades pretendidas serão realizadas em associações e comunidades indígenas da cidade de Manaus. As atividades previamente agendadas com as mulheres participantes que pretendendo realizar são as seguintes:

Realizar reunião participativa para apresentar o projeto à comunidade envolvida; realizar entrevista com roteiro semiestruturado; executar grupos focais com as mulheres indígenas; elaborar material educativo com as tecnologias de cuidado em saúde e conhecimentos tradicionais utilizados no autocuidado feminino indígena.

Ao participar deste estudo, você será convidada a uma entrevista e a entrevista será gravada. É previsto em torno de 30 a 60 min, podendo ser realizada no local escolhido e determinado por você. Você tem a liberdade de se recusar a participar e tem a liberdade de desistir de participar em qualquer momento que decida.

Serão solicitadas algumas informações básicas/perguntas sobre saúde, as práticas tradicionais de cuidado à saúde utilizadas por você de acordo com o seu povo e utilização de serviços de Atenção Primária à Saúde na cidade de Manaus. As entrevistas e transcrições de dados poderão ser apresentadas a você caso queira fazer correções ou complementações que achar necessárias.

Você terá informações e retornos sobre o desenvolvimento, etapas e resultados da pesquisa, assim como acesso ao material educativo produzido. Será realizada ao final da pesquisa uma roda de conversa para apresentação dos resultados da pesquisa para todos os grupos participantes.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na pesquisa, conforme a Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde. Durante esta pesquisa, segundo consta nas leis que regem sobre pesquisas com seres humanos, os possíveis riscos mínimos relacionados a quebra de confidencialidade e mobilização de experiências ruins vividas pelas participantes em serviços de saúde serão minimizados pelo cuidado com o armazenamento e utilização dos dados e com relação à mobilização de memórias desagradáveis, as entrevistas serão interrompidas, oferecido apoio para as mulheres e encaminhamento para serviço de saúde local se necessário. Contudo, ressalto que, como membro da equipe do estudo, farei o possível para deixar as participantes à vontade para responder à entrevista, dando tempo suficiente para que ela possa desistir ou concluir e dar segurança necessária para evitar riscos, estando sempre à disposição para realizar o atendimento necessário. Tais riscos e possibilidades de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente, serão resolvidos com encaminhamentos que garantam cuidados e respeito de acordo com a manifestação do respondente. Conforme a Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 19, o pesquisador estará atento aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos participantes, adotando medidas de precaução para evitar ou minimizar danos. Para mitigar esses riscos, será garantida a confidencialidade e o sigilo das informações pessoais através de armazenamento seguro dos dados, com acesso restrito à equipe responsável. Caso alguma participante manifeste desconforto emocional ou reviva experiências traumáticas durante as entrevistas, estas serão imediatamente interrompidas. Adicionalmente, será informada à participante que ela terá acesso a atendimento adequado de acordo com a necessidade, em caso de acidentes ou mal-estar durante a pesquisa, de forma imediata, gratuita e integral, fornecido pela equipe do estudo, sob a responsabilidade do pesquisador responsável e serão custeados pelo pesquisador responsável, sem sobrecarregar o Sistema Único de Saúde (SUS). Havendo algum dano durante a participação na pesquisa, a participante terá direito a ser indenizada pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, pelo pesquisador responsável, Prof. DR. Luiz Fernando Calage Alvarenga. Essas ações visam assegurar uma condução ética da

pesquisa, protegendo os direitos e o bem-estar dos participantes em todas as etapas do estudo.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Todas as informações coletadas nesta investigação são estritamente confidenciais, garantindo o resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada. Trataremos todas as informações sem que haja identificação de particularidades de cada entrevistada. Os resultados obtidos na pesquisa serão utilizados para alcançar os objetivos do trabalho expostos acima, incluindo a possível publicação na literatura científica especializada. Todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo, físico ou digital, sob guarda e responsabilidade do/a pesquisador(a), por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa (Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 28, Inciso IV).

Após o encerramento da pesquisa, será realizado um momento de retorno para todos os grupos participantes, por meio de rodas de conversa, nas quais serão apresentados os resultados do estudo e o produto educativo desenvolvido em formato acessível ao grupo pesquisado (em conformidade com a Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 3º, Inciso IV). Além disso, serão realizadas atividades de educação em saúde para as participantes e suas comunidades, bem como ofertadas ações de educação permanente para profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), a partir do material produzido com o estudo da pesquisa, trazendo benefícios diretos aos participantes da pesquisa sem prejuízo do retorno à sociedade em geral.

A senhora tem o direito de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais, incluindo a preservação de sua intimidade, inclusive do uso do som de sua voz. Não haverá divulgação do som de voz por qualquer meio de comunicação (televisão, rádio, internet), exceto em atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa explicitadas anteriormente. Os registros de voz realizados nesta pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins de análise pela equipe de pesquisa, conforme os objetivos do estudo.

Diante disso, a senhora declara que:

() Sim, autorizo a gravação e/ou divulgação da minha voz, nos termos acima descritos.

() Não, não autorizo a gravação e/ou divulgação da minha voz nos termos acima descritos.

() Autorizo a gravação da minha voz, mas não autorizo sua divulgação, nos termos acima descritos.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Eu autorizo livre e voluntariamente que a pesquisadora realize gravações de minha voz para fins de pesquisa científica/educacional. Concordo que o material obtido a partir dos meus relatos possa ser utilizado em aulas, congressos, eventos científicos, palestras, dissertações, teses ou publicações em periódicos científicos. Ressalto que não serei identificada por nome ou qualquer outra forma de identificação nesses materiais.

As gravações permanecerão sob a propriedade do(a) pesquisador(a). Considerando meu direito ao sigilo e à confidencialidade das informações prestadas, bem como à decisão sobre se minha identidade será divulgada ou não, esta opção foi registrada neste documento e será rigorosamente respeitada durante toda a condução do estudo (Resolução CNS nº 510/2016, Artigos 9º e 17).

Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto; entretanto, esperamos que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício de outras pessoas, mulheres indígenas em contexto urbano, para a comunidade na qual está inserida e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida e saúde, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Sra. não terá nenhum tipo de despesa por participar da pesquisa, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação. Entretanto, caso a Sra. tenha alguma despesa decorrente desta pesquisa, será totalmente ressarcida pelo coordenador responsável.

Os pesquisadores se comprometem a dar início a este projeto somente após a aprovação do Sistema CEP/CONEP, conforme a Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, e a não utilizar as informações dessa pesquisa para fins comerciais. As informações serão utilizadas apenas de acordo com os objetivos descritos neste Termo.

Desde já, agradecemos a atenção e a participação. Caso queiram contatar a equipe, isso poderá ser feito através do contato com os pesquisadores responsáveis Luiz Fernando Calage Alvarenga, através do telefone (51) 99186 4114 e/ou Dalva Nascimento Coimbra, através do telefone (92) 981146264, ou diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (51) 3308 3738.etica@propesq.ufrgs.br Av. Paulo Gama, 110, Sala 311 Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que participe desta pesquisa. Para tanto, preencha os itens que se seguem\;

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, _____, entendi os objetivos desta pesquisa, bem como a forma de participação. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto concordo em participar.

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela pesquisa e a outra com a participante.

Local e data: _____

(Assinatura do participante)

Eu, _____, membro da equipe do projeto RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa.

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE ou do pesquisador responsável).

APÊNDICE E - TCLE - TCLE - GRUPO FOCAL**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GRUPO FOCAL**

PESQUISA: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: qualificando a atenção integral à saúde.

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga e coorientação do Prof. Dr. André Petraglia Sassi.

Prezada Sra.

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), se refere ao Projeto de pesquisa de mestrado: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, que está sendo desenvolvida por mim, Dalva Nascimento Coimbra, com a orientação do Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga e coorientação do Prof. Dr. André Petraglia Sassi.

Você está sendo convidada a participar deste estudo. A seguir, esclarecemos e descrevemos as condições e objetivos do estudo.

Geral: Compreender a relação entre as práticas tradicionais de cuidado à saúde utilizadas por mulheres indígenas com a prestação de serviços de Atenção Primária à Saúde na cidade de Manaus.

Sendo seus objetivos específicos: Identificar quais as práticas tradicionais de cuidados à saúde (preventivos, menstruação, cuidados na idade adulta e na terceira idade) que as mulheres indígenas utilizam no contexto da cidade de Manaus; Descrever a percepção das mulheres indígenas sobre o processo saúde-doença; Descrever a interface entre os cuidados tradicionais indígenas e os serviços de Atenção Primária; Construir material educativo sobre os cuidados e práticas tradicionais na saúde da mulher indígena no contexto urbano de Manaus.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. Meios de contato com o CEP UFRGS: Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: +55 51 3308 3787 E-mail: etica@propeq.ufgrs.br Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30h. Meios de contato com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa- CONEP, SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D – Edifício PO 700, 5º andar, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70719-040. Fone: +55 61 33155878 E-mail: conep@saude.gov.br

As atividades pretendidas serão realizadas em associações e comunidades indígenas da Cidade de Manaus. As atividades previamente agendadas com as mulheres participantes que pretendendo realizar são as seguintes:

Realizar reunião participativa para apresentar o projeto à comunidade envolvida; realizar entrevista com roteiro semiestruturado; executar grupos focais com as mulheres indígenas; elaborar material educativo com as tecnologias de cuidado em saúde e conhecimentos tradicionais utilizados no autocuidado feminino indígena.

Ao participar deste estudo você será convidada a participar de um grupo focal e a reunião será gravada. É previsto em torno de 60 min a 90 min podendo ser realizada no local escolhido e determinado pelas mulheres entrevistadas. Você tem a liberdade de se recusar a participar e tem a liberdade de desistir de participar em qualquer momento que decida. Serão abordadas algumas informações básicas/perguntas sobre saúde, as práticas tradicionais de cuidado à saúde utilizadas por você de acordo com o seu povo e utilização de serviços de Atenção Primária à Saúde na cidade de Manaus. As gravações do grupo focal e transcrição de dados, poderão ser apresentadas a você caso queira fazer correções ou complementações que achar necessárias

Você terá informações e retornos sobre o desenvolvimento, etapas e aos resultados da pesquisa, assim como acesso ao material educativo produzido. Será realizada ao final da pesquisa uma roda de conversa para apresentação dos resultados da pesquisa para todos os grupos participantes.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na pesquisa, conforme a Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde. Durante esta pesquisa, segundo consta nas leis que regem sobre pesquisas com seres humanos, os possíveis riscos mínimos relacionados a quebra de confidencialidade e mobilização de experiências ruins vividas pelas participantes em serviços de saúde serão minimizados pelo cuidado com o armazenamento e utilização dos dados e com relação à mobilização de memórias desagradáveis, as entrevistas serão interrompidas, oferecido apoio para as mulheres e encaminhamento para serviço de saúde local se necessário. Contudo, ressalto que como membro da equipe do estudo, farei o possível para deixar as participantes à vontade para responder a entrevista, dando tempo suficiente para que a mesma possa desistir ou concluir e dar segurança necessária para evitar riscos, estando sempre à disposição para realizar o atendimento necessário. Tais riscos e possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente; serão resolvidos com encaminhamentos que garantam cuidados e respeito de acordo com a manifestação do respondente. Conforme a Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 19, o pesquisador estará atento aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos participantes, adotando medidas de precaução para evitar ou minimizar danos. Para mitigar esses riscos, será garantida a confidencialidade e o sigilo das informações pessoais através de armazenamento seguro dos dados, com acesso restrito à equipe responsável. Caso alguma participante manifeste desconforto emocional ou reviva experiências traumáticas durante as entrevistas, estas serão imediatamente interrompidas.

Adicionalmente, será informada à participante que ela terá acesso a atendimento adequado de acordo com a necessidade, em caso de acidentes ou mal-estar durante a pesquisa, de forma imediata, gratuita e integral fornecido pela equipe do estudo, sob a responsabilidade do pesquisador responsável e serão custeados pelo pesquisador responsável, sem sobrecarregar o Sistema Único de Saúde (SUS). Havendo algum dano durante a participação na pesquisa, a participante terá direito a ser indenizada pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, pelo pesquisador responsável, Prof. Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga. Essas ações visam assegurar uma condução ética da

pesquisa, protegendo os direitos e o bem-estar dos participantes em todas as etapas do estudo.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Todas as informações coletadas nesta investigação são estritamente confidenciais garantindo o resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada. Trataremos todas as informações sem que haja identificação de particularidades de cada entrevistada. Os resultados obtidos na pesquisa serão utilizados para alcançar os objetivos do trabalho expostos acima, incluindo a possível publicação na literatura científica especializada. Todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo, físico ou digital, sob guarda e responsabilidade do/a pesquisador(a), por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa (Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 28, Inciso IV).

Após o encerramento da pesquisa, será realizado um momento de retorno para todos os grupos participantes, por meio de rodas de conversa, nas quais serão apresentados os resultados do estudo e o produto educativo desenvolvido em formato acessível ao grupo pesquisado (em conformidade com a Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 3º, Inciso IV). Além disso, serão realizadas atividades de educação em saúde para as participantes e suas comunidades, bem como ofertadas ações de educação permanente para profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), a partir do material produzido com o estudo da pesquisa, trazendo benefícios diretos aos participantes da pesquisa sem prejuízo do retorno à sociedade em geral.

A senhora tem o direito de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais, incluindo a preservação de sua intimidade, inclusive do uso do som de sua voz. Não haverá divulgação do som de voz por qualquer meio de comunicação (televisão, rádio, internet), exceto em atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa explicitadas anteriormente. Os registros de voz realizados nesta pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins de análise pela equipe de pesquisa, conforme os objetivos do estudo.

Diante disso, a senhora declara que:

() Sim, autorizo a gravação e/ou divulgação da minha voz, nos termos acima descritos.

() Não, não autorizo a gravação e/ou divulgação da minha voz nos termos acima descritos.

() Autorizo a gravação da minha voz, mas não autorizo sua divulgação, nos termos acima descritos.

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

Eu autorizo livre e voluntariamente que a pesquisadora realize gravações de minha voz para fins de pesquisa científica/educacional. Concordo que o material obtido a partir dos meus relatos possa ser utilizado em aulas, congressos, eventos científicos, palestras, dissertações, teses ou publicações em periódicos científicos. Ressalto que não serei identificada por nome ou qualquer outra forma de identificação nesses materiais.

As gravações permanecerão sob a propriedade do(a) pesquisador(a). Considerando meu direito ao sigilo e à confidencialidade das informações prestadas, bem como à decisão sobre se minha identidade será divulgada ou não, esta opção foi registrada neste documento e será rigorosamente respeitada durante toda a condução do estudo (Resolução CNS nº 510/2016, Artigos 9º e 17).

Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto; entretanto, esperamos que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício de outras pessoas, mulheres indígenas em contexto urbano, para a comunidade na qual está inserida e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida e saúde, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Sra. não terá nenhum tipo de despesa por participar da pesquisa, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação. Entretanto, caso a Sra. tenha alguma despesa decorrente desta pesquisa será totalmente ressarcida pelo coordenador responsável.

Os pesquisadores se comprometem a dar início a este projeto somente após a aprovação do Sistema CEP/CONEP conforme a Norma Operacional CNS nº 001 de 2013 e a não utilizar as informações dessa pesquisa para fins comerciais. As informações serão utilizadas apenas de acordo com os objetivos descritos neste Termo.

Desde já, agradecemos a atenção e a participação. Caso queiram contatar a equipe, isso poderá ser feito através do contato com os pesquisadores responsáveis Luiz Fernando Calage Alvarenga através do telefone (51) 99186 4114 e/ou Dalva Nascimento Coimbra, através do telefone (92) 981146264, ou diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (51) 3308 3738.etica@propesq.ufrgs.br Av. Paulo Gama, 110, Sala 311 Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que participe desta pesquisa. Para tanto, preencha os itens que se seguem:

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, _____, entendi os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto e concordo em participar.

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela pesquisa e a outra com o(a) participante.

Local e data: _____

(Assinatura do participante)

Eu, _____, membro da equipe do projeto RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa.

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE ou o pesquisador responsável)

Rubrica do pesquisador Responsável: _____

Rubrica do Participante da Pesquisa do Representante Legal:

APÊNDICE F - CARTA DE ANUÊNCIA DAS ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES INDÍGENAS



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Faculdade de Medicina

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde - Mestrado Profissional

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA

Eu, _____, declaro conhecer o projeto de pesquisa intitulado TECNOLOGIAS DE CUIDADOS EM SAÚDE DA MULHER INDIGENA EM CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, de responsabilidade da pesquisadora Dalva Nascimento Coimbra e responsabilidade do orientador Prof Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga e coorientador Prof. Dr. André Petraglia Sassi

Declaro ter ciência que o objetivo geral da proposta é qualificar a assistência e cuidado integral à saúde da mulher indígena na cidade de Manaus.

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança das informações e do bem-estar de seus participantes da pesquisa.

Assim, manifesto-me favorável a realização da pesquisa citada acima

Manaus, de de 2024.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO/A PESQUISADOR(A)

Eu, _____, pesquisador(a) do projeto de pesquisa RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, declaro o compromisso de não patentear, nem usar para fins comerciais, o conhecimento tradicional adquirido em campo e catalogado. O conhecimento tradicional será utilizado de acordo com os objetivos propostos pela pesquisa e o consentimento da comunidade, e com ela será repartido em conformidade com a Resolução CNS no 304 de 2000 (Art. 19, item 2.5.4) e com a Lei 13.123/2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Comprometo-me a dar início a este projeto somente após a aprovação do Sistema CEP/CONEP em conformidade com a Norma Operacional CNS nº 001 de 2013 (item 3.3.f). Em relação à coleta de dados, eu pesquisador responsável, asseguro que o caráter de anonimato dos participantes desta pesquisa será mantido e que as suas identidades serão protegidas. Mantereí um registro de inclusão dos participantes de maneira sigilosa, contendo códigos, nomes e endereços para uso próprio.

Os Termos assinados pelos participantes serão mantidos em confiabilidade estrita, juntos em um único arquivo, físico ou digital, sob minha guarda e responsabilidade por um período mínimo de 05 anos.

Asseguro que os participantes desta pesquisa receberão uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

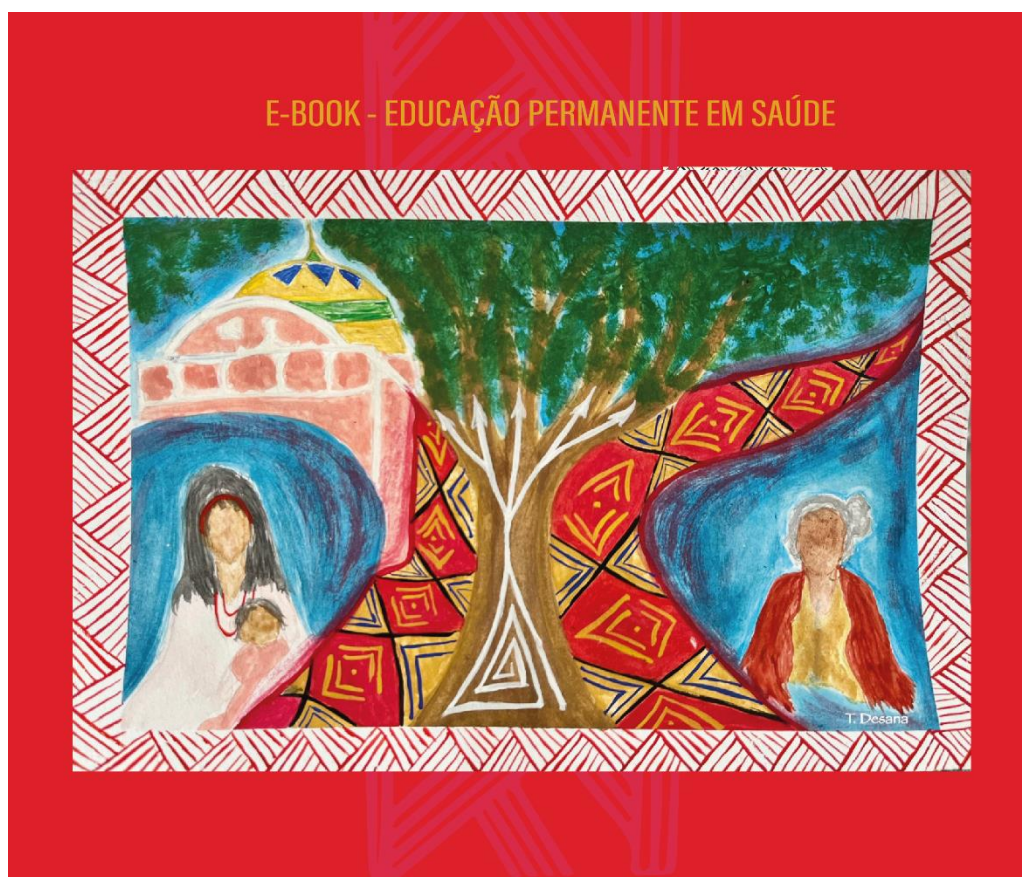
Comprometo-me apresentar o relatório final da pesquisa, e os resultados obtidos, quando do seu término ao Comitê de Ética – CEP-UFRGS e CONEP, via Plataforma Brasil como notificação.

Nome e Assinatura do (a) pesquisador (a)

Local e data

APÊNDICE G – PRODUTO *e-book*

Abaixo apresenta-se o produto desenvolvido mediante essa pesquisa. Para melhor legibilidade, acesse o link: <https://files.catbox.moe/vtftry.pdf>



Cuidado em Saúde da Mulher Indígena em Contexto Urbano: Diálogos com Atenção Primária à Saúde

Autores:

Dalva Nascimento Coimbra
Luiz Fernando Calage Alvarenga
Andre Petraglia Sassi



FICHA TÉCNICA

Título:

Cuidado em Saúde da Mulher Indígena em Contexto Urbano: Diálogos com a Atenção Primária à Saúde.

Tipo de produto :

E-Book educativo/formativo - produto técnico de dissertação de mestrado.

Ilustração da capa:

Thaís Sarmento Fernandes

Projeto gráfico e diagramação:

Fabiane Volkmer Grossmann

Tema:

Saúde das mulheres indígenas em contexto urbano; Atenção Primária à Saúde (APS); interculturalidade; articulações entre medicina indígena e APS.

Finalidade:

Subsidiar ações de educação permanente em saúde, contribuindo para a qualificação do cuidado intercultural, integral e territorializado às mulheres indígenas no âmbito da Atenção Primária à Saúde em contexto urbano.

Público de interesse:

Profissionais da Atenção Primária à Saúde; Agentes Indígenas de Saúde; estudantes e docentes da área da saúde; gestores do SUS; lideranças indígenas.

Vinculação acadêmica:

Produto vinculado ao projeto de dissertação de mestrado intitulado "O CUIDADO QUE NÃO SE APAGA: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE CUIDADO DAS MULHERES INDÍGENAS E SUA (IN)VISIBILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM CONTEXTO URBANO", desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde – Mestrado Profissional (PPGENSAU), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Disponibilização:

Formato digital (PDF), com acesso livre, por meio de repositório institucional e de ações formativas em saúde.

Autoria:

Dalva Nascimento Coimbra

Orientação:

Luiz Fernando Calage Alvarenga

Coorientador:

André Petraglia Sassi

NOTA SOBRE A CAPA

A capa representa o encontro intergeracional de mulheres indígenas em espaço urbano, simbolizando trocas de saberes sobre cuidado, memória e saúde da mulher indígena.

SUMÁRIO

Caminho trilhado: como este e-Book está organizado	
• Porque este e-book foi elaborado	07
• Justificativa da importância	10
• Objetivos do e-book	11
Capítulo 1 - Concepção de saúde e doença na cosmovisão indígena	18
1.1 - Saúde como equilíbrio	18
1.2 - Saúde e ciclos da vida da mulher indígena	20
1.3 - Percepção indígena do adoecimento	21
Capítulo 2 - Práticas e tecnologias da medicina indígena	23
2.1 - Práticas tradicionais de cuidado	25
2.2 - Mulheres como guardiãs do cuidado	25
2.3 - Adaptação das práticas no contexto urbano	26
Capítulo 3 - Interface entre os cuidados tradicionais e a Atenção Primária à Saúde	33
3.1 - Itinerários terapêuticos das mulheres indígenas	34
3.2 - Tensões entre biomedicina e medicina indígena	44
3.3 - Possibilidades para uma Atenção Primária Intercultural	50
Considerações finais	59
Referências	65



Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas.

Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós.



(KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 75).



04

DOS AUTORES

DALVA NASCIMENTO COIMBRA



Fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Possui especialização em Fisioterapia Pneumofuncional pela UEPA/PA, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ex-residente em Fisioterapia Neurofuncional pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD-SP). Atua na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) e

na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Sua trajetória na Atenção Primária à Saúde ampliou seu olhar sobre o cuidado, reconhecendo-o como um território potente de aprendizado, produção e compartilhamento de saberes em saúde. Acredita que os saberes tradicionais e ancestrais, dentre eles as medicinas indígenas têm contribuições fundamentais para o cuidado integral, intercultural e para a promoção do bem viver.

LUIZ FERNANDO CALAGE ALVARENGA

Fisioterapeuta, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre e Doutor em Educação pela UFRGS, professor do curso de Fisioterapia da UFRGS e dos programas de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da UFRGS

e de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Membro da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia - ABENFISIO.



ANDRE PETRAGLIA SASSI

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Médico de Família e Comunidade com Residência Médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição/SA. Especialista em Saúde Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente professor do Departamento de Medicina Social da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Curso de Medicina da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Sociologia pela UFPB. Doutor em Sociologia pela UFPB. Ex-Coordenador do Curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPE.



05



O QUE LEVOU À ELABORAÇÃO DESTA E-BOOK



Este e-book é um produto técnico derivado de uma dissertação de mestrado que teve como objetivo compreender a saúde da mulher indígena em contexto urbano a partir de suas próprias narrativas, saberes e experiências de cuidado. O material foi construído a partir da escuta atenta de mulheres indígenas residentes em Manaus, cujas trajetórias evidenciam a continuidade, a adaptação e a resistência das práticas tradicionais de cuidado fora dos territórios indígenas de origem.

Ao dar voz e visibilidade às mulheres indígenas e seus modos de produzir saúde, o material propõe-se como um canal de diálogo entre diferentes racionalidades de cuidado, mulheres indígenas e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), contribuindo para a construção de

práticas de cuidados mais integradas, interculturais e sensíveis à diversidade cultural.

Sua elaboração ocorreu de forma coletiva, envolvendo mulheres indígenas, pesquisadora e orientadores, comprometidos com a valorização da Medicina Indígena, a produção acadêmica situada e o fortalecimento das políticas públicas de saúde indígena em contexto urbano.

Destinado à educação permanente de profissionais da APS, o e-book oferece subsídios para o reconhecimento dos saberes tradicionais como parte legítima do cuidado, fortalecendo vínculos, qualificando a atenção, promovendo a integralidade da saúde da mulher indígena em contexto urbano e reafirmando que a saúde integral se produz no encontro respeitoso entre saberes.

As narrativas apresentadas neste e-book, assim como na dissertação que lhe deu origem, são identificadas por denominações fictícias, definidas pela pesquisadora com o objetivo de preservar a identidade das participantes e assegurar o sigilo das informações, conforme os princípios éticos da pesquisa.

As denominações utilizadas foram inspiradas nas comunidades, associações de pertencimento e em elementos do cotidiano e da natureza relacionados às práticas de cuidado e modos de vida das mulheres indígenas.

As imagens que compõem o material pertencem ao acervo pessoal da pesquisadora, incluem ilustrações produzidas pela artista do povo Dessana Thais Sarmento Fernandes, com autorização para publicação, e pela designer Fabiane Volkmer Grossmann, assim como imagens de acesso público disponíveis em mídias digitais.



08

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA

A APS é, em grande parte, o primeiro e principal espaço de contato institucional entre as mulheres indígenas e o Sistema Único de Saúde. Entretanto, quando os serviços de saúde operam exclusivamente sob a lógica biomédica, desconsiderando as cosmologias indígenas e os saberes tradicionais, produzem-se incompreensões, constrangimentos e, muitas vezes, a ruptura do cuidado.

ramenta de apoio à prática profissional, voltada ao fortalecimento de uma atenção intercultural, ética e integral, capaz de reconhecer as mulheres indígenas como protagonistas de seus processos de cuidado e de articular as tecnologias de cuidados da Medicina Indígena com a assistência ofertada no cotidiano dos serviços de saúde, especialmente a APS.

Este e-book justifica-se, portanto, como uma fer-



(BRASIL, 2018; FREITAS; VILELA; NWORA, 2023; FARIAS ET AL., 2023)

09

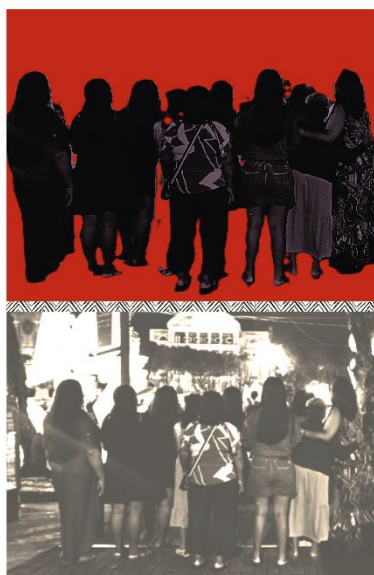
PARA QUEM FOI FEITO

Este e-Book foi elaborado como material educativo e formativo para profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), estudantes e gestores que atuam em contextos urbanos com presença de povos indígenas.

A elaboração deste e-Book responde à necessidade de qualificar a educação permanente dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), oferecendo subsídios teóricos e práticos para a compreensão das concepções indígenas de saúde e doença e das práticas de cuidado mobilizadas pelas mulheres indígenas no cotidiano urbano.



10





CONTEXTO URBANO E SAÚDE INDÍGENA: os sons invisíveis das mulheres indígenas

A presença indígena nas cidades brasileiras não é recente, mas ainda é marcada por invisibilidade, preconceito e dificuldades de acesso a políticas públicas.

Em Manaus, a capital brasileira com maior população indígena em contexto urbano, com 71.713 indígenas autodeclarados, 38.127 mulheres indígenas vivem em diferentes bairros, mantendo redes familiares, culturais e de cuidado que atravessam o espaço urbano.

No cotidiano da APS, essas mulheres acessam os serviços de saúde, mas continuam mobilizando práticas indígenas de cuidado, aprendidas com mães, avós e lideranças, produzindo formas próprias de atenção à saúde.

Essa realidade evidencia que a vida na cidade não rompe os vínculos com as práticas indígenas de cuidado à saúde; mas produz novos arranjos e adaptações, nos quais os saberes tradicionais continuam a orientar as decisões sobre o cuidado.

(IBGE, 2022; ROMERO et al, 2023; DIEHL; LANGDON, 2007)

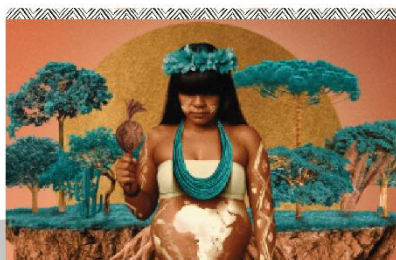
12

AS MULHERES CORPOS-TERRITÓRIOS E SEU PROTAGONISMO NA CAPITAL MAIS INDÍGENA

No contexto indígena, a noção de corpo-território, expressa a articulação entre a defesa dos corpos femininos e a defesa dos territórios, a indissociabilidade entre corpo individual, corpo coletivo e território, entendido como espaço de vida, memória, espiritualidade e reprodução social.

As mulheres ocupam centralidade nessa articulação, sendo protagonistas na defesa dos corpos, dos territórios e das formas de cuidar e viver.

(MIRANDA; BARROSO, 2023)



Fonte: ANMIGA (@anmigaorg, 2025)

13

AS MULHERES TERRITÓRIOS E SEU PROTAGONISMO NA CAPITAL MAIS INDÍGENA



Fonte: REDE MAKIRA-E'TA, s.d.

Em Manaus, mulheres indígenas organizadas em associações atuam na reivindicação de políticas afirmativas voltadas à saúde indígena e à atenção diferenciada no SUS, afirmando-se como agentes centrais na produção do cuidado e na valorização das práticas da medicina indígena.

O protagonismo feminino indígena é acompanhado por coragem, resiliência e liderança das mulheres em suas comunidades. Elas desempenham papéis centrais na preservação de saberes tradicionais, na transmissão intergeracional de conhecimentos e na organização comunitária, assumindo responsabilidades que desafiam estereótipos de gênero e estruturas históricas de poder.

Ao mesmo tempo, sua atuação contribui significativamente para a transformação social e cultural, consolidando a importância das mulheres na construção da identidade e na defesa dos direitos coletivos das comunidades indígenas.

(MIRANDA, 2020; MIRANDA; BARRHOSE, 2023; GARNELLO; SAMPAIO, 2003; FONTES, 2020)

14

TERRITÓRIOS DE CONHECIMENTOS: comunidades e associações indígenas de Manaus



PRQUE FALAR DISSO AGORA

As mulheres indígenas que moram na cidade não abandonam seus modos de cuidado ao acessar a APS. Elas combinam saberes, avaliam riscos e escolhem o que utilizar em cada situação.

Plantas medicinais, chás, banhos, benzimentos e cuidados corporais coexistem com exames, vacinas, consultas e medicamentos ofertados na APS.

Essas articulações não seguem uma lógica fixa, mas são construídas no cotidiano, conforme a experiência, a confiança e a necessidade.

Compreender esses percursos é fundamental para qualificar a atenção à saúde e fortalecer o vínculo entre usuários e serviços.

(ROMERO et al, 2023 ; DIEHL; LANGDON, 2007; GARNELO; PONTES, 2012)



16



Janela da memória, cura e proteção

A figura apresenta uma janela concebida como símbolo da memória da cura, do corpo, das plantas e das conversas entre mulheres em um grande encontro coletivo.

A janela é representada como um espaço de comunicação entre o mundo visível e o dos encantados, que observam e escutam, assim como são observados nos corpos, nas plantas e nos caminhos.

No centro, o olho do encantado funciona como metáfora da escuta das narrativas sobre memória, cura, corpo e saberes das mulheres mais velhas.

Os grafismos da Cobra Canoa, em vermelho, e da jararaca, em azul sobre o amarelo, aparecem na composição, enquanto a moldura reúne esses grafismos, simbolizando a geração da vida, a proteção e a força associadas ao corpo feminino e às mulheres reunidas.

Fonte: Ilustração e descrição produzidas por Thais Sarmiento Fernandes (povo Dessana), com edição da autora, a partir dos grupos focais desta pesquisa, 2025.

17

CAPÍTULO 1

Rede de vivências da saúde e do adoecimento: concepção de saúde e doença na cosmovisão indígena

1.1 - Saúde como equilíbrio

Para as mulheres indígenas, saúde não significa apenas ausência de doença. Trata-se de um estado de equilíbrio entre:



A doença surge quando esse equilíbrio é rompido, podendo envolver dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais.

(DIAS-SOPEL; SOPEL, 2019; BAGGIO et al, 2018; GARNELLO; SAMPAIO; PONTES, 2019; MANDUJÃO; GUIMARÃES, 2024; BARRETO, 2025; BANIVA, 2025.)

18



66

O meu corpo tem regras, então não posso sair por aí, por exemplo, quando estou menstruada, tomar banho de rio, ter contato com cachoeiras, com pedras porque estes lugares têm donos, donos da natureza que podem não gostar de estar sujando a casa deles com meu sangue...

(TUCUM)



O MANEJO CONJUNTO DO MUNDO: UMA OUTRA SAÚDE

Para os povos indígenas, saúde não se restringe à ausência de doença. Ela está relacionada ao equilíbrio entre corpo, território, relações sociais, espiritualidade e ambiente.

O cuidado envolve práticas preventivas, resguardos, alimentação, uso de plantas medicinais, benzimentos e respeito às regras que organizam a vida coletiva.

Mesmo em contexto urbano, essas concepções permanecem orientando as escolhas das mulheres indígenas sobre como e quando buscar cuidado.

(DIAS-SOPEL; SOPEL, 2019; BARRETO, 2025; BANIVA, 2025)



19

1.2- Saúde e ciclos da vida da mulher

Os ciclos femininos, menstruação, gestação, parto e pós-parto, são significativos na concepção indígena de saúde

Cada fase exige:

- cuidados específicos;
- resguardos corporais e alimentares;
- orientações transmitidas intergeracionalmente.

Esses cuidados não são vistos como restrições, mas como formas de proteção do corpo e da vida.

(BRASIL, 2018; BRASIL, 2024; BAGGIO et al, 2018; SCHWEICKARDT; BARRETO, 2023; BARRETO, 2025; BANINWA, 2025)

20

1.3 PERCEPÇÃO INDÍGENA DO ADOECIMENTO

O adoecimento é compreendido como uma experiência vivida e interpretada a partir da cultura e da cosmologia do povo.

Assim, a doença não se limita ao corpo biológico, mas envolve:

- relações sociais;
- conflitos morais;
- forças espirituais;
- vínculos com o território.

No contexto urbano, a saúde das mulheres indígenas é afetada pela ruptura dos vínculos com o território e a natureza, pela degradação ambiental, pela precariedade do saneamento e pela ausência de políticas públicas.

A substituição de alimentos tradicionais por produtos industrializados, somada à insegurança alimentar e ao acesso limitado à água potável, agrava as condições de saúde, especialmente entre mulheres e crianças.

(DIAS; SCOPEL; SCOPEL, 2019; BARRETO, 2025; BANINWA, 2025; GARNIELO; PONTES, 2012; FARIA et al, 2022; FREITAS et al, 2017; GARNIELO; SAMPAIO, PONTES, 2019)

21



“...Essa talvez seja uma relação de quem vive na cidade e tem muitas atividades e funções. Porque eu acho que a gente hoje vive dois vieses... um de mulheres que estão no território e outro nós que estamos fora do território, estamos na cidade, eu acho que a gente é tão influenciada pela sociedade, pelo branco que a gente esquece de onde viemos e de que mesmo estando nas cidades devemos seguir as regras e cultura do nosso povo. A gente esquece isso e então essas doenças mostram que você não se cuidou ou se tratou como deveria.

(CRAJIRU)



Compreender a saúde-doença como equilíbrio/desequilíbrio permite reconhecer que o cuidado se materializa em práticas concretas, transmitidas e atualizadas no cotidiano.

É nesse ponto que se tornam visíveis as tecnologias da medicina indígena, apresentadas no capítulo seguinte.



22



CAPÍTULO 2

2.1 - Práticas e tecnologias de cuidado da Medicina Indígena

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) reconhece que as práticas tradicionais constituem tecnologias de cuidado da medicina indígena, na medida em que são sistematizadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo de gerações, promovendo saúde, autonomia e bem viver a partir dos contextos socioculturais indígenas.

Nesse conjunto, destacam-se práticas amplamente mobilizadas no cotidiano das mulheres indígenas, tais como:

- uso de plantas medicinais (chás, banhos, garrafadas, inalação, defumação, etc);
- restrição alimentar;
- regras sociais, resguardos e rituais;
- orientações das mulheres mais velhas;
- acompanhamento por especialistas tradicionais: pajés, kumuns, parteiras, benzedeiras.

(BRASIL, 2018; BRASIL, 2024; BAGGIO et al, 2018; SCHWEICKARDT; BARRETO, 2023; BARRETO, 2025; BANIWA, 2025)



23



Para mim remédio caseiro faz parte de mim, da minha família, da minha essência, é onde vejo a cura.

(TUCUMÃ)



24



2.2 - MULHERES COMO GUARDIÃS DO CUIDADO

As mulheres ocupam o eixo fundamental na transmissão dos saberes de cuidado.

Avós, mães e tias ensinam por meio de:

- observação;
- convivência cotidiana;
- conselhos;
- participação nos rituais.



Esses saberes sustentam o cuidado com a saúde da mulher, das crianças e da coletividade.

O cuidado com o corpo e a preservação da saúde das mulheres indígenas estão profundamente marcados por silenciamentos, esses conhecimentos não deixam de ser vividos e transmitidos, sobretudo por meio da oralidade e das práticas cotidianas, muitas vezes no espaço doméstico, inclusive em contextos urbanos.

Mantêm-se como prática de resistência frente às violências históricas do processo colonizatório.

(RAMOS, 2022; AURIORA, 2019; BANIWA, 2018; FONTES, 2020; OLIVEIRA et al., 2023; BARRETO, 2025)



25



2.3 - ADAPTAÇÃO DAS PRÁTICAS NO CONTEXTO URBANO

Mesmo vivendo na cidade, as práticas são mantidas e adaptadas por meio de:

- cultivo de plantas em vasos e pequenos quintais; 
- compra em mercados especializados; 
- recebimento de plantas do interior; 
- realização de cuidados no espaço doméstico e em espaços na cidade com essa finalidade. 

Essas estratégias expressam resistência cultural e continuidade dos modos indígenas de cuidar. Os espaços habitados pelas indígenas na cidade são produzidos a partir dos usos do lugar e dos sentidos a ele atribuídos, expressos em práticas como a pintura corporal, os cantos, o aprendizado da língua, a produção de artesanato e as práticas agrícolas e alimentares compartilhadas por múltiplas etnias em contexto urbano. Essas estratégias expressam resistência cultural e continuidade dos modos indígenas de cuidar.



(ALCIPAK, 2019; PULHANA, 2022; SHIMIZU, 2025)



26



MEDICINA INDÍGENA Tecnologias de cuidado: plantas medicinais



“

...Também podemos fazer banhos, assentos com plantas medicinais e também chás para tomar. Tomamos banho com as folhas de saratudo e com a casca fazemos o chá...

(WARÁ)

”

“

...pegava uma plantinha, fazia um chá, usava algumas folhas, ela fazia a reza dela ali, uma plantinha, fazia um banho.

(CRAJIRU)

”

(BRASIL, 2004; BARRETO, 2025; BANWIA, 2025)



27

MEDICINA INDÍGENA

Tecnologias de cuidado: transmissão intergeracional

“

Aprendi esses cuidados com minha avó, minha mãe e tias paternas. Esses ensinamentos são feitos principalmente através da oralidade e também conforme fui crescendo, através da prática, fui observando e depois praticando.

(Centro de Medicina Indígena)

”



Fonte: BANWA, KANGANG; MANDUJO (2023).

“

“...na verdade a mulher tem uma grande responsabilidade, ela que dá continuidade desses conhecimentos para os mais novos...não apenas os conselhos porque para nós indígenas é muito mais a prática, as formas, as atitudes, as ações...”

(COPAÍBA)

”

(BRASIL, 2024; SARRETO, 2025; BANWA 2025)

28

MEDICINA INDÍGENA

Tecnologias de cuidado: acompanhamento com especialistas

“

...tem que passar no acompanhamento das mulheres especialistas... os homens que são kumuns que tratam em outra categoria, não tocando no corpo da mulher, diferente da especialista mulher, a mulher toca no nosso corpo, faz perguntas mais íntimas... o homem age com as práticas de basesé...

(TUCUM)

”

“

...na nossa cultura quem cuida da saúde são os homens, fazem basesé (benzimento) utilizando cigarro e opê (breu branco) durante a gravidez e no parto...

(ÔPÉ)

”



Fonte: PIANI Eduardo Queiroga, 2019

29

MEDICINA INDÍGENA

Tecnologias de cuidado: regras sociais e resguardos

“...são tecnologias de cuidado: tecnologia para fazer sua comida, tecnologias para cuidar da roça. Para isso, existem padrões de comportamento que precisamos seguir, pois eles também têm conexão com a nossa saúde; se não seguirmos esses padrões, o nosso corpo pode adoecer.”
(TUCUM)



Ilustração: Jemaruwa Wajaji | Fonte: Instituto Socioambiental (ISA)

“..Na menstruação eu tive resguardo, não se pode ficar muito tempo com a barriga molhada, no frio porque depois pode desenvolver uma doença chamada de mãe do corpo. Que é uma dor que a mulher sente, fortes dores, muito pior que uma cólica, é muito mais que isso...”
(SARATUDO)

(BRASIL, 2024; BARRIETO, 2025; BANINWA 2025)

30

MEDICINA INDÍGENA

Tecnologias de cuidado: restrição alimentar

“...até três meses de gestação não se pode comer determinados alimentos, não podemos comer determinadas caças senão pode gerar alguma malformação, ou características do animal ao filho, tipo jabuti. A rã é muito usada na nossa cultura, é muito boa...”
(WARÁ)



Fonte: BANINWA; KANGANG, MANDULÃO (2023).

“...também não devemos comer determinadas comidas durante a menstruação como alimentos com muita acidez, peixes remosos...”
(COPAÍBA)

31



Ao manterem essas práticas, as mulheres indígenas constroem percursos de cuidado que não se restringem à medicina indígena nem à assistência prestada no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Esses percursos se encontram, tensionam-se e dialogam no cotidiano da APS, temática que será aprofundada no próximo capítulo.



Fonte: BARIWA; KANGANG; MANJOLUÃO (2023).



“...a gente sempre começa a cuidar com nossa medicina, com chás e quando não resolve, caso precisa de um tratamento mais específico procuramos as unidades de saúde...”

(MANIVA)



32



CAPÍTULO 3

Interface entre os cuidados tradicionais e a Atenção à Saúde Primária

3.1 - Itinerários terapêuticos:

dois sistemas de cuidado em diálogo.

As mulheres indígenas utilizam simultaneamente:



Esse percurso constitui seus itinerários terapêuticos, que não se restringem ao espaço institucional.

(BAGGIO et al, 2018; GARDELLA, 2024; FARIAS et al, 2023; GARNELO; PONTES, 2012)



33

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS

Os itinerários terapêuticos das mulheres indígenas não se limitam aos serviços de saúde. O cuidado começa em casa, na família e na comunidade, e só em alguns casos chega à UBS ou a outros níveis do SUS.

Esses percursos revelam que o cuidado é resultado de escolhas situadas, influenciadas por vínculos culturais, experiências anteriores com os serviços e pela forma como são tratadas nos atendimentos.

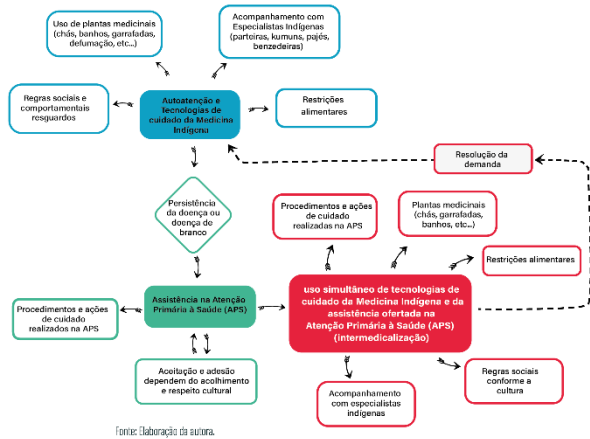


“...Agora em relação a doenças como gripes, a gente não vai na UBS, a minha mãe faz os remédios com as plantas medicinais que ela aprendeu, então em situações de gripe não vamos na UBS, a gente trata na comunidade com nossos remédios...”

(ANDIROBA)

(BARREIRO, PONTES, 2012; FREITAS, VILELA, INYORA, 2023)

MODELO EXPLICATIVO DOS ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS da Mulher Indígena em Contexto Urbano



Itinerários terapêuticos da mulher indígena em contexto urbano

O esquema representa os itinerários terapêuticos das mulheres indígenas em Manaus, iniciados pela autoatenção baseada na Medicina Indígena e, quando necessário, articulados à Atenção Primária à Saúde.

Evidencia-se o uso concomitante de práticas tradicionais e de cuidados realizados no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), configurando processos de intermedicização, cuja continuidade depende do acolhimento, do respeito às práticas culturais e da construção do vínculo terapêutico, fundamentais para a promoção da saúde integral.

O início do início do caminho: Autoatenção e tecnologias da Medicina Indígena

Os itinerários terapêuticos das mulheres indígenas que residem em Manaus têm início, predominantemente, na autoatenção, entendida como o conjunto de práticas de cuidado mobilizadas no âmbito familiar e comunitário.

Essas práticas baseiam-se nos saberes da medicina indígena e incluem o uso de plantas medicinais (chás, banhos, xaropes, garra-

fadas, defumações), a observância de resguardos corporais, alimentares e comportamentais e o acompanhamento por especialistas indígenas, como parteiras, pajés, kumuns e benzedeiras.

A autoatenção expressa autonomia, prevenção e proteção, articulando corpo, território, relações sociais e espiritualidade.

(MCHÉNUEZ, 2003, 2009; BARBOSA, 2021)



36

CUIDANDO DO CORPO-TERRITÓRIO: Especificidades e proteção

Nos cuidados relacionados ao corpo feminino, como menstruação, gestação, parto e pós-parto, observa-se, com frequência, a priorização das práticas tradicionais.

Muitas mulheres relatam o adiamento ou a recusa inicial da busca pelos serviços da APS, motivadas por concepções culturais segundo as quais esses cuidados devem ser conduzidos por outras mulheres, bem como por experiências anteriores de constrangimento, vergonha ou desrespeito nos serviços de saúde.

Essas vivências impactam diretamente o vínculo com a APS.

(DUJONNI; BARBA, 2025)

Fonte: IPHAN/Eduardo Queiroga, 2019.



37

OUTROS CAMINHOS A PERCORRER: Reconhecimento das "doenças de branco"

A Atenção Primária à Saúde passa a ser acionada com maior frequência quando as práticas tradicionais não produzem a resolução esperada do adoecimento ou quando se trata das chamadas "doenças de branco", como gripes, infecções, necessidade de

exames, cirurgias ou procedimentos considerados invasivos. Nesses casos, a APS é reconhecida como espaço necessário para acesso a medicamentos, exames diagnósticos e intervenções clínicas.

(BRASIL, 2012; AHMADPOUR et al., 2020)

QUANDO OS CAMINHOS SE ENCONTRAM: APS INTERCULTURAL Territórios possíveis de cuidado

A saúde integral das mulheres indígenas não se produz pela substituição da medicina indígena pelos cuidados realizados na APS, mas pela construção de territórios possíveis de cuidado, nos quais diferentes racionalidades coexistem. Uma APS orientada por princípios interculturais pode atuar como espaço

estratégico de articulação entre sistemas de cuidado, contribuindo para a redução de iniquidades, o fortalecimento da autonomia das mulheres indígenas e a efetivação de práticas culturalmente sensíveis, contínuas e integrais.

(LANGDON; GARNHEIL, 2017; DUMONT; BARBA, 2025; BARBOSA, 2021)

38

INTERCAMINHOS...INTERMEDICALIZAÇÃO Uso simultâneo de sistemas de cuidado

Mesmo após o ingresso nas ações de cuidado da APS, as mulheres indígenas mantêm o uso concomitante das práticas da medicina indígena ao longo de seus itinerários terapêuticos. Medicamentos prescritos convivem com chás, banhos, garrafadas, defumações, benzimentos e resguardos, configurando um

processo de intermedicalização. Esse processo não é uma fusão harmônica entre sistemas, mas uma articulação negociada, construída no cotidiano do cuidado, conforme as percepções das mulheres sobre o corpo e a eficácia das práticas.

(ROMERO et al., 2023; DUTRA; LANGDON, 2007; GARNHEIL; PONTES, 2012)



PAPEL DO SISTEMA DOS NÃO INDÍGENAS: Escuta, vínculo e respeito

A permanência das mulheres indígenas na assistência da atenção primária depende fortemente da postura dos profissionais da APS, sendo a escuta qualificada, o acolhimento respeitoso e o reconhecimento das práticas tradicionais

como legítimas ampliam a adesão ao cuidado e fortalecem o vínculo terapêutico. Abordagens que desqualificam os saberes indígenas tendem a produzir abandono do tratamento e ruptura do cuidado.

(LANGDON; GARNHEIL, 2017; BARBOSA, 2021; DUMONT; BARBA, 2025)

39



O RIO DO CUIDADO: Itinerários Terapêuticos

Este infográfico explora os itinerários terapêuticos das mulheres indígenas em contextos urbanos, utilizando o rio como metáfora para suas jornadas de cuidado e saúde.

1. A Nascente

O início da jornada de cuidado, representando as raízes culturais, onde as tradições indígenas se conectam com os contextos urbanos:

- > Saberes ancestrais
- > Ensinamentos das mães e avós
- > Práticas de autocuidado
- > Chás, banhos, resguardos

➤ A saúde nasce no território, na família e na memória.



2. Corredeiras

Superação de desafios na busca por saúde e bem-estar. Tensões no percurso.

- Racismo Institucional <
- Preconceito <
- Barreiras linguísticas <
- Padronização biomédica <

As corredeiras podem dificultar o acesso e o vínculo



Fonte: Elaboração da autora.

3. Encontro das Águas

A integração entre Medicina Indígena e APS para um cuidado integral e único.

Intermedicinalidade:

- > O uso concomitante das práticas indígenas e a assistência ofertada pela APS.
- > Escolhas situadas
- > Negociação entre saberes

➤ Não é substituição, é articulação.

Afluente 1: Plantas medicinais, especialistas tradicionais e cuidados do próprio corpo.

Afluente 2: Biomedicina/APS/UBS, vacinas, exames, saúde da mulher.

➤ Os saberes se encontram, não se anulam



4. Margens do Rio

Mediação do cuidado, Escuta qualificada, Diálogo intercultural, Agente Indígena da Saúde.

As margens sustentam o percurso



5. Foz do Rio

A união de saberes e a celebração da saúde coletiva na vida urbana das mulheres indígenas. Acolhimento e comunidade. Onde o cuidado chega

- > Alívio do sofrimento
- > Autonomia das mulheres
- > Continuidade dos saberes
- > Bem viver

➤ Quando há respeito, o cuidado alcança seu destino



OS ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DAS MULHERES INDÍGENAS COMO UM RIO: NASCEM NA ANCESTRALIDADE, ATRAVESSAM ENCONTROS E DESAFIOS, E PRODUZEM CUIDADO QUANDO ENCONTRAM ESCUTA E RESPEITO NA APS.

(RUMELO et al. 2023, MEHL; LANGDON, 2007; GARNELO-PONTES, 2012; DUMONT; BARRA, 2025)



Práticas no cotidiano da APS

“

...as práticas, chás ...na UBS pedem para não tomar... quando se fala dessa negação, se nega isso, é negar o que é a sua essência, aquilo que você cresceu, viu, como se aquilo ali fosse uma mentira, uma farsa...”

(TUCUMÃ)

”



“

... eu nunca falei que uso as minhas plantas porque os médicos não acreditam, falam que não presta e que não é bom e não funciona... fico quietinha tomando... continuo usando os meus remédios caseiros e às vezes até páro o tratamento da UBS pelo que falam do meu tratamento com plantas. Nunca nenhum profissional da UBS falou ou me orientou sobre a minha medicina, sobre o uso de chás.”

(SARATUDO)

”

(BRASIL, 2024; SARATUDO, 2025; BARBOSA, 2025)

42

PRÁTICAS NO COTIDIANO DA APS

Exemplos do que acontece no atendimento

“

O que passei foi preconceito, porque muitas vezes, o profissional acha que o indígena não sente dor, ele acha que tem que voltar para o mato para poder fazer o que tem que fazer ali...”

(COMUNIDADE WOTCHIMAUCU)

”



Fonte: AGÊNCIA ACRÉVILIANA QUEIROZ, 2021

“

... porque nós indígenas sempre somos questionados em relação a isso. Sempre tem que estar com a carteirinha para dizer que é indígena, tem que tá com cabelo comprido, com cocar de pena, cabelo liso, se eu não tiver cabelo liso e tiver cabelo enrolado, pior ainda...

(TUCUMÃ)

”

43

3.2 - Tensões entre APS e Medicina Indígena

Quando o diálogo não acontece, a desvalorização das práticas tradicionais pelos serviços de saúde pode gerar:

- constrangimento;
- rompimento do vínculo;
- abandono do tratamento;
- sofrimento moral.

Isso ocorre quando os saberes indígenas são entendidos como atraso ou superstição.

para
refletir

Que práticas de cuidado as mulheres indígenas já trazem quando chegam à UBS?
Esses saberes são reconhecidos no atendimento?

(LANGDON; GARVIELO, 2017; BARROSA, 2021; DUMONT; SARRA, 2025)

44



(Fonte: @yacamã (2020))

... a minha prima foi se consultar na UBS, e ela é assim: ruiva, gosta de usar muitas jóias, quando ela foi se identificar como indígena, a mulher falou assim: tu quer me enganar?... e ela respondeu: não moça, sou indígena... e a mulher disse na cara dela: esses índios de agora... acabou que ela nem teve mais ação e foi embora, nem consultou mais.

(TUCUMÃ)

45

PRÁTICAS NO COTIDIANO DA APS

Onde surgem conflitos

Entre os principais desafios observados no cuidado às mulheres indígenas na APS, destacam-se:

- Desvalorização das práticas indígenas de cuidado;
- Racismo institucional e silenciamento de saberes;
- Barreiras de comunicação e ausência de intérpretes;
- Abordagens verticalizadas que dificultam a adesão ao cuidado.

(LANGSTON; GARINHO, 2017; BARBOSA, 2021; DUMONT; BARRA, 2025)



46

UM LUGAR PARA PENSAR



Kumorô, banco tradicional do povo tukano, símbolo de estabilidade e sabedoria.

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2006)

47



"Como escuto as mulheres indígenas no atendimento?"

"Que práticas de cuidado as mulheres indígenas já trazem quando chegam à UBS?"

"O que deslegítimo sem perceber?"

De que forma meu modo de atender favorece ou afasta o cuidado?



48



“

...na Covid o que garantiu as nossas vidas foram as práticas tradicionais, que praticamente ficamos desassistidos da medicina ocidental. Então foi o chá, foi a pomada, foi o benzimento, foi isso que nos salvou! Nós nos unimos!...”

(COPAÍBA)

”



49

3.3 - Possibilidades de uma Atenção Primária à Saúde Intercultural

Uma Atenção Primária à Saúde (APS) intercultural se constrói a partir do reconhecimento da diversidade sociocultural e dos modos indígenas de produzir cuidado. No cotidiano dos serviços, isso implica:

- Reconhecimento da Medicina Indígena e de suas tecnologias de cuidado como práticas legítimas de produção da saúde;
- Compreensão do cuidado como relacional e coletivo, articulado às redes familiares, comunitárias e territoriais;
- Escuta qualificada e sem julgamento, fortalecendo o vínculo entre profissionais e usuárias;
- Respeito à cultura e aos modos de vida indígenas, favorecendo maior adesão ao cuidado;
- Mediação cultural e linguística, qualificando a comunicação e o acesso aos serviços;
- Educação permanente dos profissionais de saúde, desde a recepção até as equipes multiprofissionais, com enfoque intercultural;
- Valorização do protagonismo das mulheres indígenas, reconhecendo seus saberes, práticas e papel central na produção do cuidado.

(VIRAS et al., 2025; LANGSDON; GARNETT, 2017; DUMONT; BARRA, 2025; LORRHUET, 2018; FREITAS; VILHA; VIVORA, 2023; CASTRO et al., 2025; FREITAS; VIEIRA; VIVORA, 2023; CASTRO et al., 2025)

INTER-RELAÇÃO ENTRE A ASSISTÊNCIA NA APS E A SAÚDE DA MULHER INDÍGENA

Problemas Identificados na APS	Impactos na saúde da mulher indígena	Caminhos possíveis na APS
Fragilidades na comunicação (ausência de escuta qualificada, linguagem técnica excessiva, desconhecimento das formas indígenas de expressar o adoecimento)	Dificuldade de vínculo com a equipe; incompreensão das queixas; sensação de desrespeito; adiamento ou abandono do cuidado.	Fortalecer a escuta qualificada; adaptar a linguagem; respeitar os tempos da fala; validar a narrativa da mulher como parte do cuidado.
Não reconhecimento dos saberes tradicionais (uso de plantas medicinais, resguardos, benzimentos desqualificados como "crendices")	Silenciamento dos saberes; uso oculto de práticas tradicionais; conflitos terapêuticos; baixa adesão ao tratamento biomédico.	Reconhecer os saberes indígenas como legítimos; perguntar sobre práticas de cuidado sem julgamento; dialogar sobre uso concomitante de terapias.
Barreiras institucionais (protocolos rígidos, racismo institucional, ausência de abordagem intercultural e mediação cultural)	Fragmentação do cuidado; interrupção dos itinerários terapêuticos; aumento das iniquidades e vulnerabilidades em saúde.	Promover práticas interculturais; flexibilizar fluxos quando possível; investir em educação permanente; articular com agentes indígenas e lideranças comunitárias.

Fonte: Elaboração da autora.

O quadro demonstra que os desafios da APS são sobretudo relacionais, culturais e institucionais, impactando a continuidade do cuidado, a autonomia das mulheres indígenas e a integralidade da atenção, cuja superação depende da articulação entre diferentes racionalidades de cuidado, fundamentada na escuta, no diálogo e no reconhecimento intercultural.

(LANGSDON; GARNETT, 2017; BAFIDICA, 2023; DUMONT; BARRA, 2025)



PARTILHAS DE SABERES

Caminhos possíveis: conhecimento intercultural

A essência do diálogo intercultural implica em saber silenciar e ouvir atentamente o que as pessoas participantes da pesquisa têm a dizer.

(VILHAS et al 2025)

52

ATENÇÃO DIFERENCIADA

A Atenção diferenciada, conforme a PNASPI, refere-se a uma forma de cuidado em saúde que reconhece e respeita as especificidades socioculturais, territoriais e linguísticas dos povos indígenas, articulando os serviços do SUS aos saberes e práticas tradicionais, com diálogo intercultural e garantia da integralidade e da equidade no cuidado.

No entanto, sua efetivação ainda é limitada, especialmente em contextos urbanos, onde padronizações institucionais dificultam o reconhecimento das especificidades socioculturais dos povos indígenas.

(LANGDON; GARNIELLO, 2017; BRASIL, 2018)

ATENÇÃO NA PRÁTICA

A ausência de sintomas não significa, necessariamente, saúde para as mulheres indígenas. Escutar como elas explicam seu sofrimento é fundamental.

53

66

...a gente foi percebendo por exemplo, que para que a gente possa garantir a continuidade da nossa existência a gente precisa dessas políticas diferenciadas principalmente no âmbito da saúde.

Para mim a saúde diferenciada é a que valoriza os conhecimentos ancestrais, que valoriza e reconhece os profissionais indígenas, a parteira, os pajés, a nossa medicina tradicional, então saúde diferenciada é todo um conjunto que é garantido na legislação, mas que infelizmente não é aplicada no dia a dia...

(COPAÍBA)



54

ASPECTOS DA ATENÇÃO DIFERENCIADA

Adequação da Organização da Atenção

Atenção às especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais, com adequação das formas ocidentais de organização dos serviços.

Qualificação para Atuação no Contexto Intercultural

Preparação dos profissionais de saúde para atuação em contexto intercultural e articulação com os sistemas tradicionais de saúde indígena.

Participação da Comunidade

Participação dos indígenas na formulação, gestão e execução do SASI-SUS para garantir a adequação e especificidade cultural.

(PONTES, REISB, GARNHEID, 2015)

Fonte: POCWIZ, s.d.



55



INTERCULTURALIDADE

A interculturalidade não significa misturar práticas ou impor saberes. Trata-se de reconhecer que diferentes racionalidades de cuidado coexistem e precisam dialogar em condições de respeito.

Em Manaus, onde convivem múltiplas etnias e línguas indígenas, a ausência de mediação linguística dificulta a comunicação nos serviços de saúde, fragiliza o vínculo e compromete a integralidade do cuidado.

A presença de intérpretes e mediadores culturais é fundamental para uma atenção mais equitativa.

NA ROTINA DA APS

Perguntar sobre o uso de chás, banhos ou plantas medicinais fortalece o vínculo e evita conflitos terapêuticos

(LORENZO, 2019; LANGDOFF, SAMPOLLO, 2017; WILLO, SANT'ANA, BASTOS E AYOUBO, 2021)

56

O PAPEL DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE

Os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) exercem papel fundamental na mediação entre as tecnologias de cuidado da Medicina Indígena e as práticas da Atenção Primária à Saúde.

Sua atuação facilita a comunicação, fortalece o vínculo e contribui para que as práticas indígenas sejam reconhecidas no cuidado em saúde.

Nos contextos urbanos, sua presença torna-se ainda mais importante diante das barreiras culturais, linguísticas e institucionais enfrentadas pelas mulheres indígenas.

(SAMPOLLO, SAMPOLLO e PONTES, 2019; D'EL e LANGDOFF, 2015)

BOAS PRÁTICAS

Reconhecer os saberes tradicionais não substitui a APS, mas amplia a integralidade do cuidado.

(Fonte: www.medicinaeintegracao.org.br, 2022)



57



Representação do corpo de uma mulher indígena configurado como um grande útero em forma de cuia, símbolo do espaço sagrado de preparo de remédios, folhas e sopros de cura. O grafismo da cobra canoa percorre o corpo até o útero, indicando proteção e geração da vida.

Os grafismos fazem referência ao feminino Dessana, às gravuras rupestres e à cerâmica, enquanto as folhas e raízes representam as ervas medicinais e a conexão entre corpo e terra.

Fonte: Ilustração e descrição produzidas por Thais Sarmiento Fernandes (povo Dessana), com edição da autora, a partir dos grupos focais e esta pesquisa, 2016.

WIKIPIEDIA: Imagem de uma mulher indígena do povo Dessana, com o corpo pintado de vermelho e preto.

58

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Garantir uma saúde diferenciada e intercultural não significa incorporar rituais aos serviços de saúde, mas respeitar e dialogar com os modos indígenas de produzir saúde, com seus saberes, experiências e formas de vida.

No contexto urbano, a Atenção Primária à Saúde ocupa posição estratégica nesse encontro, sendo fundamental reconhecer as práticas tradicionais das mulheres indígenas para promover um cuidado integral, equitativo e coerente com os princípios do SUS.

Fonte: ONU Mulheres Equador/Johns Alarcón, 2022.



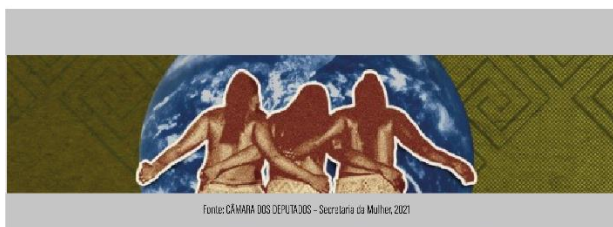
59

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este e-Book reafirma que os cuidados tradicionais das mulheres indígenas constituem sistemas complexos, preventivos e protetivos, que permanecem vivos mesmo fora dos territórios de origem.

Reconhecer esses saberes na APS fortalece a integralidade do cuidado, o respeito à diversidade cultural e a autonomia das mulheres indígenas, contribuindo para práticas mais sensíveis, dialógicas e interculturais.

Cuidar da saúde da mulher indígena exige, portanto, escuta qualificada, diálogo e reconhecimento de seus territórios, saberes e modos próprios de existir e cuidar, possibilitando a construção de uma atenção primária verdadeiramente intercultural.



60

Cuidar com interculturalidade é reconhecer que existem muitas formas legítimas de produzir saúde e que o diálogo entre saberes fortalece o cuidado.



61

Não há
cuidado integral
sem respeito à
cultura!



62

Não há saúde intercultural
sem reconhecimento das
tecnologias de cuidados da
Medicina Indígena.



63



Não há saúde
intercultural sem
reconhecimento das
mulheres indígenas
e seu direito à cidade.

64

REFERÊNCIAS

- AGRICOLA ACORF. Dia Nacional da Paralela: profissão de dedicação e amor. Fotografia de Juliana Queiroz, 20 jan. 2021. Disponível em: <<https://agencia.uol.com.br/dia-nacional-da-paralela-profissao-de-dedicacao-e-amor/>>. Acesso em: 03 fev. 2026.
- AMAGA (@gerenciagm). AMAGA COP 30. [Instagram]. 16 jul. 2025. Disponível em: <<https://www.instagram.com/AMAGA2025/>>. Acesso em: 29 jan. 2026.
- AUREO, R. A colonização sobre as mulheres indígenas: reflexões sobre cuidado com o corpo. *Revista de Estudos em Relações Interétnicas - Interétnica* (s.l.), v. 22, n. 1, p. 109-115, 2019. DOI: 10.26907/interétnica.v22i1.22530. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/interétnica/article/view/22530>>. Acesso em: 5 jan. 2026.
- BAGGIO, F.; BASCHARTO, V. F.; dos THOAS, A. C. P.; HOTTOR, T. V.; ATAMWA, M.; FRANKS, F. R. S. de. O cuidar da saúde para a mulher indígena. *Revista de Enfermagem UFPE On Line* Recife, v. 12, n. 3, p. 429-434, 2018. DOI: 10.5303/980.8553.v12n3.2018/29729734. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/22970>>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- BAWANA, A. Origens e desenvolvimento das práticas indígenas: tecnologias da cidade dos povos indígenas e formação de especialistas. Transcrição de fala apresentada no 3º Congresso Mundial de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas, Rio de Janeiro, 18 out. 2025. Revisado pelo autor em 21 out. 2025.
- BAWANA, R. A. Mulheres e território: reflexão sobre o que altera a vida das mulheres indígenas quando os direitos territoriais são ameaçados. *Vida e Saúde: Revista da Terra, v. 1, n. 1, p. 155-170*, 2018.
- BARRETO, L. P. L. O mundo em mim: uma terra indígena e os cuidados sobre o corpo no Alto Rio Negro. Brasília, DF: MÍFolhas, 2022. ISBN 978-65-87337-12-8.
- BARRETO, L. P. L. Tecnologias de cuidados nos territórios indígenas. Encontro no Centro de Medicina Indígena, Manaus, 2025.
- BAWANA, R.; KAMARIG, J.; MANDULAU, G. Mulheres: corpos-territórios indígenas em resistência! Organização: Kassiane Schwingel. Porto Alegre: Fundação Urupema de Ciência, Conselho da Missão entre Povos Indígenas, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF: 2017. Disponível em: <<http://aps.saude.gov.br>>. Acesso em: 14 dez. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – P-ASPI: a busca por uma vida e saúde nas comunidades indígenas. Documento orientador. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude>>. Acesso em: 20 nov. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Medicinas indígenas: tecnologias de cuidados em saúde e cura nos territórios indígenas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.mec.gov.br/sigil/publicar/189731807>>. Acesso em: 20 out. 2025.
- DA SILVA, R. L. P.; SOUZA, D. Promoção da saúde da mulher indígena: contribuição da etnografia das práticas de cuidados entre os Mundurucu do Estado do Amazonas, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 35, e00085918, 2019. DOI: 10.1590/0102-311X00085918. Acesso em: 4 nov. 2025.
- DE LIMA, L.; LANGDON, L. A. Transformações na etnografia da saúde indígena: tensões e negociações em um contexto indígena brasileiro. *Universitas Humanica*, Bogotá, n. 80, p. 213-236, jul. dez. 2015. DOI: 10.1144/averitas.UH80.040.
- DUMONT, F.; BARRETO, L. P. L. (coord.). Terro: guia de atenção ao pré-natal na Terra Indígena Yanomami. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2025. Projeto Focos de Cuidado na Terra Indígena Yanomami. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/items/67e9001e-dc6-4239-9415-23f83c3755a0>>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- FARF, L. F. et al. Povos indígenas: da negação da identidade e do território ao direito à terra no Amazonas. *Revista Brasileira de Geografia* (s.l.), v. 26, n. 2, p. 526-550, 2022. Disponível em: <<https://revistas.uem.br/index.php/revista-geografica/article/view/2563>>. Acesso em: 4 jan. 2026.
- FARF, A. S. de et al. Construindo um modelo explicativo para o entendimento do envolvimento por picada de cobra na Amazônia brasileira a partir da perspectiva dos cuidadores indígenas. *Plus Neglected Tropical Diseases*, v. 17, n. 3, e20072, 2023.
- FIDUCIA. Curso Gestante e DOW-18: Módulo 1 – Aula 2 [imagem]. Campus Virtual Focuz, s.d. Disponível em: <<https://mooc.campusvirtual.focuz.br/area/gestante-covid-19/assets/images/modulo1/aula2/banner2.jpg>>. Acesso em: 03 fev. 2026.
- FORTES, F. R. Minha escrivência, experiências vividas e diálogo com as mulheres indígenas do Rio Negro – Anauawos/Brasil. *Cadernos de Campo*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 179-186, 2020. DOI: 10.1016/j.cad.2019.03.029. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/766450>>. Acesso em: 11 nov. 2025.
- FRUTAS, M.; WIT, F. A.; MONTA, F. Religiosity and indigenous cosmology in a Brazilian hospital setting: the challenges faced by health professionals. *International Journal of Latin American Religions*, v. 2, p. 46-72, 2023. DOI: 10.1007/s40603-023-00094-w.

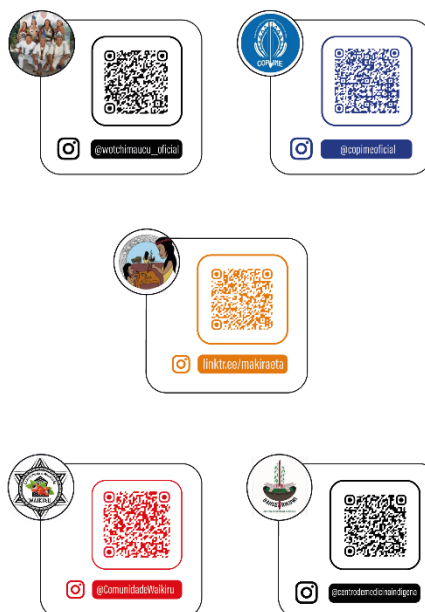
65

REFERÊNCIAS

- FRUTAS, M. A. et al. Quem são, o que falam e quem escuta os pobres? *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 3685-3692, dez. 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017221234857017.
- KIPPEMMA, D.; ALBERT, B. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução de Beatriz Perronne-Moiseis. Prefácio de Eduardo Viveiros de Castro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- BARRETO, Q. L.; SAMPAIO, S. Razes socioculturais do controle social em saúde indígena: problemas e questões na Região Norte do Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 31-52, 2002. DOI: 10.1590/S0103-97020020001000025.
- BARRETO, Q. L.; SAMPAIO, S.; DE S.; POMES, A. I. Atenção diferenciada: a formação técnica de agentes indígenas de saúde do Alto Rio Negro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2019. ISBN 978-85-7544-634-4.
- BARRETO, Q. L.; POMES, A. I. (org.). Saúde indígena: uma introdução ao tema. Brasília, DF: MEC/SECACT, UNFSCD, 2017. (Série Vias das Saberes, n. 5). ISBN 978-85-7594-063-7.
- GONZALEZ-VALENTE, A.; ANDREA TANIETI et al. La seguridad alimentaria y nutricional en una comunidad indígena de México. *Revista Española de Nutrición Comunitaria*, v. 25, n. 3, 2018.
- IPHAN. Parcerias tradicionais do Brasil. Fotografa de Eduardo Queiroz, 29 jul. 2018.
- Disponível em: <https://boichuan.gov.br/midias-registro/fotografia-parcerias-tradicionais-do-brasil-25>.
- Acesso em: 03 fev. 2026.
- INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil 2016. 2016. Editores gerais: Betu Ricardo; Fanny Ricardo. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2016. ISBN 85-05994-40-1.
- LAVOZON, E. L.; DIEHL, E. E. Participação e autonomia nos espaços interculturais de saúde indígena: reflexões a partir do sul do Brasil. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 19-36, 2007. DOI: 10.1590/S0104-12902007000200004.
- LAVOZON, E. L.; GARNELLO, L. Articulation between health services and "indigenous medicine": anthropological reflections on policies and reality in Brazil. *Health Collective*, v. 13, n. 3, p. 457, 2017.
- MAMUJIÃO, G.; GUIMARÃES, S. As medicina indígenas e os serviços de saúde: articulando a interculturalidade. In: D'AS SOUZA, R. et al. (org.). *Saúde indígena: abordagens antropológicas e epidemiológicas*. Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2004, p. 115-127.
- MENÉNDEZ, E. L. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones jurídicas y articulaciones prácticas. *Ciencia & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 185-207, 2003.
- MENÉNDEZ, E. L. Actualización de los padecimientos y algunos imaginarios antropológicos. *Desacatos*, n. 29, p. 161-176, 2009.
- ONU MULHERES. Tema deste ano é o papel das mulheres indígenas na conservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais. Nações Unidas, 9 ago. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/08/794972>. Acesso em: 05 fev. 2026.
- POMES, A. I.; DE M.; REGO, S.; GARNELLO, L. O modelo de atenção diferenciada nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas: reflexões a partir do Alto Rio Negro/AM, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 10, p. 3199-3210, 2015.
- SCHWEICORDT, J. C.; BARRETO, L. R. Triangos, destampas e caxos na dança e no canto: práticas da medicina indígena na Amazônia. Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2023. (Série Saúde & Amazônia, v. 26). ISBN 978-85-9462-186-0.
- TAPIMPE, K. O corpo e a pessoa entre os Apinês: resguardos, afetos para os espíritos e transição videntar. In: D'AS, L. O.; ALVAREZ, G. B. (org.). *Forças das ações afirmativas na antropologia social*. Goiânia: Cezar UFG, 2025, p. 109-196.
- VEIAS, L. de A. et al. Tradição e saúde: o uso de plantas medicinais por mulheres kaxóbo em Cuzco - Perú. *Cadernos Pedagógicos*, v. 22, n. 9, 2021, 2025. DOI: 10.54033/cadped22n9-243.
- WAPU Jemaveve. Resguardando do mapa (Ilustração). São Paulo: Instituto Socioambiental, s.d. Disponível em: https://img.socioambiental.org/67425531/resguardando-mo_a.jpg. Acesso em: 04 fev. 2026.
- YADUWATUNA, N. N. Somos racista. 2020. Publicação em rede social. Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/yacunduxa/?gsh=AMWtY2ZvP3JubWk2==. Acesso em: 31 jan. 2026.

66

PARA CONHECER MELHOR AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS DO ESTUDO, ACESSE OS QR CODES ABAIXO:



67

ANEXO A – PARECER CEP/UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADOS EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA EM CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Pesquisador: Luiz Fernando Calage Alvarenga

Área Temática: Estudos com populações indígenas;

Versão: 3

CAAE: 85623324.0.0000.5347

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.502.483

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento Informações Básicas da Pesquisa - PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2439209.pdf, versão 3, com data de 17/03/2025 e do "Projeto Detalhado", arquivo projetocorrigido2.docx de 14/03/2025.

TÍTULO

RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADOS EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA EM CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

INTRODUÇÃO

Este estudo surgiu a partir de vivências e encontros da pesquisadora no Centro de Medicina Indígena Bahserikowí, localizado em Manaus, onde concepções indígenas de cuidado do corpo são utilizadas e vivenciadas, assim como nas inúmeras ações como trabalhadora da Secretaria de Saúde do Município de Manaus em comunidades indígenas urbanas e bairro com predominância de moradores indígenas. A partir dessas experiências, longas conversas, trocas com os indígenas, usuários da atenção primária, constatouse relatos e sentimentos de

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.502.483

Outros	anuencia1.pdf	20/12/2024 23:22:52	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projetofinaldaiva.pdf	20/12/2024 23:18:31	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tclegrupofocal.docx	20/12/2024 23:18:19	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcleentrevista.docx	20/12/2024 23:18:10	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
Folha de Rosto	folharostoassinada.pdf	20/12/2024 22:23:57	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita apreciação da CONEP:

Sim

PORTO ALEGRE, 11 de Abril de 2025

Assinado por:
MARCIA HOLSBACH BELTRAME
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@gabinete.ufrgs.br

ANEXO B – PARECER CEP/CONEP

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA



PARECER CONSUBSTANCIADO DA CONEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: RACIONALIDADES E TECNOLOGIAS DE CUIDADOS EM SAÚDE DA MULHER INDÍGENA EM CONTEXTO URBANO: QUALIFICANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Pesquisador: Luiz Fernando Calage Alvarenga

Área Temática: Estudos com populações indígenas;

Versão: 4

CAAE: 85623324.0.0000.5347

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.754.147

Apresentação do Projeto:

As informações contidas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram obtidas dos documentos contendo as Informações Básicas sobre o Projeto de Pesquisa (PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2439209.pdf de 26/06/2025) e do Projeto Detalhado.

INTRODUÇÃO

Este estudo surgiu a partir de vivências e encontros da pesquisadora no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, localizado em Manaus, onde concepções indígenas de cuidado do corpo são utilizadas e vivenciadas, assim como nas inúmeras ações como trabalhadora da Secretaria de Saúde do Município de Manaus em comunidades indígenas urbanas e bairro com predominância de moradores indígenas. A partir dessas experiências, longas conversas, trocas com os indígenas, usuários da atenção primária, constatou-se relatos e sentimentos de invisibilidade do indivíduo indígena pelo fato de viverem na cidade, assim como a exclusão de direitos e a falta de justiça social no acesso aos serviços de saúde levando-se em conta a escuta diferenciada, a equidade, a integralidade, territorialidade, respeito aos seus costumes e tradições. Considerando esse contexto, a partir da experiência da pesquisadora na atuação na Atenção Primária à Saúde, foi possível evidenciar lacunas no cuidado, como: a insuficiência de

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 5º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 7.754.147

Justificativa de Ausência	tclegropofocal.docx	20/12/2024 23:18:19	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcleentrevista.docx	20/12/2024 23:18:10	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito
Folha de Rosto	folharostoassinada.pdf	20/12/2024 22:23:57	Luiz Fernando Calage Alvarenga	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

BRASILIA, 17 de Agosto de 2025

Assinado por:

Laís Alves de Souza Bonilha
(Coordenador(a))

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 5º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br